CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MÉDICA
DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



Diseño 2024- 2028

Actualizado a noviembre de 2024

Contenido

I. INTRODUCCIÓN 3

II. DISEÑO DE LA EPSS PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (PNA). 4

a. Aspectos generales. 4

b. Equipos técnicos consultados. 4

c. Inventario de indicadores de la EPSS del primer nivel de atención 2024-2028. 5

d. Intervenciones y Fichas técnicas. 8

III. DISEÑO DE LA EPSS PARA EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN (STNA) 9

a. Aspectos generales. 9

b. Inventario de indicadores de la EPSS del segundo y tercer nivel de atención 2024-2028. 9

c. Intervenciones y Fichas técnicas. 10

IV. ANEXO: INTERVENCIONES E INDICADORES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 11

01-SALUD MATERNO-INFANTIL 11

02-SALUD BUCODENTAL 33

03-SALUD DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 43

04-SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 71

05-ECNT: OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO 76

06-ECNT: DIABETES MELLITUS TIPO 2 96

07-ECNT: HIPERTENSIÓN ARTERIAL 105

09-ECNT: CÁNCER 115

11-EFICIENCIA PRODUCTIVA 128

V. ANEXO: INTERVENCIONES E INDICADORES DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN. 140

10-SÍNDROME CORONARIO AGUDO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 140

12-GESTIÓN HOSPITALARIA 163

I. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene los principales elementos del diseño de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS) de la Caja Costarricense de Seguro Social para el quinquenio 2024-2028, y representa una guía de todo el proceso metodológico seguido para su ejecución, con el propósito de resguardar la transparencia y objetividad de los resultados y recomendaciones que de ella se desprendan.

De acuerdo con el marco referencial de la EPSS 2024-2034, la EPSS consiste en una valoración sistemática de los resultados de las intervenciones estratégicas en salud contenidas en políticas, planes, programas y proyectos que la institución implementa en los establecimientos de salud; cuyos principales objetivos son aportar elementos para la mejora de la gestión, la toma de decisiones informadas, el aprendizaje y conocimiento, así como la rendición de cuentas.

Es importante mencionar que la EPSS tiene un horizonte quinquenal, no obstante, establece un seguimiento anual de las intervenciones en salud que, por su naturaleza, son continuas; por lo que propone un proceso anual de recolección de datos según indicadores y metas programadas, para verificar con ello lo realizado y sus resultados.

La etapa de diseño, como parte del proceso de evaluación, incluye como actividades principales: la definición de las intervenciones estratégicas a evaluar, según las principales temáticas que para este efecto se definan, la construcción de las fichas técnicas, tanto de indicadores de evaluación como de indicadores complementarios; además de la descripción de los respectivos procedimientos de recolección de datos.

Los indicadores de evaluación son aquellos para los cuales el diseño de la EPSS define una meta institucional quinquenal, mientras que los indicadores complementarios son aquellos que tienen como propósito apoyar el análisis de los resultados de los indicadores de evaluación o responder a una necesidad de información particular en el ámbito institucional o completar los requerimientos básicos para ser considerado un indicador de evaluación en el futuro.

Considerando lo anterior, este documento describe cada una de las intervenciones estratégicas en salud que conforman la EPSS 2024-2028, abarcando la definición de la necesidad o problema de salud que la intervención pretende atender, el objetivo y pregunta de evaluación, la evidencia científica que respalda los beneficios esperados, la identificación de barreras y estrategias para su implementación, la normativa técnica, así como aspectos de coordinación y consenso con el equipo técnico encargado del diseño de la intervención.

Asimismo, contiene las fichas técnicas de los indicadores que se utilizarán en la evaluación, que, entre otros, definen la población blanco, las variables del indicador y su fórmula de cálculo; además, plantean la línea base y la meta institucional para cada indicador de evaluación.

La presentación del diseño de la EPSS 2024-2028 se hace según dos grandes categorías, lo correspondiente a la evaluación del primer nivel de atención y lo relacionado con el segundo y tercer nivel, considerando las diferencias en la naturaleza de la prestación de servicios de salud en cada uno de ellos.

II. DISEÑO DE LA EPSS PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (PNA).

a. Aspectos generales.

El análisis de evaluabilidad realizado, dentro de la etapa de preparación, partió de la revisión diseño de la EPSS del primer nivel de atención correspondiente al quinquenio 2019-2023, por lo que la experiencia desarrollada por los evaluadores fue primordial para recoger las lecciones aprendidas, establecer las limitaciones y definir la evolución de los indicadores.

Se consideraron los lineamientos establecidos desde la coordinación general de la evaluación, en el sentido de construir indicadores cuyo procedimiento de recolección de datos fuese lo más automatizado posible, así como favorecer los indicadores cuya gestión de datos no dependiera de actores fuera de la Dirección Compra de Servicios de Salud.

Por otro lado, fue de vital importancia la valoración de las fuentes de datos disponibles, su nivel de accesibilidad, confiabilidad, homologación de registros, capacitación del nivel operativo y estabilidad en el tiempo.

Asimismo, se hizo una exhaustiva revisión de la nueva normativa emanada en relación con los programas de atención integral en salud del primer nivel de atención, además de las actualizaciones y modificaciones a la ya existente.

Se realizaron revisiones bibliográficas que permitieron identificar nueva evidencia científica acerca de los beneficios esperados de las intervenciones, lo que complementó el análisis llevado a cabo con los equipos técnicos y los consensos logrados con estos.

b. Equipos técnicos consultados.

Los equipos técnicos consultados en el proceso de preparación y diseño de la EPSS provienen de las siguientes instancias institucionales:

1. Dirección de Administración y Gestión de Personal.
2. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.
3. Dirección de Presupuesto.
4. Dirección de Proyección de Servicios de Salud.
5. Subárea de Vigilancia Epidemiológica.
6. Coordinación Nacional de Enfermería.
7. Coordinación Nacional de Nutrición.
8. Coordinación Nacional de Odontología.
9. Coordinación Técnica del Cáncer.
10. Programa de Normalización de la Atención de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles.
11. Programa de Normalización de la Atención de las Infecciones de Transmisión Sexual.
12. Programa de Normalización de la Atención a la Mujer.
13. Programa de Normalización de la Atención al Niño y la Niña.
14. Programa Normalización de la Atención a la Persona Adulta Mayor
15. Supervisores de Odontología de Direcciones de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud.
16. Comisión Gerencial de Maternidades.
17. Equipo de REDES de Área de Salud de Cartago.

c. Inventario de indicadores de la EPSS del primer nivel de atención 2024-2028.

INVENTARIO DE INDICADORES DE LA EPSS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 2024-2028			
01. TEMÁTICA: SALUD MATERNO INFANTIL			
Intervención estratégica: *Atención en salud materno infantil*			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
01-01-1.0 Cobertura de atención temprana de menores de un año	Prevención	Proceso	Acceso
01-02-2.0 Cobertura de atención temprana de mujeres en periodo posnatal	Prevención	Proceso	Acceso
01-03-1.0 Cobertura de atención temprana de embarazadas	Prevención	Proceso	Acceso
01-04-2.0 Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional	Prevención	Proceso	Continuidad
01-05-2.0 Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado	Prevención / Tratamiento	Proceso	Continuidad
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
-Porcentaje de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno (V-1.0)			01-01-1.0
-Porcentaje de muestras insatisfactorias para el tamizaje neonatal (V-1.0)			01-01-1.0
-Tiempo de tránsito promedio de las muestras para tamizaje neonatal (V-1.0)			01-01-1.0
-Porcentaje de mujeres en periodo posnatal a quienes se les registra la fecha del parto actual en el apartado correspondiente y la consulta de primera vez se da entre los 0 y 42 días del parto (V-2.0)			01-02-2.0
-Porcentaje de embarazadas a quienes se les registra la fecha de última regla actual en el apartado correspondiente y la consulta de primera vez se da entre una y 42 semanas de gestación (V-2.0)			01-03-1.0 01-04-2.0
-Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones correspondiente según grupo. (V-2.0)			01-04-2.0
02. TEMÁTICA: SALUD BUCODENTAL			
Intervención estratégica: *Atención en salud bucodental*			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
02-01-1.0 Cobertura de atención en salud oral a las personas de 20 a 64 años	Preventivo	Proceso	Acceso
02-02-1.0 Cobertura de atención en salud oral a las personas de 65 años y más	Preventivo	Proceso	Acceso
02-03-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral en las que se brinda educación en salud oral, preventiva por grupo de edad 0 a 9 años	Preventivo	Proceso	Acceso
02-04-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral en las que se brinda educación en salud oral, preventiva por grupo de edad 10 a 19 años	Preventivo	Proceso	Acceso
02-05-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral en las que se brinda educación en salud oral, preventiva por grupo de edad 20 a 64 años	Preventivo	Proceso	Acceso
02-06-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral en las que se brinda educación en salud oral, preventiva por grupo de edad 65 y más años	Preventivo	Proceso	Acceso
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
-Índice Pérdida Bucodental (IPBD) (V-1.0)			02-01-1.0 al 02-06-1.0
-Índice de Salud Bucodental (ISBD) (V-1.0)			02-01-1.0 al 02-06-1.0
-Índice de Riesgo Bucodental (IRBD) (V-1.0)			02-01-1.0 al 02-06-1.0
03. TEMÁTICA: SALUD DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			
Intervención estratégica: *Prevención de los efectos de la anemia por deficiencia de hierro en la población infantil*			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:

03-01-2.0 Tamizaje oportuno para la anemia por deficiencia de hierro de la población de seis a menos de 10 meses	Prevención	Proceso	Acceso
03-02-1.0 Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro resuelta	Prevención / Tratamiento	Resultado	Efectividad
03-03-2.0 Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro resuelta	Prevención / Tratamiento	Resultado	Efectividad
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
-*Porcentaje de la población de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno con resultado de hemoglobina < 11g/dL y sin diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro (V-2.0)*			03-01-2.0
-*Proporción de la población de seis a menos de 10 meses con anemia (V-2.0)*			03-01-2.0
-*Porcentaje de población de 6 a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemograma de control oportuno (V-1.0)*			03-02-1.0
-*Porcentaje de población de 6 a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico < 11g/dL y en el rango de edad (V-1.0)*			03-02-1.0
-*Porcentaje niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de control oportuna (V-2.0)*			03-03-2.0
-*Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro que cuentan con hemoglobina de diagnóstico < 11,5 g/dL (V-2.0)*			03-03-2.0
Intervención estratégica: ***Prevención temprana de la enfermedad ateroesclerótica***			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
03-04-0.1 Porcentaje de población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia	Preventivo	Proceso	Acceso
03-05-0.1 Porcentaje de población de dos a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por dislipidemia	Preventivo	Proceso	Acceso
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
-*Porcentaje de población de nueve a 11 años tamizados con al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo según clasificación del estado nutricional (V-1.0)*			03-04-1.0
-*Porcentaje de población de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional (V-1.0)*			03-04-1.0 03-05-1.0
-*Porcentaje de población de dos a 19 años con componentes del perfil de lípidos en alto riesgo (V-1.0)*			03-04-1.0 03-05-1.0
04. TEMÁTICA: SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR			
Intervención estratégica: ***Valoración de capacidad funcional del adulto mayor***			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
04-01-1.0 Cobertura de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor	Prevención	Proceso	Acceso
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
-*Cobertura de atención a personas de 65 años y más (V-1.0)*			04-01-1.0
-*Porcentaje de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor en los servicios de salud del Primer Nivel de Atención (V-1.0)*			04-01-1.0
05. TEMÁTICA: ECNT-OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO			
Intervención estratégica: ***Atención en salud a las personas con obesidad***			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
05-01-1.0 Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m2 a quienes se les registra el diagnóstico de obesidad	Prevención	Proceso	Acceso
05-02-1.0 Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m2 y un diagnóstico de obesidad que son referidas a Nutrición	Promoción y Prevención	Proceso	Continuidad
05-03-1.0 Porcentaje de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro factor de riesgo cardiovascular, que se atienden en consulta modalidad grupal de Nutrición	Prevención	Proceso	Continuidad
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:

- *No hay*	-

Intervención estratégica: *Atención en salud a las personas con síndrome metabólico*

Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
05-04-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) que alcanzan valores normales de triglicéridos	Prevención	Resultado	Efectividad
05-05-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC), que logran reducir al menos un 5 % del peso corporal	Prevención	Resultado	Efectividad

Indicadores complementarios	Para Indicador de evaluación código:
-*Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico que completan la atención multidisciplinaria (V-1.0)*	05-04-1.0 05-05-1.0
-*Porcentaje de personas de 20 años y más con atención multidisciplinaria para Síndrome Metabólico (SM) y registro del diagnóstico CIE-10 E889 (V-1.0)*	05-04-1.0 05-05-1.0

06. TEMÁTICA: ECNT-DIABETES MELLITUS TIPO 2

Intervención estratégica: *Atención a la población con diabetes mellitus tipo 2*

Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
06-01-1.0 Cobertura de atención de personas con diabetes mellitus tipo 2.	Prevención	Proceso	Acceso
06-02-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo.	Prevención	Resultado	Efectividad
06-03-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial.	Prevención	Resultado	Efectividad
06-04-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo.	Prevención	Resultado	Efectividad

Indicadores complementarios	Para Indicador de evaluación código:
-*Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos una hemoglobina glicosilada en cada semestre (V-1.0)*	06-02-1.0
-*Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos un perfil lipídico al año (V-1.0)*	06-04-1.0

07. TEMÁTICA: ECNT-HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Intervención estratégica: *Atención a la población con hipertensión arterial*

Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
07-01-1.0 Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA)	Prevención	Proceso	Acceso
07-02-1.0 Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA)	Prevención / Tratamiento	Resultado	Efectividad

Indicadores complementarios	Para Indicador de evaluación código:
-*Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo (V-1.0)*	07-01-1.0
-*Cobertura de atención con control óptimo de presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo (V-1.0)*	07-01-1.0
-*Porcentaje de personas de 20 años y más atendidas en el escenario domiciliar por el ATAP con registro de cifras presión arterial en SIFF (V-1.0)*	07-01-1.0
-*Porcentaje de personas no conocidas con hipertensión arterial (no HTA), tamizadas por el ATAP en el escenario domiciliar (V-1.0)*	07-01-1.0
-*Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo (V-1.0)*	07-02-1.0

09. TEMÁTICA: ECNT-CÁNCER

Intervención estratégica: *Prevención del cáncer de cuello uterino*

Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
09-01-2.0 Cobertura bienal de tamizaje con citología cérvico-vaginal por PAP en mujeres de 20 a 29 años.	Prevención	Proceso	Acceso

09-02-2.0 Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de cérvico-uterino en mujeres de 30 a 64 años.	Prevención	Proceso	Acceso
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
- *Porcentaje bienal de mujeres de 20 a 64 años atendidas a las que se les realizó el tamizaje de cáncer cérvico-uterino (V-2.0)*			09-01-2.0 09-02-2.0
- *Porcentaje de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino por grupo de edad según tipo de prueba (V-2.0)*			09-01-2.0 09-02-2.0
Intervención estratégica: ***Prevención del cáncer de mama***			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
09-03-2.0 Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de mama con mamografía en mujeres de 40 a 74 años	Prevención	Proceso	Acceso
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
-*Cobertura bienal de mujeres de 40 a 74 años con mamografía por grupo de edad (V-2.0)*			09-03-2.0
11. TEMÁTICA: EFICIENCIA PRODUCTIVA			
Intervención estratégica: ***Atención integral de la salud en el primer nivel de atención***			
Indicadores de evaluación	Componente:	Clasificación:	Dimensión:
11-01-1.0 Comportamiento del gasto en sueldos para cargos fijos por consulta	Todos	Proceso	Eficiencia
11-02-2.0 Comportamiento del gasto en tiempos extraordinarios	Todos	Proceso	Eficiencia
Indicadores complementarios			Para Indicador de evaluación código:
-*Gasto per cápita en áreas de salud según complejidad (V-1.0)*			11-01-1.0
-*Porcentaje de las horas médicas contratadas requerido para la cobertura de la población con DM2 y HTA (V-2.0)*			11-01-1.0

d. Intervenciones y Fichas técnicas.

Las intervenciones y las fichas técnicas de los indicadores de evaluación y complementarios para la EPSS del primer nivel de atención están contenidos en el anexo respectivo: ANEXO: INTERVENCIONES E INDICADORES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.

III. DISEÑO DE LA EPSS PARA EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN (STNA)

a. Aspectos generales.

Estos indicadores son el resultado de la revisión extensa de fuentes bibliográficas y medicina basada en hechos, desarrollados a partir de la interrelación y corrección de contenidos y observaciones emanados desde la gerencia, las direcciones y unidades locales encargadas de la prestación directa de servicios.

En su construcción, con énfasis en su análisis, se apunta hacia un equilibrio entre la eficiencia general y lo clínicamente requerido, que en lo posible satisfaga la demanda de servicios con calidad técnica e interpersonal, donde se aproveche al máximo los limitados recursos de que se dispone.

Representan en primera instancia el esfuerzo continuado para describir la condición actualizada del quehacer hospitalario según información registrada, de extracción certera y verificable, a su vez, constituyen el primer paso para consolidar un sistema de indicadores integrado que se proyecta madurar progresivamente incorporando, según se requiera, la revisión y análisis de intervenciones y temáticas con valor estratégico gerencial e institucional.

b. Inventario de indicadores de la EPSS del segundo y tercer nivel de atención 2024-2028.

INVENTARIO DE INDICADORES DE LA EPSS DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN 2024-2028			
10. TEMÁTICA: SINDROME CORONARIO AGUDO- INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO			
Intervención estratégica: *Atención de las personas con infarto agudo de miocardio ST-elevado*			
Indicadores de evaluación	Componente	Clasificación	Dimensión
10-01-1.0 Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-aguja de 30 minutos o menos.	Tratamiento	Proceso	Oportunidad
10-02-1.0 Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-balón de 90 minutos o menos.	Tratamiento	Proceso	Oportunidad
10-03-1.0 Proporción de casos trasladados por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo primera puerta-balón de 120 minutos o menos.	Tratamiento	Proceso	Acceso
10-04-1.0 Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado egresados con referencia a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria.	Rehabilitación	Proceso	Oportunidad
Indicadores complementarios			Para indicador de evaluación código.
-Proporción de atenciones con aguja.			10-01-1.0
-Proporción de atenciones con tiempo puerta-aguja medible.			10-01-1.0
-Proporción de atenciones con balón			10-02-1.0
-Proporción de atenciones con balón			10-03-1.0
-Proporción de casos trasladados con tiempo primera puerta-puerta de 60 minutos o menos.			10-03-1.0
-Proporción de casos trasladados con tiempo puerta-balón de 60 minutos o menos.			10-03-1.0
12. TEMÁTICA: GESTIÓN HOSPITALARIA			
Intervención estratégica: *Productividad de los servicios hospitalarios*			
Indicadores de evaluación		Clasificación	Dimensión
12-01-1.0 Índice conjunto de utilización de tiempo en el servicio de emergencias		Proceso	Oportunidad Eficiencia
12-02-1.0 Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada		Proceso	Eficiencia
12-03-1.0 Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria		Proceso	Eficiencia

12-04-1.0 Relación índice de estancia ajustado por el riesgo vs porcentaje de ocupación	Proceso	Eficiencia
12-05-1.0 Índice de mortalidad ajustado por el riesgo	Resultado	Efectividad
Indicadores complementarios		Para indicador de evaluación código.
-Tasa de reingreso en 24 horas por cada 100 atenciones al servicio de emergencias/urgencias		12-01-1.0
-Tasa de reingreso en 72 horas por cada 100 atenciones al servicio de emergencias/urgencias		12-01-1.0
-Porcentaje de altas en especialidad		12-02-1.0
-Porcentaje de ausentismo neto		12-02-1.0
-Tiempo promedio de espera en días para la cita en especialidades médicas		12-02-1.0
-Tiempo promedio de espera en días para procedimientos médicos ambulatorios		12-02-1.0
-Tiempo promedio de espera para cirugías ambulatorias		12-02-1.0
-Porcentaje de ambulatorización quirúrgica		12-02-1.0
-Total citas pendientes en especialidad médica		12-02-1.0
-Brecha oferta-demanda en la consulta externa especializada (LE)		12-02-1.0
-Porcentaje de reingresos hospitalarios a los 30 días		12-03-1.0
-Proporción de egresos hospitalarios con estancia prolongada		12-03-1.0
-Porcentaje de hospitalizaciones prevenibles		12-03-1.0
-Aprovechamiento del tiempo de quirófano disponible		12-03-1.0
-Tasa de Mortalidad		12-05-1.0

c. Intervenciones y Fichas técnicas.

Las intervenciones y las fichas técnicas de los indicadores de evaluación y complementarios para la EPSS del primer nivel de atención están contenidos en el anexo respectivo: ANEXO: INTERVENCIONES E INDICADORES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.

IV. ANEXO: INTERVENCIONES E INDICADORES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.

01-SALUD MATERNO-INFANTIL

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN DE LA SALUD MATERNO INFANTIL

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La Organización Panamericana de la Salud señala que a pesar del progreso alcanzado en materia de salud materno infantil en los países de América Latina y el Caribe, las diferencias en la cobertura y los resultados en salud en determinados grupos de población siguen siendo generalizadas, dejando en evidencia las desigualdades que se enfrentan en este tema (Sanhueza, y otros, 2022, pág. 46). Tal hallazgo, se ratifica con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual reconoce que durante el 2020 la razón de mortalidad materna en países de bajos ingresos fue de 430 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos, frente a 12 por 100 000 nacidos vivos en los países de ingresos altos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Asimismo, el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, añade que pese a los avances en la reducción de la tasa mortinatalidad y la mortalidad de menores de cinco años, durante 2021, murieron cinco millones de niños antes de cumplir cinco años, y 1,9 millones de bebés nacieron muertos; muertes que podrían haberse evitado si las madres, los recién nacidos, los adolescentes y los niños tuvieran un acceso equitativo a una atención sanitaria de alta calidad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2023). Ante el panorama expuesto, los sistemas de salud han desarrollado intervenciones costo efectivas como la detección y el abordaje oportuno de patología durante el embarazo que permiten evitar más del 90 % de las muertes maternas y las complicaciones obstétricas graves (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012, pág. 8); no obstante, un grupo de mujeres y niños aún se enfrentan a barreras económicas, geográficas y sociales, que les impiden el acceso a servicios de calidad, lo que hace que la morbimortalidad materno infantil se mantenga como un problema de salud pública. En Costa Rica, el comportamiento de la razón de mortalidad materna es fluctuante, registrándose para 2022 la razón más baja en los últimos diez años (1,5 por 10 000 mil nacidos vivos); sin embargo, a lo interno de las provincias, Puntarenas alcanzó la mayor razón de mortalidad del país durante 2022, con un 3,36 (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2022, pág. 11). Además, la tasa de mortalidad infantil (TMI) registrada a diciembre de 2022, de 9,58 por 1 000 nacimientos, es la más alta en los últimos cinco años y aumentó 11,1 % respecto a la tasa registrada para 2021 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2023). Por otra parte, según los resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPPS) 2022, en la institución se documentan coberturas de atención en salud materno infantil mayores al 80 %; sin embargo, a lo interno, la falta de acceso, el acceso tardío, así como la detección y el manejo no oportuno todavía afectan a unidades que en su mayoría se caracterizan por atender en sus centros a grupos de población que enfrentan, en mayor grado que otras, barreras económicas, geográficas, sociales y étnicas. Además, se añaden aspectos administrativos, como la distribución geográfica de los puestos de visita periódica y la capacidad instalada de los servicios. En general, condiciones como la fluctuación en la razón de mortalidad materna y el deterioro de la tasa de mortalidad infantil, como indicadores de inequidad y desigualdad, aunado a los resultados institucionales en acceso a los servicios y detección de patología, hacen que la salud materno infantil en Costa Rica se mantenga como un problema de interés en salud pública que amerita de intervenciones claves orientadas a fortalecer los programas de cobertura de atención, acceso temprano, detección y manejo de las enfermedades que inciden en la morbimortalidad materno infantil.

Evidencia	Beneficios de la intervención por intervención y/o dimensión Intervenciones en los sistemas de salud para mejorar la utilización y calidad de la atención prenatal: para reducir la mortalidad perinatal y mejorar la experiencia asistencial de las mujeres se recomiendan modelos de atención prenatal con un mínimo de ocho contactos. *Tipo de recomendación: Recomendada por OMS* (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018, pág. 108). El U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) encontró evidencia convincente de que la detección temprana universal para la infección de sífilis en embarazadas reduce la incidencia de la sífilis congénita y los resultados adversos del embarazo asociados con infección materna. *Tipo de Recomendación A* (Curry, Krist, Owens, & Barry, 2018, pág. 913). El USPSTF también encontró pruebas convincentes que la identificación y el tratamiento de las embarazadas que viven con la infección por el VIH es de gran beneficio en la reducción de la tasa de transmisión de madre a hijo. La magnitud global del beneficio de la detección de la infección por el VIH en adolescentes, adultos y mujeres embarazadas es sustancial. *Tipo de Recomendación A* (Owens, 2019, pág. E2). El diagnóstico temprano de diabetes manifiesta no detectada previamente en una embarazada puede permitir la instauración rápida de una terapia para mitigar estos riesgos (Blumeer, y otros, 2013, pág. 4229). Es recomendable realizar glucosa plasmática de ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas a toda persona embarazada, para una detección temprana de mujeres con DM tipo 2 no diagnosticadas antes del embarazo*. Tipo de Nivel/grado Recomendación A NICE GPC* (Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2017, pág. 28). Evaluación de la evidencia el USPSTF concluye con certeza moderada que existe un beneficio neto moderado de la detección de diabetes gestacional a las 24 semanas de gestación o después para mejorar los resultados maternos y fetales. USPSTF recomienda la detección de diabetes gestacional en embarazadas asintomáticas a partir de las 24 semanas de gestación. *Tipo de Recomendación B* (Davidson, Barry, Mangione, & Cabana, 2021, pág. 531). Las mediciones de la presión arterial son importantes para identificar y tratar con eficacia una condición potencialmente impredecible y fatal, por lo que la USPSTF recomienda la detección de preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de presión arterial durante el embarazo. *Tipo de Recomendación B* (Bibbins, Grossman, Curry, Barry, & Davidson, 2017, pág. 1662) Se encuentra que al menos una dosis de penicilina benzatínica IM aplicada 30 o más días antes del parto previene hasta en un 97% de los casos la infección en el feto, mortalidad y parto pretérmino. Esto supone un beneficio mayor al presentado con la no aplicación oportuna del tratamiento (casos de sífilis congénita, mortalidad perinatal). Es muy bajo el riesgo de presentar efectos adversos serios derivados de la administración de penicilina benzatínica, por lo tanto, se considera que es un tratamiento seguro que sumado a la efectividad comprobada en otros estudios apoya su administración en gestantes. El panel de expertos recomienda la aplicación inmediata de la penicilina. *Tipo de Recomendación fuerte a favor / Calidad de la evidencia: muy baja* (Ministerio de Salud y Protección Social y Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2014, pág. 28).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Falta de capacitación del personal a cargo para la atención y seguimiento de los casos, así como para el uso y mantenimiento de los equipos: esfingomanómetros y glucómetros. Concentraciones de pobreza y/o riqueza. Acceso a servicios privados por condición laboral o económica. Alta dispersión geográfica y migración interna y externa. Población vulnerable: indígenas y adolescentes. Aseguramiento limitado por condición legal, laboral o económica. Capacidad instalada de los laboratorios clínicos para suplir las necesidades de la población (sean cupos, horarios, equipo, infraestructura o personal, reactivos). Estrategias: Brindar educación continua del personal a cargo de la atención y de la calidad y funcionabilidad de los equipos a través de la vigilancia y el mantenimiento por parte de los encargados o responsables. Intensificar los procesos de divulgación y educación sobre las políticas públicas de salud en el marco del estado migratorio o condición legal en el país y aseguramiento, además de otras relacionadas con las necesidades particulares de los grupos vulnerables como son las adolescentes, las personas indígenas y aquellas en estado de pobreza. Incorporar en sus planes y programas acciones destinadas a la organización y la estructura de los servicios, con el propósito de solventar las limitaciones asociadas a horarios de atención, frecuencias de las consultas en los puestos de visita

	periódica y la oferta de servicios de laboratorio clínico en cada área, estableciendo un sistema efectivo para la transferencia precisa y oportuna de los resultados de la prueba a los registros médicos.
Normativa Técnica	• Ley N° 9824. Reforma del artículo 12 de la ley 5395 Ley general de salud, de 30 de octubre de 1973, para proteger a la mujer embarazada, antes, durante y después del parto. • Ley N° 10081. Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido. • Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud, CÓDIGO.PAC.GM.DDSS. AAIP.260121 versión 01 Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud Área de Atención Integral a las Personas Programa de Normalización de Atención a la Mujer 2022 (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2022). • Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.040123. Detección, abordaje y seguimiento de niños y niñas con sífilis congénita (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2023). • Modelo de atención calificada en el embarazo, parto, posparto: centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultural en las maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2017). • Guía para la atención de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Área de Atención Integral a las Personas-Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.3ra edición. San José - Costa Rica (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2020).
Costo / Efectividad	Un estudio realizado en Sudáfrica examinó los datos disponibles sobre mortinatos específicos de este país y evalúo el impacto y la rentabilidad de 13 intervenciones reconocidas para prevenir los mortinatos y la mortalidad materna y neonatal. Concluyendo que las intervenciones fueron altamente rentables y la mejora de la cobertura de 13 intervenciones que ya se recomiendan, podría tener un impacto significativo en las tasas de mortinatalidad y mortalidad materna y neonatal. (Michalow, y otros, 2015, pág. 1). Una serie de estudios de la relación costo-efectividad efectuados en 2013, 2014 y 2015 pusieron de manifiesto que en situaciones de prevalencia elevada se ahorraban costos y que el costo por año de vida ajustado en función de la discapacidad (AVAD) se situaba dentro de lo que la OMS considera estándar en entornos con baja prevalencia. Concluyendo en términos generales, que el tamizaje universal es preferible a la ausencia de tamizaje porque trae aparejada una probable y sustancial reducción de la sífilis congénita y de resultados adversos graves del embarazo independientemente del nivel de prevalencia de la sífilis. (Organización Mundial de la Salud [OMS] y Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2019, pág. 18). Este estudio considera el impacto potencial y el costo de aumentar las intervenciones comprobadas para reducir las muertes de madres, recién nacidos y niños, así como los mortinatos. Considera que el número anual de muertes maternas e infantiles a nivel mundial ha disminuido notablemente en los últimos 25 años; sin embargo, en muchos países la tasa de reducción ha sido demasiado lenta. Concluyendo que para acelerar este progreso se propone ampliar los paquetes integrados de intervenciones esenciales en todo el continuo del cuidado de la salud reproductiva, materna, del recién nacido y el niño (SMRN). Sustentados en que estas intervenciones son altamente costo-efectivas y resultan en una relación costo-beneficio de 7-11 al 2035 (valor actual neto en dólares estadounidenses de los beneficios a los costos). Lo que conllevaría a evitar 149 000 muertes maternas; 849 000 muertes prenatales; 1 498 000 muertes neonatales; y 1 515 000 muertes infantiles, representando el impacto con las tasas actuales de embarazo, nacimiento y mortalidad (Black, Walker, Laxminarayan, & Temmerman, 2018)
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar el acceso, la detección y manejo oportuno de la población materno infantil, con el fin de identificar las brechas en la equidad a los servicios y aportar elementos para la formulación de estrategias para la prevención de complicaciones en la madre y el recién nacido.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuáles son las brechas y las probables determinantes en los resultados de la cobertura de atención temprana en la atención de salud materno infantil entre las unidades que conforman el primer nivel de atención? ¿Cuáles son los logros de la oportunidad en el acceso y detección oportuna en el embarazo con relación al paquete básico de intervenciones de las embarazadas?

	¿Cuáles son las deficiencias en la cadena acontecimientos en la atención de las embarazadas seropositivas para sífilis?
Indicadores asociados a la intervención	02-01-1.0 Cobertura de atención temprana de menores de un año 02-02-1.0 Cobertura de atención temprana de mujeres en periodo posnatal 02-03-1.0 Cobertura de atención temprana de embarazadas 02-04-1.0 Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional. 02-05-1.0 Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado
Anexos	Consenso con equipo técnico Minuta de reunión con Programa de Normalización de Atención a la Mujer y Comisión Gerencial de Maternidades. Participantes: Dra. Carla Gríos Dávila, Dr. Jorge Arturo Mora Sandí, Dra. Alina del Carmen Gutiérrez Rodríguez, Dra. María Griselda Ugalde Salazar. (02 marzo 2023) Acuerdos: se avala los indicadores: • Porcentaje de embarazadas a quienes se les realiza un paquete básico de intervenciones según edad gestacional. • Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado. Minuta de reunión con Área de Atención Integral a las Personas, Programa de normalización de la atención de las infecciones de transmisión sexual. (15 de agosto 2023). Participantes: Dra. Gloria Terwes Posada y Dra. Silvia Vanesa Briceño Méndez Acuerdos: se avala los indicadores: • Porcentaje de embarazadas a quienes se les realiza un paquete básico de intervenciones según edad gestacional. • Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado. Minuta de reunión con Área de Atención Integral a las Personas, Programa de normalización de la atención de las infecciones de transmisión sexual. (25 de agosto 2023). Participantes: Dra. Gloria Terwes Posada, Dra. Silvia Vanesa Briceño Méndez y enlaces de red: Yendri Pamela Sáenz Madrigal, Yorleny Morales Alfaro, Melvin Anchía Villalobos, Nidia Morera Murillo, Yihonory Patricia Martínez Guillén, Luis Diego Mora Madrigal, Clary Yessenia Delgado Delgado, Tania Medina Alfaro, Juliana Monge Arguello, Heraldo Monge Duarte, Laura Sánchez Ortiz Acuerdos: se avala los indicadores: • Porcentaje de embarazadas a quienes se les realiza un paquete básico de intervenciones según edad gestacional. • Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado.
Referencias Bibliográficas	Bibbins, K., Grossman, D., Curry, S., Barry, M., & Davidson, K. (25 de abril de 2017). Screening for Preeclampsia US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA, 317*(16), 1661-1667. doi:10.1001/jama.2017.3439 Black, R., Walker, N., Laxminarayan, R., & Temmerman, M. (2018). Salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño: mensajes clave de este volumen. En D. Jamison, H. Nugent, S. Gelband, P. Horton, & R. Laxminarayan, Prioridades para el control de enfermedades: Compendio de la tercera edición. (pág. 89). Washintong: Banco Mundial. Obtenido de https://documents1.worldbank.org/curated/en/502171618819290636/pdf/Prioridades-para-el-control-de-enfermedades-Compendio-de-la-3a-edicion.pdf Blumeer, I., Hadar, E., Hadden, D., Jovanovic, L., Mestan, J., Hassan, M., & Yogev, Y. (1 de noviembre de 2013). Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 98*(11), 4227–4249. doi:10.1210/jc.2013-2465 Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017). Modelo de atención calificada en el embarazo, parto, posparto: centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultural en las maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Obtenido de https://www.mamasol.com/wp-content/uploads/2019/12/Modelo-ATENCION-CALIFICADA-EN-EL-EMBARAZO-PARTO-POSPARTO-ULTIMO.pdf Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2020). Guía para la atención de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Obtenido de

https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/3487/Gu%C3%ADaDM.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2022). Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud. Obtenido de https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2023/02/Protocolo-de-Atencion-Clinica-integral-al-embarazo-parto-y-postparto-2.pdf

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.040123 Detección, abordaje y seguimiento de los niños y niñas con sífilis congénita.

Curry, S., Krist, A., Owens, D., & Barry, M. (setiembre de 2018). Screening for Syphilis Infection in Pregnant Women US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement. *JAMA, 320*(9), 918-948. doi:10.1001/jama.2018.11785

Davidson, K., Barry, M., Mangione, C., & Cabana, M. (10 de agosto de 2021). Screening for Gestational Diabetes US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*, 539-577. doi:10.1001/jama.2021.11922

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (18 de julio de 2023). *Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia*. Obtenido de Un informe de las Naciones Unidas revela que un niño o un joven murió cada 4.1 segundos en 2021: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/un-informe-de-las-naciones-unidas-revela-que-un-ni%C3%B1o-o-un-joven-muri%C3%B3-cada-44#:~:text=La%20tasa%20de%20mortalidad%20de,se%20redujo%20en%20un%2035%25.

Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS]. (2017). *Control prenatal con atención centrada en la paciente.Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. Actualización 2017.* México: IMSS. Obtenido de https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/028GER.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2022). *Mortalidad Materna y su evolución reciente 2021.* San José, Costa Rica: INEC. Obtenido de https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-01/repoblacdefEV_2021A_mortalidad%20materna%20y%20su%20evoluci%C3%B3n%20reciente.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC]. (2023). *Tasa de mortalidad infantil interanual abril 2023.* San José, Costa Rica: INEC. Obtenido de https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-06/RePoblacEv-TMII04-2023.pdf

Michalow, J., Schola, L., McGee, S., Tugendhaft, A., Pattinson, R., Kerberth, K., & Hofman, K. (2015). Triple return on investment: the cost and impact of 13 interventions that could prevent stillbirths and save the lives of mothers and babies in South Africa. *BMC Pregnancy & Childbirth, 15*(39). doi:10.1186/s12884-015-0456-9

Ministerio de Salud de Colombia y Protección Social y Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2014). *Guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia para la atención de la sífilis gestacional y congénita Sistema General de Seguridad Social en Salud.* Bogotá Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/gpc-guia-corta-sifilis.pdf

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2012). *Organización Mundial de la Salud Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproducción.* Montevideo, Uruguay: OMS. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49332/CLAP1593.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (18 de julio de 2023). *Organización Mundial de la Salud*. Obtenido de Mortalidad Materna: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

Organización Mundial de la Salud [OMS] y Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2019). *Guía de la OMS sobre detección y tratamiento de la sífilis en embarazadas.* Washington: OPS. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51791/9789275321744_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2018). *Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo.* Washington DC: OPS. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49550/9789275320334_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Owens, D. (11 de junio de 2019). Screening for HIV Infection US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. doi:10.1001/jama.2019.6587

Sanhueza, A., Carvajal, L., Cueva, D., Camacho, A., Berroterán, M., Horowitz, D., . . . Mujica, O. (2022). La iniciativa Todas las mujeres Todos los niños brinda apoyo a los países de América Latina y el Caribe para reduir las desigualdades sociales en salud. *Revista Panam Salud Pública*, 46. doi:https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.201

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 01-01-1.0

Elemento	Descripción	
Código	01-01-1.0	
Nombre	Cobertura de atención temprana de menores de un año.	
Definición conceptual	Porcentaje de menores de un año que reciben atención temprana en la consulta externa de primera vez en el periodo. • Atención temprana de menores de un año: es la atención que se realiza en los primeros siete días de vida. Incluye: • Consultas de primera vez en el año (medicina general, enfermería, ginecología y medicina familiar): población de menores con edades entre cero y 364 días, con fecha de nacimiento del periodo. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de un año que reciben atención en los primeros siete días de vida en el periodo. • Número de nacimientos del periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de un año que reciben atención en los primeros siete días de vida en el periodo}}{\text{Número de nacimientos del periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	61 %	
Meta	Quinquenal: 72 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal): • Consultas de primera vez en la vida por edad (28 días o menos y de uno a 11 meses). Dirección Actuarial y Económica: • Nacimientos preliminares del periodo con base en los datos el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual y monitoreo). • Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual).	
Comentarios generales	No aplica.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 01-02-2.0

Elemento	Descripción	
Código	01-02-2.0	
Nombre	Cobertura de atención temprana de mujeres en periodo posnatal.	
Definición conceptual	Porcentaje de mujeres en periodo posnatal que reciben atención temprana en la consulta externa de primera vez en el periodo. • Atención temprana de mujeres en periodo posnatal: es la atención que se realiza en los primeros siete días del parto. • Posnatal: periodo entre los 0 y los 42 días del parto o el aborto. • Pospartos estimadas del periodo: nacimientos del periodo por 1.1 (10 % de abortos). Incluye: • Consultas de primera vez en el año (medicina general, enfermería, ginecología y medicina familiar): población de mujeres en periodo posnatal con fecha de parto (FP) válida del periodo. La FP se considera válida cuando la diferencia entre la fecha de consulta de primera vez en el posparto y la fecha de parto registrada en el apartado posparto ítem captación temprana del expediente digital único en salud (EDUS) está entre de 0 a 42 días. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Número de mujeres en el periodo posnatal que reciben atención en los primero siete días del parto en el periodo. • Número de pospartos estimadas del periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres en el periodo posnatal que reciben atención en los primeros siete días del parto en el periodo}}{\text{Número de pospartos estimadas del periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	43 %	
Meta	Quinquenal: 55 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal): • Consultas de primera vez de mujeres en el periodo posnatal por códigos CIE-10: Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto, Z391. Atención y examen de madre en periodo de lactancia, Z392. Seguimiento postparto de rutina, Z370. Nacido vivo único, Z379. Producto de parto no específico, O800. Parto único espontáneo presentación cefálica de vértice, O03. Aborto espontaneo, O04. Aborto médico, O05. Otro aborto, O06. Aborto no especificado y O021 Aborto retenido. O60 Parto prematuro. Dirección Actuarial y Económica: • Nacimientos preliminares del periodo con base en los datos el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual y monitoreo).	

	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo del indicador complementario: • Porcentaje de mujeres en periodo posnatal con fecha de parto válida.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 01-03-1.0

Elemento	Descripción	
Código	01-03-1.0	
Nombre	Cobertura de atención temprana de embarazadas.	
Definición conceptual	Porcentaje de embarazadas que reciben atención temprana en la consulta externa de primera vez en el periodo. • Atención temprana de embarazadas: es la atención que se realiza en las primeras 11 semanas de gestación. • Embarazadas estimadas del periodo: nacimientos del año por 1.1 (10 % de abortos) Incluye: • Consultas de primera vez en el embarazo (medicina general, enfermería, ginecología y medicina familiar): población de mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con fecha probable de parto (FPP) válida para el periodo, independientemente del año de inicio el control. Para el cálculo de la FPP se utiliza la Regla de Naegle que suma siete días a la fecha de última regla (FUR) válida y le resta tres meses, y la misma se considera válida cuando la fecha resultante coincide con el periodo. La FUR se considera válida cuando la diferencia entre la fecha de consulta de primera vez en el embarazo y la fecha de última regla (FUR) registrada en el apartado control prenatal ítem datos embarazo del expediente digital único en salud (EDUS) está entre una a 42 semanas. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Número de embarazadas que reciben atención en las primeras 11 semanas de gestación en el periodo. • Número de embarazadas estimadas del periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de embarazadas que reciben atención en las primeras 11 semanas de gestación en el periodo}}{\text{Número de embarazadas estimadas del periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	59 %	
Meta	Quinquenal: 68 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal): • Consultas de primera vez en el embarazo por códigos CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado. Dirección Actuarial y Económica: • Nacimientos preliminares del periodo con base en los datos el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual y monitoreo). • Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual).	
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo del indicador complementario: • Porcentaje de embarazadas con fecha de última regla válida.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 01-04-2.0

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Código</td><td>01-04-2.0</td></tr>
<tr><td>Nombre</td><td>Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional.</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td>
Porcentaje de embarazadas que reciben atención en la consulta externa de primera vez a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones para el control prenatal correspondiente a la edad gestacional.

A continuación, se detalla las intervenciones que aplican según el rango de edad gestacional al momento de la fecha de corte:

<table>
<tr><td colspan="5">Intervenciones del paquete básico según rango de edad gestacional al momento del corte para la evaluación</td></tr>
<tr><td>1 a 19 semanas</td><td>20 a 28 semanas</td><td>29 a 32 semanas</td><td>33 a 40 semanas</td><td>41 semanas y más</td></tr>
<tr><td colspan="5">Primer control en las primeras 11 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="5">Toma de presión arterial (PA) en el primer control</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td colspan="4">Detección de VDRL en las primeras 19 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="4">Detección de VIH en las primeras 19 semanas</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td colspan="3">Detección de DM pregestacional en las primeras 23 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Detección de DM gestacional entre 24 y 28 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Segundo control entre 12 y 20 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Toma de PA en el segundo control</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tercer control entre 21 y 28 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Toma de PA en tercer control</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">Cuarto control entre 29 y 32 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toma de PA en el cuarto control</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Quinto control entre 33 y 40 semanas</td></tr>
<tr><td>Toma de PA en el quinto control</td></tr>
</table>

Incluye:

• Consultas de primera vez en el embarazo (medicina general, enfermería, ginecología y medicina familiar): población de mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación y que cuente con FUR válida para el periodo.

La FUR se considera válida cuando la diferencia entre la fecha de consulta de primera vez en el embarazo y la fecha de última regla (FUR) registrada en el apartado control prenatal
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">ítem datos embarazo del expediente digital único en salud (EDUS) está entre una a 42 semanas.

• Pruebas de laboratorio clínico: serología para VDRL, serología para VIH, glicemia en ayunas y curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, realizadas en el periodo.
Excluye:

• No aplica.</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Número de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional en el periodo.
• Número de embarazadas con FUR válida para el periodo.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\text{Número de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional en el periodo}}{\text{Número de embarazadas con FUR válida para el periodo}} \times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Salud materno infantil</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Se define con el resultado de la evaluación para el 2024</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="2">Quinquenal: en construcción</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal):

• Consultas de primera vez en el embarazo por código CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado.
• Consultas de primera vez de mujeres en el periodo posnatal por códigos CIE-10: Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto, Z391. Atención y examen de madre en periodo de lactancia, Z392. Seguimiento postparto de rutina, Z370. Nacido vivo único, Z379. Producto de parto no específico, O800. Parto único espontáneo presentación cefálica de vértice, O03. Aborto espontaneo, O04. Aborto médico, O05. Otro aborto, O06. Aborto no especificado, O021 Aborto retenido y O60 Parto prematuro.
Sistema integrado de laboratorio clínico y LabCore®:

• Pruebas de laboratorio clínico realizadas en el periodo: serología para VDRL, serología para VIH, glicemia en ayunas y curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos.
Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal)**:**

• Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente con fecha y resultado del periodo: serología para VDRL y serología para VIH.</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual y monitoreo).
• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual).</td></tr>
</table>

Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios por intervención del paquete básico según grupo al momento del corte para la evaluación: • Porcentaje de embarazadas entre siete y 19 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas entre 20 y 28 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas entre 29 y 32 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas entre 33 y 40 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas 41 semanas de gestación y más a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 01-05-2.0

Elemento	Descripción
Código	01-05-2.0
Nombre	Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado
Definición conceptual	Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben atención en la consulta externa de primera vez a quienes se les brinda tratamiento oportuno y adecuado. • Embarazadas seropositivas para sífilis: mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con una prueba de laboratorio clínico de serología VDRL positiva o reactiva (independientemente de las titulaciones). • Tratamiento oportuno y adecuado: administración por vía intramuscular de 2,4 millones penicilina g benzatínica en los primeros 10 días hábiles a partir de la fecha de ingreso del reporte de la serología VDRL positivo, según sea el caso (Anexo 1). Incluye: • Consultas de primera vez en el embarazo (medicina general, enfermería, ginecología, medicina familiar): población de mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con FUR válida para el periodo. • Consultas de primera vez en el embarazo con diagnóstico presuntivo de sífilis (medicina general, enfermería, ginecología, medicina familiar): población de mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con FUR válida para el periodo. La FUR se considera válida cuando la diferencia entre la fecha de consulta de primera vez en el embarazo y la fecha de última regla (FUR) registrada en el apartado control prenatal ítem datos embarazo del expediente digital único en salud (EDUS) está entre una a 42 semanas. • Pruebas de laboratorio clínico: serología para VDRL reportada como positiva o reactiva (independientemente de las titulaciones) en el periodo, con una fecha de realización 10 días hábiles previos a la fecha de corte del periodo de evaluación. Excluye: • No aplica.
Variables involucradas en la medición	• Número de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado en el periodo • Número de embarazadas seropositiva con FUR válida para el periodo
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado en el periodo}}{\text{Número de embarazadas seropositiva con FUR válida para el periodo}} \times 100$

<table>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención

Tratamiento (curación/mantenimiento)</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Salud materno infantil</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">79 %</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="2">Quinquenal: 100 %</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal):

• Consultas de primera vez en el embarazo por código CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado.
• Consultas de primera vez en el embarazo con diagnóstico presuntivo por sífilis por código CIE-10: A50 Sífilis congénita. A51 Sífilis precoz. A52 Sífilis tardía. A53 Otras sífilis y las no específicas. O981 Sífilis que complica el embarazo, parto y puerperio. R762 Falso positivo en la prueba serológica para sífilis. Z369 Pesquisa prenatal, sin otra especificación. Z224 Portador de agentes de enfermedades infecciosas con un modo de transmisión predominantemente sexual.
• Consultas de primera vez de mujeres en el periodo posnatal por códigos CIE-10: Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto, Z391. Atención y examen de madre en periodo de lactancia, Z392. Seguimiento postparto de rutina, Z370. Nacido vivo único, Z379. Producto de parto no específico, O800. Parto único espontáneo presentación cefálica de vértice, O03. Aborto espontaneo, O04. Aborto médico, O05. Otro aborto, O06. Aborto no especificado, O021 Aborto retenido y O60 Parto prematuro.

Sistema integrado de laboratorio clínico y LabCore®:

• Pruebas de laboratorio clínico realizadas en el periodo: serología para VDRL.

Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal)**:**

• Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente con fecha y resultado del periodo: serología para VDRL.</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual y monitoreo).
• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual).</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

Anexo 1:

Tratamiento oportuno y adecuado para embarazadas seropositivas para sífilis

Serología VDRL	Prueba Treponémica	Caso	Tratamiento adecuado	
Positiva	Ausente	1	Aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular en las siguientes dosis, según corresponda:	Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G cuando hay presencia de síntomas o antecedentes recientes de signos o síntomas (menos de 1 año)
				Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control, muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y tiene antecedentes de signos o síntomas recientes
				Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando no tiene síntomas o no recuerda historia de signos o síntomas
				Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control, muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y no tiene síntomas o no recuerda historia de signos o síntomas
		2	No aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular en los siguientes casos:	Cuando hay antecedentes de serología VDRL positiva antes del embarazo, cuyo VDRL muestra títulos menores a 4 veces al VDRL anterior y hay evidencia de que su pareja o contacto(s) fue tratado
				Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una embarazada detectada el año anterior y las diluciones: a. se mantienen b. aumentan a menos de 4 veces de titulación inicial c. disminuyen a menos de 4 veces de titulación inicial
				Cuando exista evidencia en el expediente de la referencia a urgencias, II o III nivel de atención, por el antecedente de alergia a la penicilina benzatínica G o cuando la unidad no cuenta con las condiciones necesarias para la aplicación
Positiva	Negativa	3	No aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular	Seguimiento según norma.
Positiva	Positiva	4	Aplicación de penicilina G por vía intramuscular, según corresponda	Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por vía intramuscular si la clasificación cronológica de la infección es: Sífilis primaria, secundaria o latente temprana
				Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control de una embarazada con diagnóstico de Sífilis Gestacional (primaria, secundaria o latente temprana), muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y se determina que se trata de una reinfección
				Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas si la clasificación cronológica de la infección es Sífilis latente tardía o latente de duración desconocida
				Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control de una embarazada con diagnóstico de Sífilis Gestacional (latente tardía o latente de duración desconocida), muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y se determina que se trata de una reinfección
				Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando no se consigne en el expediente la clasificación cronológica de la infección
		5	No aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular en los siguientes casos:	Cuando hay antecedentes de Sífilis tratada antes del embarazo, cuyo VDRL muestra títulos menores a 4 veces al VDRL anterior y hay evidencia de que su pareja o contacto(s) fue tratado
				Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una embarazada con Sífilis Gestacional detectada el año anterior y las diluciones: a. se mantienen b. aumentan a menos de 4 veces de titulación inicial c. disminuyen a menos de 4 veces de titulación inicial
				Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una embarazada con Sífilis Gestacional detectada el año anterior y las diluciones aumentan a más de 4 veces la titulación inicial y exista evidencia en el expediente de la referencia al II o III nivel de atención por fracaso terapéutico o neurosífilis
				Cuando existe evidencia en el expediente de la referencia a urgencias, II o III nivel de atención, por el antecedente en la embarazada de alergia a la penicilina benzatínica G o cuando la unidad no cuenta con las condiciones necesarias para la aplicación

Casos 1 y 2: CIE-10: Z369

Pesquisa prenatal, sin otra especificación

Caso 3: CIE-10: R762

Falso positivo en la prueba serológica para sífilis

Caso 4: CIE-10: O981

Sífilis que complica el embarazo, parto y puerperio

Caso 5: CIE-10: Z224
Portador de agentes de enfermedades infecciosas con un modo de transmisión predominantemente sexual

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de atención temprana de menores de un año	
Indicador Complementario	Porcentaje de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno. (V-1.0)	
Definición conceptual	Porcentaje de niños menores de 28 días de vida a quienes se les realiza una prueba del talón entre el tercer y séptimo día de edad en el periodo. Tamizaje neonatal oportuno: prueba que se realiza con gotas de sangre fresca capilar obtenidas del talón de un recién nacido entre el tercer y séptimo día de vida. La prueba del talón se realiza para descubrir aquellos recién nacidos aparentemente sanos, pero que ya tienen una enfermedad que con el tiempo ocasionará daños graves, irreversibles, antes de que éstos se manifiesten, con la finalidad de poder tratarla, evitando o aminorando sus consecuencias. Incluye: • Pruebas del talón registradas: población de recién nacidos a quienes se les realiza la prueba del talón en el periodo. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno en el periodo • Número de recién nacidos con tamizaje neonatal en el periodo	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno en el periodo}}{\text{Número de recién nacidos con tamizaje neonatal en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	93 %, referente institucional del 2022	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Sistema de información del Programa Nacional de Tamizaje: • Pruebas del talón registradas (guía).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.	
Comentarios generales	Se espera para el quinquenio una mejora en el registro, alcanzando un 95 %.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de atención temprana de menores de un año	
Indicador Complementario	Porcentaje de muestras insatisfactorias para el tamizaje neonatal. (V-1.0)	
Definición conceptual	Porcentaje de muestras tomadas con calidad insatisfactoria para el tamizaje neonatal. Contempla las muestras de sangre seca en papel de filtro, tomadas en el centro de salud correspondiente, donde se les realiza la verificación de la calidad de la muestra y se determina que no cumplen con los parámetros de calidad para ser procesadas de manera satisfactoria en el laboratorio. • Muestra insatisfactoria: muestra de gotas de sangre en papel de filtro que se requiere para el tamizaje neonatal y que no tiene los criterios de calidad para definirse como satisfactoria. • Tamizaje neonatal: prueba del talón que se realiza para descubrir aquellos recién nacidos aparentemente sanos, pero que ya tienen una enfermedad que con el tiempo ocasionará daños graves, irreversibles, antes de que éstos se manifiesten, con la finalidad de poder tratarla, evitando o aminorando sus consecuencias. Incluye: • Muestras para la prueba del talón registradas: muestra de gotas de sangre seca en papel de filtro de la población de recién nacidos a quienes se les realiza la prueba del talón en el periodo. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de muestras para el tamizaje neonatal insatisfactorias en el periodo • Número de muestras para el tamizaje neonatal en el periodo	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de muestras para el tamizaje neonatal insatisfactorias en el periodo}}{\text{Número de muestras para el tamizaje neonatal en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	3 %, referente institucional del 2022	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Sistema de información del Programa Nacional de Tamizaje: • Pruebas del talón registradas (guía).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.	
Comentarios generales	Se espera para el quinquenio una mejora en el registro, alcanzando un 2 %.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de atención temprana de menores de un año	
Indicador Complementario	Tiempo de tránsito promedio de las muestras para tamizaje neonatal. (V-1.0)	
Definición conceptual	Tiempo de tránsito promedio en días de las muestras de sangre seca en papel de filtro que se utiliza para realizar la prueba del talón de los niños menores de 28 días de vida en el periodo. Tiempo de tránsito: se define como el tiempo en días, desde que se toma la muestra en el centro de salud hasta que es recibida en el Laboratorio Nacional de Tamizaje Neonatal y Alto Riesgo, donde se realiza los diferentes estudios relacionados con el tamizaje neonatal. La prueba del talón se realiza para descubrir aquellos recién nacidos aparentemente sanos, pero que ya tienen una enfermedad que con el tiempo ocasionará daños graves, irreversibles, antes de que éstos se manifiesten, con la finalidad de poder tratarla, evitando o aminorando sus consecuencias. Incluye: • Pruebas del talón registradas: población de recién nacidos a quienes se les realiza la prueba del talón en el periodo. Excluye: • Las muestras que se reciben para confirmación o seguimientos.	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de las diferencias entre la fecha de toma y la fecha de llega de cada muestras para el tamizaje neonatal en el periodo • Número de muestras para el tamizaje neonatal en el periodo	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Sumatoria de las diferencias entre la fecha de toma y la fecha de llega de cada muestras para el tamizaje neonatal en el periodo}}{\text{Número de muestras para el tamizaje neonatal en el periodo}}$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	3 días, referente institucional del 2022	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Sistema de información del Programa Nacional de Tamizaje: • Pruebas del talón registradas (guía).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.	
Comentarios generales	Se espera para el quinquenio una mejora en el registro, alcanzando los 2 días.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 04

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de atención temprana de mujeres en periodo posnatal	
Indicador Complementario	Porcentaje de mujeres en periodo posnatal a quienes se les registra la fecha del parto actual en el apartado correspondiente y la consulta de primera vez se da entre los 0 y 42 días del parto. (V-2.0)	
Definición conceptual	Porcentaje de mujeres en periodo posnatal a quienes se les registra la fecha del parto actual en el apartado ítem captación temprana y la consulta de primera vez se da entre los 0 y 42 días del parto. Incluye: • Consultas de primera vez de mujeres en el periodo posnatal (medicina general, enfermería, ginecología y medicina familiar) por códigos CIE-10: Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto, Z391. Atención y examen de madre en periodo de lactancia, Z392. Seguimiento postparto de rutina, Z370. Nacido vivo único, Z379. Producto de parto no específico, O800. Parto único espontáneo presentación cefálica de vértice, O03. Aborto espontaneo, O04. Aborto médico, O05. Otro aborto y O06. Aborto no especificado. O021 Aborto retenido y O60 Parto prematuro. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de mujeres en periodo posnatal a quienes se les registra una fecha de parto en el apartado "*posparto ítem captación temprana"* y la consulta de primera vez se da entre los 0 y 42 días del parto • Número de mujeres en periodo posnatal que consultan de primera vez en el periodo	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres en periodo posnatal a quienes se les registra una fecha de parto en el apartado "posparto ítem captación temprana" y la consulta de primera vez se da entre los 0 y 42 días del parto}}{\text{Número de mujeres en periodo posnatal que consultan de primera vez en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	58 %, referente institucional del 2022.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Ver apartado correspondiente en indicador 01-02-2.0	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.	
Comentarios generales	Se espera para el quinquenio una mejora en el registro, alcanzando un 90% de validez del dato.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 05

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de atención temprana de embarazadas Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional.	
Indicador Complementario	Porcentaje de embarazadas a quienes se les registra la fecha de última regla actual en el apartado correspondiente y la consulta de primera vez se da entre una y 42 semanas de gestación. (V-2.0)	
Definición conceptual	Porcentaje de embarazadas a quienes se les registra la fecha de última regla en el apartado control prenatal ítem datos embarazo y la consulta de primera vez se da entre una y 42 semanas de gestación. Incluye: • Consultas de primera vez en el embarazo (medicina general, enfermería, ginecología y medicina familiar): población de mujeres a quienes se les consigna un código diagnóstico CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de embarazadas a quienes se les registra una fecha de última regla en el apartado *"control prenatal ítem datos embarazo"* y la consulta de primera vez se da entre una y 42 semanas de gestación. • Número de embarazadas que consultan de primera vez en el periodo	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de embarazadas a quienes se les registra una fecha de última regla en el apartado "control prenatal ítem datos embarazo" y la consulta de primera vez se da entre una y 42 semanas de gestación}}{\text{Número de embarazadas que consultan de primera vez en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud materno infantil
Línea base	88 %, referente institucional del 2022	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Ver apartado correspondiente en indicadores 01-03-1.0 y 01-04-2.0	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.	
Comentarios generales	Se espera para el quinquenio una mejora en el registro, alcanzando un 90% de validez del dato.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 06

Elemento	Descripción
Indicador de Evaluación	Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional
Indicador Complementario	Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones correspondiente según grupo. (V-2.0)
Definición conceptual	Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones correspondiente según grupo: • Porcentaje de embarazadas entre una y 19 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones. • Porcentaje de embarazadas entre 20 y 28 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones. • Porcentaje de embarazadas entre 29 y 32 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones. • Porcentaje de embarazadas entre 33 y 40 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones. • Porcentaje de embarazadas entre 41 y 42 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones. Incluye: • Consultas: establecidas en el indicador de evaluación (02-04-2.0) Excluye: • No aplica.
Variables involucradas en la medición	• Número de embarazadas entre una y 19 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo • Número de embarazadas entre una y 19 semanas de gestación con FUR válida para el periodo • Número de embarazadas entre 20 y 28 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo • Número de embarazadas entre 20 y 28 semanas de gestación con FUR válida para el periodo • Número de embarazadas entre 29 y 32 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo • Número de embarazadas entre 29 y 32 semanas de gestación con FUR válida para el periodo • Número de embarazadas entre 33 y 40 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo • Número de embarazadas entre 33 y 40 semanas de gestación con FUR válida para el periodo • Número de embarazadas con 41 semanas de gestación y más a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo • Número de embarazadas con 41 semanas de gestación y más con FUR válida para el periodo

<table>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">Número de embarazadas entre una y 19 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo
———————————————————————————————— x 100
Número de embarazadas entre una y 19 semanas de gestación con FUR válida para el periodo

Número de embarazadas entre 20 y 28 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo
———————————————————————————————— x 100
Número de embarazadas entre 20 y 28 semanas de gestación con FUR válida para el periodo

Número de embarazadas entre 29 y 32 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo
———————————————————————————————— x 100
Número de embarazadas entre 29 y 32 semanas de gestación con FUR válida para el periodo

Número de embarazadas entre 33 y 40 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo
———————————————————————————————— x 100
Número de embarazadas entre 33 y 40 semanas de gestación con FUR válida para el periodo

Número de embarazadas con 41 semanas de gestación y más a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones en el periodo
———————————————————————————————— x 100
Número de embarazadas con 41 semanas de gestación y más con FUR válida para el periodo</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Salud materno infantil</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Se define con el resultado de la EPSS para este indicador en el 2024</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Ver apartado correspondiente en indicador 01-04-2.0</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.
• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

02-SALUD BUCODENTAL

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD BUCODENTAL

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La salud bucodental es parte integral de la salud general, entendida como el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.). Actualmente, la ausencia de salud bucodental es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que casi la mitad de población (3,5 mil millones de personas), padece enfermedades bucodentales; de estas, tres de cada cuatro viven en países de ingreso bajo y mediano y esta asociación se da desde la niñez hasta la vejez. Por otra parte, el problema se agrava por el incremento en unos mil millones durante los últimos 30 años, evidenciando una limitación de acceso a la prevención y el tratamiento de las enfermedades bucodentales (OMS, 2022). La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Asamblea Mundial del 2021 aprobó estrategias que se centran en la promoción. Así mismo, en el 2022 se adoptó la estrategia mundial sobre salud bucodental, cuya visión es la cobertura sanitaria universal para la salud bucodental de todas las personas y comunidades para 2030, priorizando las poblaciones marginadas y de bajos ingresos, con más limitaciones para acceder a la atención; entre dichas estrategias se incluyen el fortalecimiento de la prevención y la atención primaria de salud centrada en el paciente (OMS, 2022). El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (actual director general de la OMS), declaró que “durante largo tiempo se ha descuidado la salud bucodental como parte de la salud mundial, pero muchas enfermedades bucodentales pueden prevenirse y ser tratadas con las medidas costo eficaces”. Y que la OMS tiene el compromiso de “facilitar orientación y apoyo a los países, de modo que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia y de cualesquiera que sean sus ingresos, dispongan del conocimiento y las herramientas precisas para cuidar sus dientes y su boca, así como para acceder a los servicios de prevención y atención cuando los necesiten” (OMS, 2022). Las enfermedades bucodentales más frecuentes son: la caries dental, la periodontitis grave, la pérdida de dientes y el cáncer bucal. La caries dental no tratada es la afección con mayor prevalencia a nivel mundial y se estima que afecta a 2 500 millones de personas. Se calcula que la periodontitis grave, es una de las causas principales de la pérdida dental total, afecta a mil millones de personas en todo el mundo y cada año se diagnostican unos 380 000 nuevos casos de cáncer bucal (OMS, 2022). La periodontitis es la enfermedad crónica inflamatoria más común que se observa en humanos, y afecta a casi la mitad de los adultos en el Reino Unido y en Estados Unidos y al 60 % de los mayores de 65 años. Es un importante problema de salud pública, causando pérdida de dientes, discapacidad, disfunción masticatoria y estado nutricional deficiente. La periodontitis también compromete el habla, reduce la calidad de la vida y es una carga creciente para la economía. Las enfermedades periodontales son muy prevalentes, tienden a afectar considerablemente a los individuos y a la sociedad, su tratamiento es costoso y son, en su gran mayoría, prevenibles, existiendo métodos eficaces para controlarlas (Carvajal, 2016). Mientras que, en Costa Rica, se ha evidenciado que el problema progresa desde la niñez, ya que las cifras demuestran que el 47 % de los casos, mantienen su condición dental sin historia de caries, situación que se deteriora durante el ciclo de vida de las personas, hasta que se llega a tener un promedio de cuatro a seis dientes, de los cuales ninguno se encuentra sano. Más aún, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), para el “2050 la cuarta parte de la población tendrá 60 años o más y requerirá de algún tipo de prótesis dental y una respuesta oportuna en la atención de los servicios odontológicos” (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2004). Aunado a esto, los hábitos de higiene de la población manifiestan deterioro, lo que guarda relación directa con la pérdida de dientes a edad temprana. Así como, “el bajo impacto de los servicios de atención de la salud bucodental del país y la falta de integración de estos contribuye a que la población no mantenga altos índices de salud bucodental durante su ciclo de vida. Siendo causa de ello el reducido acceso universal y equitativo de la población a los servicios de promoción, prevención, atención y rehabilitación de salud bucal, en el curso de vida, lo que se manifiesta en: barreras en la cobertura y accesibilidad de la atención de la salud bucal a escala nacional, sin enfoque de atención primaria. Recursos humanos insuficientes en los servicios de salud odontológicos en cantidad. Insuficiente producción y gestión del conocimiento e investigación" (CCSS, 2004).

	Las Prestaciones Odontológicas de la Caja Costarricense de Seguro Social se orientan en: promoción con participación social, prevención masiva y específica, actividades clínicas (preventivas, curativas y rehabilitación) (CCSS, 2004). Según el instrumento de gestión de los servicios de odontología de la CCSS en el 2019, se logró abarcar el 17,4 % de la población total asegurada, con un odontólogo por cada 11 362 habitantes (cuando debería ser de uno cada 5000). Un estudio realizado en el 2016 identificó que el 71,2 % de las personas adultas mayores que asistieron al servicio de odontología de la CCSS requieren algún tipo de prótesis dental y 25,0 % son totalmente edéntulas (CCSS, 2004). El marco jurídico nacional relacionado con la atención odontológica en el país es el siguiente: • Ley general de salud Nº 5395 (1973). Se establece el derecho a las prestaciones de la salud de la población y se menciona el acceso a exámenes dentales preventivos en escolares. • Ley orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica Nº 5784 (1975), artículo 4. • Ley del servicio social obligatorio para los profesionales en las ciencias de la salud Nº 7559 (1985).
Evidencia	Las estrategias de educación sobre salud bucal dirigidas por dentistas, docentes y pares son igualmente efectivas para mejorar el conocimiento sobre salud bucal y el estado de higiene bucal de los adolescentes. Sin embargo, la estrategia dirigida por pares es casi tan efectiva como la estrategia dirigida por el dentista y comparativamente más efectiva que las estrategias dirigidas por el maestro y las de autoaprendizaje para mejorar su comportamiento de salud bucal (Haleem et al., 2012). Los resultados del Estudio Multicéntrico en Latinoamérica de Nutrición y Salud (ELANS), publicado en el año 2018 en la revista "Nutrients", revelaron que el 80 % de las personas adultas costarricenses consumen más del 10 % del total de energía derivada de los azúcares agregados, lo cual supera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Lo anterior es preocupante ya que, la reducción de su consumo como parte de una dieta saludable ayuda a disminuir la caries, la diabetes, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles (ENT). La Política Nacional de Salud establece que todo escolar deberá someterse a los exámenes dentales preventivos, participar en los programas educativos sobre salud que deberán ofrecer los centros educativos tanto públicos como privados. Por otra parte, algunos de los actuales objetivos de la Política Nacional de Salud Bucal incluyen el subsanar las desigualdades sanitarias dentro de una estrategia integral que tome en cuenta los factores de riesgo comunes y los determinantes fundamentales de la salud, esto basado en la promoción de una mejor salud bucal (Ministerio de Salud [MINSA], 2022). Por su parte, la última Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 evidenció en sus resultados que en el grupo entre 1-6 años el promedio de piezas dentales cariadas, extraídas y obturadas es de 2,2; siendo los dientes cariados la mayor cantidad, especialmente en la zona rural, lo que evidencia problemas de acceso a prevención y tratamiento. En la población de siete a 12 años se mostró que la severidad de piezas dentales cariadas, perdidas y obturadas fue de 1,43, a expensas de que las piezas obturadas representan la mayoría, siendo ambas condiciones totalmente prevenibles (MINSA, 2022). La implementación de políticas de promoción y prevención de la salud bucodental desde temprana edad permiten lograr niveles ideales a la edad de 12 años y estos se podrían mantener estables a través de toda la vida del individuo. Esto justifica ampliamente la aplicación de medidas preventivas como la educación en salud oral, la detección, valoración y control de placa bacteriana en la población preescolar, de manera que se han creado objetivos y estrategias donde la CCSS como parte de sector salud esta implícita (MINSA, 2022).
Consideraciones de Implementación	<u>Limitaciones</u>: En lugares donde no existe señal para conectarse al internet no se puede llenar información en EDUS. Eventualidades en el EDUS que no permitan verificar si el paciente consulta de primera vez o subsecuente hace que se incrementen en forma irreal las coberturas porque se ingresan como de primera vez. <u>Estrategias</u>: Para solventar esta situación se registra en físico y en la sede del área o su lugar de trabajo se ingresan a EDUS.
Normativa Técnica	• Norma de prestaciones odontológicas (1997). CCSS. • Norma para la atención preventiva en salud oral CEN-CINAI (2014) (PS.DN.UNAT.AID.ODONT. N.01) • Protocolos para la atención clínica en red específicos de la CCSS: trastornos temporomandibulares y dolor orofacial (2019).

	• Protocolos para la atención clínica en red específicos de la CCSS: operatoria dental, cirugía ortognática, ortopedia funcional correctiva, interceptiva y preventiva, cirugía oral menor mayor y maxilofacial y periodoncia (2020). • Instrucción de trabajo para regreso ordinario en los servicios de odontología de los tres niveles de atención de la CCSS" (2022), código IT.GM.DDSS. ARSDT.OD.21112022.
Costo / Efectividad	Evaluando la efectividad clínica y la rentabilidad de los programas de promoción de la salud bucal, para reducir los dientes cariados, perdidos u obturados (CPOD) y al mismo tiempo reducir el costo financiero para las instituciones de salud, se verificaron revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA), lo que demostró eficacia para reducir el costo y confirmó un efecto de reducción en el CPOD infantil. (Fraihat et al., 2019). Se realizaron dos intervenciones, una con acciones básicas educativo-preventivas-curativas masivas (IMCCD) y otra con acciones intensivas según el grado de riesgo (IRCCD). Se analizó el costo-efectividad para estas alternativas. La IRCCD fue la alternativa más efectiva en la prevención de la caries dental con 95 % de casos prevenidos/año y la menos costosa en total con $ 1 824 (costo promedio de $ 8,4 paciente/año). El menor costo y el mayor número de casos prevenidos en la IRCCD, la hicieron más eficiente con un costo de $ 8,8 dólares por caso prevenido/año (Gispert et al., 2015).
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar el porcentaje de personas que tienen acceso a los servicios de odontología, a los cuales se les brinda atención preventiva y curativa, para fomentar la salud bucodental y disminuir el riesgo de múltiples enfermedades sistémicas
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la variación interanual en la cobertura de atención de personas atendidas en odontología del primer nivel de atención en salud? ¿Cuál es el porcentaje de personas atendidas en odontología del primer nivel de atención que recibe educación en salud bucodental y acciones de prevención de las enfermedades bucodentales? ¿Cuál es el estado y progresión de la enfermedad dental en las personas que consultan en el primer nivel de atención en salud?
Indicadores asociados a la intervención	02-01-1.0 Cobertura de atención en salud oral a personas de 20 años a 64 años, en el primer nivel de atención. 02-02-1.0 Cobertura de atención en salud oral a personas de 65 años y más en el primer nivel de atención. 02-03-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 0 a 9 años, en el primer nivel de atención. 02-04-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 10 a 19 años, en el primer nivel de atención. 02-05-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 20 a 64 años, en el primer nivel de atención. 02-06-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 65 años y más en el primer nivel de atención.
Anexos	Manual del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología (2022). Actualización IT.GM.DDSS. ARSDT-OD-200720 Versión 02.
Referencias Bibliográficas	Anstey, E., Bradley, C., Shimbo, D. (2021). USPSTF Recommendation Statement on Hypertension Screening in Adults—Where Do We Go From Here? *JAMA Netw Open*, *4*(4). doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.4203 Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2004). Plan Nacional de Atención en Salud Bucodental. San José. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018). Plan Estratégico Institucional 2019-2022. CENDEISSS. https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATÉGICO-INSTITUCIONAL-2019-2022.pdf Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, tercera encuesta 2018. San Jose: EDNASS-CCSS. Carvajal, P. (2016). Enfermedades periodontales como un problema de salud pública: el desafío del nivel primario de atención en salud. *Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral*, *9*(2), 177-183. https://dx.doi.org/10.1016/j.piro.2016.07.001 Castro, L. P., Soria, I. C., Casco, E. C., & Vallejo, M. D. (2016). Análisis de costo-efectividad e impacto presupuestal de un programa de atención farmacéutica para pacientes hipertensos de un hospital de tercer nivel de México. *Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas*, 25.

Fraihat, N., Madae'en, S., Bencze, Z., Herczeg, A., & Varga, O. (2019). Clinical Effectiveness and Cost-Effectiveness of Oral-Health Promotion in Dental Caries Prevention among Children: Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16*(15), 2668. https://doi.org/10.3390/ijerph16152668

Gispert, E., Collazo, M., & Sosa, I. (2015). Evaluación económica de dos intervenciones para el control de caries dental en escolares de primaria en Cuba. *Ciencia Odontológica*, *12*(2). https://produccioncientificaluz.org/index.php/cienciao/article/view/33802

Haleem, A., Siddiqui, M.I. & Khan, A.A. (2012). School-based strategies for oral health education of adolescents-a cluster randomized controlled trial. *BMC Oral Health*, *12*(54). https://doi.org/10.1186/1472-6831-12-54

Hettiarachchi, R. M., Kularatna, S., Downes, M. J., Byrnes, J., Kroon, J., Lalloo, R., Johnson, N. W., & Scuffham, P. A. (2018). The cost-effectiveness of oral health interventions: A systematic review of cost-utility analyses. *Community dentistry and oral epidemiology*, *46*(2), 118–124. https://doi.org/10.1111/cdoe.12336

Ministerio de Salud [MINSA]. (2022). Política Nacional de Salud Bucal 2022-2032. MINSA.

Ministerio de Salud de Costa Rica. (17 de mayo de 2023). *Medí tu presión arterial con precisión, contrólala, viví más*. Ministerio de Salud Gobierno de Costa Rica. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1592-casos-notificados-de-hipertension-arterial-disminuyen-un-19-6-durante-2022#:~:text=Sin%20embargo%2C%20las%20defunciones%20asociadas,muertes%20asociadas%20a%20esta%20enfermedad.

Organización Mundial de la Salud. (2022). Directriz para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en adultos. Organización Mundial de la Salud. https://iris.who.int/handle/10665/364491

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (18 de noviembre de 2022). La OMS destaca que el descuido de la salud bucodental afecta a casi la mitad de la población mundial. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news/item/18-11-2022-who-highlights-oral-health-neglect-affecting-nearly-half-of-the-world-s-population

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (21 de agosto de 2023). Hipertensión. OPS. https://www.paho.org/es/temas/hipertension

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (s.f.). La OMS mantiene su firme compromiso con los principios establecidos en el preámbulo de la Constitución https://www.who.int/es/about/governance/constitution

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (15 de marzo de 2022). Salud bucodental. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

Zhao, J., Shi, H., Wang, J., Huang, R., Liu, Y., Zhang, Y., Jiang, N., Wang, T., Wang, J., Xu, X. (2022). Association of oral health knowledge, self-efficacy and behaviours with oral health-related quality of life in Chinese primary school children: a cross-sectional study. *BMJ Open*, *12*(12). doi: 10.1136/bmjopen-2022-062170

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 02-01-1.0 02-02-1.0

Elemento	Descripción	
Código	02-01-1.0 02-02-1.0	
Nombre	Cobertura de atención en salud oral	
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas que presentan una atención en salud oral de primera vez en los servicios de odontología, en relación con la cantidad de personas de ese grupo de edad de la estructura poblacional. La atención en salud oral comprende las siguientes prestaciones (Artículo 22º. Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS): • Promoción de salud dental. • Atención clínica preventiva y curativa. Incluye: • Atenciones en salud oral de primera vez en los servicios de odontología general, en el periodo. En los siguientes grupos de edad: ◦ 20 a 64 años ◦ 65 años y más Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas con atención en salud oral de primera vez en los servicios de odontología general según grupo de edad, en el periodo. • Número de personas según grupo de edad de la estructura poblacional.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas con atención en salud oral de primera vez en los servicios de odontología general según grupo de edad, en el periodo}}{\text{Número de personas según grupo de edad de la estructura poblacional}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud Bucodental
Línea base	20 a 64 años: 10 % 65 años y más: 10 %	
Meta	Quinquenal: (Meta consensuada por la comisión central de odontología con supervisores de Red de odontología) 20 a 64 años: 11 % 65 años y más: 11 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo Atenciones): • Cantidad de atenciones. Dirección Actuarial y Económica: • Población estimada de la estructura poblacional del periodo con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), según grupo de edad.	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreo). • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual).	
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Índice de Salud Bucodental (ISBD). • Índice de Riesgo Bucodental (IRBD). • Índice de Perdida Bucodental (IPBD).	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 02-03-1.0 02-04-1.0 02-05-1.0 02-06-1.0

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Código</td><td colspan="2">02-03-1.0 02-04-1.0 02-05-1.0 02-06-1.0</td></tr>
<tr><td>Nombre</td><td colspan="2">Porcentaje de atenciones en salud oral en las que se brinda educación en salud oral preventiva por grupo de edad</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Corresponde al porcentaje de atenciones en salud oral (de primera vez y subsecuentes), en las que se brinda educación en salud oral (código diagnóstico CIE-10: Z719, “Consejos en salud”), en relación con el total de atenciones en salud oral brindadas en el periodo, por grupo de edad.
La atención en salud oral comprende las siguientes prestaciones (Artículo 22º. Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS):
• Promoción de salud dental
• Atención clínica preventiva y curativa
<u>Educación en salud oral:</u> consiste en el fortalecimiento y promoción de la salud, prevención de aparición de patologías orales, definición de los diagnósticos presentes en el usuario, instrucciones de fisioterapia oral, cuidados personales en el hogar, prevención y mitigación del daño de las patologías presentes, cuidado de aparatología, alimentación saludable y cuidados postoperatorios afines al tratamiento, entre otros.
Incluye:
• Atenciones en salud oral (de primera vez y subsecuentes), brindadas en los servicios de odontología general, según los siguientes grupos de edad, en el periodo:
  • 0 a 9 años
  • 10 a 19 años
  • 20 a 64 años
  • 65 y más años
Excluye:
• No Aplica</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Número de atenciones en salud oral realizadas en los servicios de odontología general a los que se les brinda educación en salud oral según grupo de edad, en el periodo.
• Número de atenciones en salud oral realizadas en los servicios de odontología general, según grupo de edad, en el periodo.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\text{Número de atenciones en salud oral realizadas en los servicios de odontología general a los que se les brinda educación en salud oral, en el periodo}}{\text{Número de atenciones en salud oral realizadas en los servicios de odontología general, en el periodo}} \times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Salud Bucodental</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">No hay línea de base</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="2">Quinquenal (Meta consensuada por Comisión Central de Odontología, con supervisores de Red de odontología).
<table><tr><th>Grupo de edad (años)</th><th>Meta (%)</th></tr><tr><td>0 a 9</td><td>80</td></tr><tr><td>10 a 19</td><td>80</td></tr><tr><td>20 a 64</td><td>75</td></tr><tr><td>65 y más</td><td>73</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo de atenciones):
• Atenciones realizadas.
• Educación brindada.</td></tr>
</table>

Clasificación	Indicador de Proceso
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreo). • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención.
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Índice de Salud Bucodental (ISBD). • Índice de Riesgo Bucodental (IRBD). • Índice de Perdida Bucodental (IPBD).

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	• Cobertura de atención en salud oral en la persona adulta. • Cobertura de atención en salud oral en la persona adulta mayor. • Porcentaje de atenciones en salud oral en las que se brinda educación en salud oral preventiva por grupo de edad.	
Indicador Complementario	Índice de Salud Bucodental (ISBD) (V-1.0)	
Definición conceptual	Corresponde a la proporción de la población que recibe atención en salud oral de primera vez en los servicios de odontología y que presenta la siguiente condición: Pieza Dental Sana, Pieza Sellada, Pieza Obturada, Planos Cráneo faciales sin Alteraciones, Periodontal Sano y Periodonto Sano Reducido. (Las definiciones y fórmula de cálculo de la prevalencia de cada una de las condiciones se encuentran en el documento "Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología (SIVEO 2022), del Área de Regulación Sistematización, Diagnóstico y Tratamiento- Odontología (ARSDT-O)". Actualización IT.GM.DDSS. ARSDT-OD-200720 Versión 02). El ISBD se obtiene los datos mediante un muestreo estratificado, la muestra se calcula según la población estimada para el área de salud según subgrupos por edad. A los sujetos de esta muestra los odontólogos les deben registrar los datos que permiten calcular las prevalencias, esto se lleva a cabo entre los meses de marzo a agosto del año en evaluación. Si el ISBD se encuentra por encima del valor de salud bucodental del año anterior, se considera que el cambio es positivo, si se encuentra por debajo del valor se considera que el cambio es negativo. Cuando no se llega a la muestra mínima requerida según la estructura poblacional asignada al área de salud los índices no son calculables, por lo que para fines de evaluación se tomará como que esta población presenta un cambio negativo, al no poder identificar cuáles son sus prevalencias actuales. La atención en salud oral comprende las siguientes prestaciones (Artículo 22º. Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS): • Promoción de salud dental • Atención clínica preventiva y curativa Incluye: • Población con atención en salud oral en los servicios de odontología general entre los meses de marzo a agosto del año evaluado. Excluye: No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Prevalencias de Pieza Dental Sana. • Prevalencias de Pieza Sellada. • Prevalencias de Pieza Obturada.	• Planos Cráneo faciales sin Alteraciones. • Periodonto Sano. • Periodonto Sano Reducido.
Fórmula de cálculo	Prevalencia Pieza Dental Sana + Prevalencia Pieza Sellada + Prevalencia Pieza Obturada + Prevalencia Planos Cráneo faciales sin Alteraciones + Prevalencia Periodonto Sano + Prevalencia Periodonto Sano Reducido	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud Bucodental
Línea base	1,65 (2022)	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Área de Regulación Sistematización, Diagnóstico y Tratamiento – Odontología (ARSDT-O), emite la certificación en la última semana de noviembre de cada año.	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud	
Comentarios generales	No aplica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	• Cobertura de atención en salud oral en la persona adulta. • Cobertura de atención en salud oral en la persona adulta mayor. • Porcentaje de atención en salud oral en las que se brinda educación en salud oral preventiva por grupo de edad.	
Indicador Complementario	Índice Pérdida Bucodental (IPBD) (V-1.0)	
Definición conceptual	Corresponde a la proporción de la población que recibe atención en salud oral de primera vez en los servicios de odontología y que presenta la siguiente condición: Pieza Dental Pérdida por Caries, Pieza Dental Pérdida por Enfermedad Periodontal. (Las definiciones y fórmula de cálculo se encuentran en el documento "Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología (SIVEO 2022), del Área de Regulación Sistematización, Diagnóstico y Tratamiento - Odontología (ARSDT-O)". Actualización IT.GM.DDSS. ARSDT-OD-200720 Versión 02). El IPBD se obtiene los datos mediante un muestreo estratificado, la muestra se calcula según la población estimada para el área de salud según subgrupos por edad. A los sujetos de esta muestra los odontólogos les deben registrar los datos que permiten calcular las prevalencias, esto se lleva a cabo entre los meses de marzo a agosto del año en evaluación. Si el IPBD se encuentra por encima del valor de pérdida del año anterior, se considera que el cambio es negativo, si se encuentra por debajo del valor, se considera que el cambio es positivo. Cuando no se llega a la muestra mínima requerida según la estructura poblacional asignada al área de salud los índices no son calculables, por lo que para fines de evaluación se tomará como que esta población presenta un cambio negativo, al no poder identificar cuáles son sus prevalencias actuales. La atención en salud oral comprende las siguientes prestaciones (Artículo 22º. Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS): • Promoción de salud dental • Atención clínica preventiva y curativa Incluye: • Población con atención en salud oral en los servicios de odontología general entre los meses de marzo a agosto del año evaluado. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Prevalencias de Pieza Dental Perdida por Caries • Prevalencias de Pieza Dental Perdida por Enfermedad Periodontal	
Fórmula de cálculo	Prevalencia Pieza Perdida por Caries + Prevalencia Pieza Perdida por Enfermedad Periodontal.	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud Bucodental
Línea base	0,31 (2022)	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Área de Regulación Sistematización, Diagnóstico y Tratamiento – Odontología (ARSDT-O), emite la certificación en la última semana de noviembre de cada año.	
Clasificación	Indicador de resultado	
Presentación de resultados	Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención	
Comentarios generales	No aplica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	• Cobertura de atención en salud oral en la persona adulta. • Cobertura de atención en salud oral en la persona adulta mayor. • Porcentaje de atenciones en salud oral en las que se brinda educación en salud oral preventiva por grupo de edad.	
Indicador Complementario	Índice de Riesgo Bucodental (IRBD) (V-1.0)	
Definición conceptual	Corresponde a la proporción de la población que recibe atención en salud oral de primera vez en los servicios de odontología y que presenta la siguiente condición: Pieza Dental Cariada, Planos Cráneo faciales con alteración y Tejido Periodontal Enfermo. (Las definiciones se encuentran en el documento "Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología (SIVEO 2022), del Área de Regulación Sistematización, Diagnóstico y Tratamiento - Odontología (ARSDT-O)". Actualización IT.GM.DDSS. ARSDT-OD-200720 Versión 02). El IRBD se obtiene los datos mediante un muestreo estratificado, la muestra se calcula según la población estimada para el área de salud según subgrupos por edad. A los sujetos de esta muestra los odontólogos les deben registrar los datos que permiten calcular las prevalencias, esto se lleva a cabo entre los meses de marzo a agosto del año en evaluación. Si el IRBD se encuentra por encima del valor de riesgo del año anterior, se considera que el cambio es negativo, si se encuentra por debajo del valor, se considera que el cambio es positivo. Cuando no se llega a la muestra mínima requerida según la estructura poblacional asignada al área de salud los índices no son calculables, por lo que para fines de evaluación se tomará como que esta población presenta un cambio negativo, al no poder identificar cuáles son sus prevalencias actuales. La atención en salud oral comprende las siguientes prestaciones (Artículo 22º. Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS): • Promoción de salud dental • Atención clínica preventiva y curativa Incluye: • Población con atención en salud oral en los servicios de odontología general entre los meses de marzo a agosto del año evaluado. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Prevalencias de Pieza Dental Cariada. • Prevalencias de Alteración de Planos Craneofaciales Sagital, Vertical, Horizontal.	• Prevalencias de Apiñamiento Dental • Prevalencias de Gingivitis. • Prevalencias de Periodontitis.
Fórmula de cálculo	Prevalencia Cariada + Alteración de Planos Craneofaciales Sagital + Alteración de Planos Craneofaciales Vertical + Alteración de Planos Craneofaciales Horizontal + Prevalencia Gingivitis + Prevalencia Periodontitis.	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Salud Bucodental
Línea base	0,47 (2022)	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	El Área de Regulación Sistematización, Diagnóstico y Tratamiento – Odontología (ARSDT-O), emite la certificación en la última semana de noviembre de cada año.	
Clasificación	Indicador de resultado	
Presentación de resultados	Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud	
Comentarios generales	No aplica	

03-SALUD DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

INTERVENCIÓN – PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN LA POBLACIÓN INFANTIL

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La anemia por deficiencia de hierro (ADH) es la carencia nutricional más común en el mundo. Es un problema de salud pública que afecta principalmente a niños pequeños (20 %), embarazadas (37 %) y mujeres entre los 15 y 49 años (37 %), principalmente por tratarse de poblaciones que se encuentran en una etapa en donde la demanda de hierro puede llegar a superar la ingesta de hierro en la dieta (Moscheo et al., 2022; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Se ha visto en diferentes estudios, que la ADH en edades tempranas (menores de tres años) puede generar problemas en el desarrollo neuronal y cognitivo, los cuales dependiendo de la severidad pueden ser revertidos con el tratamiento oral con hierro (Leung et al. 2023). Por otra parte, la anemia en población infantil de tres años en adelante puede manifestarse con síntomas como palidez, cansancio, disnea, problemas de concentración y disminución de la productividad, entre otros; todos síntomas que podrían afectar en el desempeño escolar de esta población (Gallagher, 2022; Sari, P. et al., 2022) Sobre la anemia en la adolescencia, se ha encontrado que en estas edades hay un segundo pico para la ADH producto del crecimiento acelerado, la menstruación y dietas deficientes en hierro (Janus y Moerschel, 2010). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece entre sus metas 2025 reducir la anemia en las mujeres en edad fértil en un 50 %, por lo que se recomiendan intervenciones que busquen la prevención temprana de la anemia en las adolescentes (OMS, 2017). De acuerdo con el Ministerio de Salud de Costa Rica, para el año 2020 alrededor de un 22 % de los hogares con población menor de cinco años presentaron inseguridad alimentaria nutricional, lo cual significa que se vieron obligados a disminuir la cantidad o la calidad de los alimentos por falta de recursos, aumentando el riesgo de malnutrición infantil (Ministerio de Salud [MINSA], 2020). A nivel institucional, el cálculo de la proporción de niños con anemia en la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud ha permitido establecer cómo se encuentra la anemia como problema de Salud Pública (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2023). En las últimas tres evaluaciones se ha encontrado que esta proporción ha venido incrementando. Actualmente la institución presenta una proporción de niños con anemia del 28 %, clasificada como Problema de Salud Pública Moderado, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, dos de las Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud, la Huetar Norte y la Huetar Atlántica, actualmente presentan proporciones clasificadas como problema de salud pública severo (40 % y 46 % respectivamente) (CCSS, 2023).
Evidencia	La American Academy of Pediatrics (AAP) recomienda que se realice el tamizaje universal para anemia por deficiencia de hierro en el grupo de menores de un año (American Academy of Pediatrics, 2010; Leung et al. 2023). El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC- siglas en inglés), recomienda realizar el tamizaje para anemia cada cinco a 10 años en mujeres no embarazadas iniciando en la adolescencia (DynaMed, 2023). Con respecto al abordaje de la anemia por deficiencia de hierro, AAP recomienda que cuando las necesidades de hierro no han logrado ser suplidas por la ingesta de la dieta es necesario suministrar el suplemento con hierro. Asimismo, los estudios recomiendan administración oral de hierro a una dosis de 3 a 6 mg/kg por día (AAP, 2010; Leung et al. 2023).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso sobre el manejo adecuado de la ADH. Mitos de los padres sobre el tratamiento con hierro y desinterés por los controles. Zonas de difícil acceso geográfico. Capacidad instalada de los servicios de laboratorio para suplir las necesidades de la población. Estrategias:

	Capacitación al personal. Educación a los padres sobre la importancia del tratamiento de la ADH. Contar con el acceso a los resultados de laboratorio en línea. Programación de citas en el servicio de laboratorio para los controles.
Normativa Técnica	Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.31032023 Diagnóstico y manejo de anemia ferropénica en niñas y niños en el primer nivel de atención (CCSS, 2023)
Costo / Efectividad	Se ha encontrado que las intervenciones para enfrentar la deficiencia de hierro son costo/efectivas y están altamente recomendadas sobre todo considerando la evidencia de los efectos que tiene la enfermedad en la niñez y adolescencia (Carsley, S. et al., 2019).
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar la detección y abordaje oportuno de la anemia por deficiencia de hierro en la población infantil y preadolescente, con el fin de establecer estrategias dirigidas a la prevención de complicaciones, tales como deficiencia en el desarrollo neuro funcional y retraso en el crecimiento en edades tempranas, afectación en el desempeño académico, así como problemas del sistema inmune y desórdenes en la salud reproductiva, entre otras, en la población preadolescentes.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es el acceso efectivo de la población infantil al tamizaje para anemia por deficiencia de hierro? ¿Cuál es la situación actual del país sobre la anemia por deficiencia de hierro como problema de salud pública? ¿Cuál es la efectividad del abordaje de la población infantil con anemia por deficiencia de hierro?
Indicadores asociados a la intervención	03-01-1.0 Tamizaje oportuno para la anemia por deficiencia de hierro de la población de seis a menos de 10 meses. 03-02-1.0 Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro resuelta. 03-03-1.0 Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro resuelta.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	American Academy of Pediatrics. (2010). Clinical report on diagnosis and prevention or iron deficiency and iron deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics. http://pediatrics.aappublications.org/content/126/5/1040.long Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2022. …a pesar del ciberataque a la institución. CCSS, Gerencia Médica, Dirección de Compra de Servicios de Salud. https://viewer.joomag.com/informe-epss-2021/0845721001633720986?short& Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). *Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.31032023 Diagnóstico y manejo de anemia ferropénica en niñas y niños en el primer nivel de atención*. San José, Costa Rica: CCSS. Carsley, S., Fu, R., Borkhoff, C. M., Reid, N., Baginska, E., Birken, C. S., Maguire, J. L., Hancock-Howard, R., Parkin, P. C., & Coyte, P. C. (2019). Iron deficiency screening for children at 18 months: a cost-utility analysis. *CMAJ open*, *7*(4), E689–E698. https://doi.org/10.9778/cmajo.20190084 DynaMed (3 de octubre 2023). Iron Deficiency Anemia in Children. EBSCO Information Services. https://www.dynamed.com/condition/iron-deficiency-anemia-in-children Gallagher P. G. (2022). Anemia in the pediatric patient. Blood, *140*(6), 571–593. https://doi.org/10.1182/blood.2020006479 Janus, J., & Moerschel, S. K. (2010). Evaluation of anemia in children. *American family physician*, *81*(12), 1462–1471. https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2010/0615/p1462.pdf Leung, A. K. C., Lam, J., Wong, A. H. C., Hon, K. L., & Li, X. (2023). Iron deficiency anemia: An updated review. Current pediatric reviews, https://doi.org/10.2174/1573396320666230727102042 Ministerio de Salud [MINSA]. (2020). *Prevalencias de inseguridad alimentaria en Costa Rica. Año 2020.* MINSA. Moscheo, C., Licciardello, M., Samperi, P., La Spina, M., Di Cataldo, A., & Russo, G. (2022). New insights into iron deficiency anemia in children: a practical review. *Metabolites*, *12*(4), 289. https://doi.org/10.3390/metabo12040289 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). Anemia. https://www.who.int/es/health-topics/anaemia#tab=tab_1

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2017). Metas Mundiales de Nutrición 2025. Documento normativo sobre anemia. https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.4

Sari, P., Herawati, D. M. D., Dhamayanti, M., & Hilmanto, D. (2022). Fundamental Aspects of the Development of a Model of an Integrated Health Care System for the Prevention of Iron Deficiency Anemia among Adolescent Girls: A Qualitative Study. *International journal of environmental research and public health*, *19*(21), 13811. https://doi.org/10.3390/ijerph192113811

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 03-01-2.0

+Elemento	Descripción	
Código	03-01-2.0	
Nombre	Tamizaje oportuno para la anemia por deficiencia de hierro de la población de seis a menos de 10 meses.	
Definición conceptual	Porcentaje de la población de seis a menos de 10 meses que consultaron, a quienes se les realiza una hemoglobina con el fin de detectar oportunamente la anemia por deficiencia de hierro. • Tamizaje oportuno de anemia: Realización de una hemoglobina entre los cinco meses 21 días y los nueve meses 29 días de edad. Incluye: • Consultas de primera vez en el año de la población de seis a menos de 10 meses. • Pruebas de laboratorio clínico (hemoglobinas) del año anterior y el periodo evaluado, realizadas en el rango de edad y que cuenten con fecha de toma de la muestra y resultado. Excluye: • Menores tamizados oportunamente en el año anterior.	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno de anemia en el periodo. • Número de menores de seis a menos de 10 meses atendidos por primera vez en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno de anemia en el periodo}}{\text{Número de menores de seis a menos de 10 meses atendidos por primera vez en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	64 %	
Meta	Quinquenal: 85 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de primera vez en el año (edad entre los seis y nueve meses 29 días). • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los cinco meses 21 días y los nueve meses 29 días.	
Clasificación	Indicador de proceso	

Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Proporción de la población de seis a menos de 10 meses con anemia. • Porcentaje de la población de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno con resultado de hemoglobina < 11g/dL y sin diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 03-02-1.0

Elemento	Descripción	
Código	03-02-1.0	
Nombre	Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro resuelta.	
Definición conceptual	Porcentaje de menores de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro que en un hemograma de control realizado oportunamente han resuelto su anemia, con el fin de prevenir o mitigar las posibles complicaciones que se pueden presentar por la deficiencia de hierro en edades tempranas. • Hemograma de control oportuno: Realización de una hemoglobina cuatro meses posteriores (entre los 120 y 149 días) a la fecha del diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resolución de la anemia: cuando en el hemograma de control realizado de forma oportuna se reporta un resultado de hemoglobina ≥ 11g/dL. Incluye: • Consultas de la población infantil de seis a menos de 24 meses a quienes se les registró el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro entre 148 días antes del inicio del periodo evaluado y 149 días antes de la finalización del periodo evaluado (Por ejemplo: entre el 5 agosto del año anterior y el 4 agosto del año evaluado). Estos son los pacientes a los que les corresponde realizarse la hemoglobina de control durante el periodo evaluado. Diagnóstico de anemia código CIE-10: D50 Anemia por deficiencia de hierro registrado en las atenciones de consulta externa. • Pruebas de laboratorio clínico para el control (hemoglobinas) realizadas durante el periodo evaluado y que tengan fecha de toma de la muestra y resultado. Excluye: • Población de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro y laboratorio de control, ambos en el año anterior.	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro con resolución de su anemia en el periodo. • Número de menores de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro con resolución de su anemia en el periodo}}{\text{Número de menores de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación del año 2024	
Meta	Quinquenal: En construcción	
Periodicidad	Anual	

Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de menores entre los seis y menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra y resultado, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los cinco meses 21 días y menos de 28 meses.
Clasificación	Indicador de resultado
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreo) • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje de la población de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemograma de control oportuno. • Porcentaje de población de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico < 11g/dL y en el rango de edad.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 03-03-2.0

Elemento	Descripción	
Código	03-03-2.0	
Nombre	Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro resuelta.	
Definición conceptual	Porcentaje de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro que en un hemograma de control realizado oportunamente han resuelto su anemia, con el fin de prevenir o mitigar las posibles complicaciones que se pueden presentar por la deficiencia de hierro en la adolescencia. • Hemograma de control oportuno: Realización de una hemoglobina cuatro meses posteriores (entre los 120 y 149 días) a la fecha del diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resolución de la anemia: cuando en el hemograma de control realizado de forma oportuna se reporta un resultado de hemoglobina ≥ 11,5 g/dL. Incluye: • Consultas de niñas de 10 años a quienes se les registró el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro 148 días previos al inicio del periodo evaluado y 149 días antes de la finalización del periodo evaluado (Por ejemplo: entre el 5 de agosto del año anterior y el 4 de agosto del año evaluado). Estas son las pacientes a las que les corresponde realizarse la hemoglobina de control durante el periodo evaluado. Diagnóstico de anemia código CIE-10: D50 Anemia por deficiencia de hierro registrado en las atenciones de consulta externa. • Pruebas de laboratorio clínico para el control (hemoglobinas) realizadas durante el periodo evaluado que cuente con resultado y fecha de toma de la muestra. Excluye: • Población de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro y laboratorio de control, ambos en el año anterior.	
Variables involucradas en la medición	• Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro con resolución de su anemia en el periodo. • Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo establecido.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro con resolución de su anemia en el periodo.}}{\text{Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo establecido}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación del año 2024	
Meta	Quinquenal: En construcción	

Periodicidad	Anual
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra y resultado, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los 10 años y 11 años cuatro meses.
Clasificación	Indicador de resultado
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreo). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de control oportuna. • Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro que cuentan con hemoglobina de diagnóstico < 11,5 g/dL.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Tamizaje oportuno para la anemia por deficiencia de hierro de la población de seis a menos de 10 meses.	
Indicador Complementario	Porcentaje de la población de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno con resultado de hemoglobina < 11g/dL y sin diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro (V-2.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de la población de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno de anemia cuyo resultado de la hemoglobina es < 11g/dL y no se les registra el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo evaluado. • Tamizaje oportuno de anemia: Realización de una hemoglobina entre los cinco meses 21 días y los nueve meses 29 días de edad. Incluye: • Consultas: Establecidas en el indicador de evaluación código 03-01-2.0 y menores de seis menos de 24 con registro del código CIE-10 "D50 Anemia por deficiencia de hierro" en las atenciones de consulta externa de enero a diciembre del periodo evaluado. • Pruebas de laboratorio clínico: Establecidos en el indicador de evaluación código 03-01-2.0 Excluye: • Establecidos en el indicador de evaluación código 03-01-2.0	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de seis a menos de 10 meses tamizados oportunamente con una hemoglobina < 11g/dL y sin diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo. • Número de menores de seis a menos de 10 meses con una hemoglobina < 11g/dL en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de seis a menos de 10 meses tamizados oportunamente con una hemoglobina < 11g/dL y sin diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo}}{\text{Número de menores de seis a menos de 10 meses con una hemoglobina < 11g/dL en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Periodicidad	Anual	

Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de primera vez en el año (edad entre los seis y nueve meses 29 días). • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los cinco meses 21 días y los nueve meses 29 días.
Clasificación	Indicador de proceso
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	No aplica

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Tamizaje oportuno para la anemia por deficiencia de hierro de la población de seis a menos de 10 meses.	
Indicador Complementario	Proporción de la población de seis a menos de 10 meses con anemia (V-2.0)	
Definición conceptual	Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno y que tienen un resultado de hemoglobina <11g/dL. • Tamizaje oportuno de anemia: Realización de una hemoglobina entre los cinco meses 21 días y los nueve meses 29 días de edad. Incluye: • Consultas: Definidas en el indicador de evaluación código 03-01-2.0 • Pruebas de laboratorio clínico: Definidos en el indicador de evaluación código 03-01-2.0 Excluye: • Definidos en el indicador de evaluación código 03-01-2.0	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno con hemoglobina <11g/dL en el periodo. • Número de menores de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno con hemoglobina <11g/dL en el periodo}}{\text{Número de menores de seis a menos de 10 meses con tamizaje oportuno en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención/Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Cubo DCSS EPSS-Tamizajes • Consultas de primera vez en el año (edad entre los seis y nueve meses 29 días). • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los cinco meses 21 días y los nueve meses 29 días.	
Clasificación	Indicador de proceso	

Presentación de resultados	Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	No aplica

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro resuelta.	
Indicador Complementario	Porcentaje de la población de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemograma de control oportuno (V-1.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de la población de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro a quienes se les realiza el hemograma de control de forma oportuna. • Hemograma de control oportuno: Realización de una hemoglobina cuatro meses (entre los 120 y 149 días) posteriores a la fecha del diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Incluye: • Consultas: La definidas para el indicador de evaluación código 03-02-1.0 • Pruebas de laboratorio clínico: Los definidos para el indicador de evaluación código 03-02-1.0 Excluye: • Lo definido para el indicador de evaluación código 03-02-1.0	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemograma de control oportuno en el periodo. • Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemograma de control oportuno en el periodo}}{\text{Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención / Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de menores de seis y menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra y resultado, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los cinco meses 21 días y menos de 28 meses.	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 04

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro resuelta.	
Indicador Complementario	Porcentaje de población de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico < 11g/dL y en el rango de edad (V-1.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de población de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico < 11g/dL y realizada entre los cinco meses 21 días y menos de 24 meses. Incluye: • Consultas: Establecidas en el indicador de evaluación código 03-01-1.0 • Pruebas de laboratorio clínico: Establecidos en el indicador de evaluación código 03-01-1.0 Excluye: • Definido en el indicador de evaluación código 03-01-1.0	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico en el rango de edad y <11g/dL en el periodo. • Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro en el periodo evaluado.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico en el rango de edad y <11g/dL en el periodo}}{\text{Número de menores de seis a menos de 24 meses con anemia por deficiencia de hierro en el periodo evaluado}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de menores entre los seis y menos de 24 meses con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra y resultado, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los cinco meses 21 días y menos de 28 meses.	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 05

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro resuelta.	
Indicador Complementario	Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de control oportuna (V-2.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro a quienes se les realiza al menos un hemograma de control de forma oportuna. • Hemograma de control oportuno: Realización de una hemoglobina cuatro meses posteriores a la fecha del diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro (entre los 120 y 149 días). Incluye: • Consultas: Definidas en el indicador de evaluación código 03-03-2.0 • Pruebas de laboratorio clínico: Definidos en el indicador de evaluación código 03-03-2.0 Excluye: • Definido en el indicador de evaluación código 03-03-2.0	
Variables involucradas en la medición	• Número de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro con hemograma de control oportuno en el periodo. • Número de niñas con anemia por deficiencia de hierro en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro con hemograma de control oportuno en el periodo}}{\text{Número de niñas con anemia por deficiencia de hierro en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra y resultado, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas en edades entre los 10 años y 11 años cuatro meses.	

Clasificación	Indicador de proceso
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	No aplica

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 06

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro resuelta.	
Indicador Complementario	Porcentaje de niñas de 10 años con anemia por deficiencia de hierro que cuentan con hemoglobina de diagnóstico < 11,5 g/dL (V-2.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de niñas de 10 años a quienes se les registra el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro con una hemoglobina de diagnóstico < 11,5 g/dL. Incluye: • Consultas definidas en el indicador de evaluación código 03-03-2.0 • Pruebas de laboratorio clínico definidas en el indicador de evaluación código 03-03-2.0 Excluye: • Definido en el indicador de evaluación código 03-03-2.0	
Variables involucradas en la medición	• Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico <11,5 g/dL en el periodo. • Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro con hemoglobina de diagnóstico <11,5 g/dL en el periodo}}{\text{Número de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de niñas de 10 años con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. • Resultados de hemoglobinas que tengan fecha de toma de la muestra y resultado, registrados en el énfasis de niño sano. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de hemoglobinas realizadas durante el periodo evaluado.	
Clasificación	Indicador de proceso	

Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	No aplica

INTERVENCIÓN – PREVENCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	Las enfermedades cardiovasculares (ECV) se encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo con un aproximado de 17,9 millones de muertes al año (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). La enfermedad ateroesclerótica, es uno de los factores de riesgo asociados a las ECV y es una patología que se presenta de forma progresiva, iniciando su proceso desde la infancia (Arroyo et al., 2019). Es por esta razón, que se considera la dislipidemia en niños y adolescentes como uno de los factores de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares en la edad adulta (Noreña-Peña, et al., 2018; OMS, 2023). Por otra parte, se ha encontrado que en niños y adolescentes con obesidad existe una mayor prevalencia de la dislipidemia, la cual puede llegar hasta un 62 %, más del doble de la prevalencia máxima encontrada en esta misma población cuando el peso se encuentra en rangos normales (23 %) (Sharma, et al., 2019). La importancia de la detección temprana de las dislipidemias radica sobre todo en que existen intervenciones seguras y efectivas que permiten el abordaje de esta patología desde la infancia y en consecuencia llegar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares prematuras (Gidding S., et al., 2022; US Deparment of Health and Human Services [HHS], 2020). Como parte de estas intervenciones se ha establecido como primer paso el abordaje por nutrición y posteriormente por pediatría, según sea la severidad del problema (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2016; HHS, 2020). Por otro lado, cuando la dislipidemia se encuentra asociada a sobrepeso u obesidad, se encontró que es mucho más efectivo que, además de la dieta, se implemente un programa que busque el aumento de la actividad física (HHS, 2020).
Evidencia	El incremento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en edades tempranas ha llevado a un aumento en la cantidad de niños con dislipidemia, por lo que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos junto con el panel de expertos del Instituto Nacional del corazón, pulmones y sangre de Estados Unidos clasifican como altamente recomendado: • Tamizaje universal para la dislipidemia en niños entre los 9 y 11 años. • Tamizaje de dislipidemia en niños entre los dos y 8 años con obesidad. • Tamizaje de dislipidemia en adolescentes entre los 12 y 16 años con obesidad. Además, recomiendan un segundo tamizaje universal entre los 17 y 19 años (HHS, 2020) Por otra parte, un análisis de las políticas europeas para el tamizaje del hipercolesterolemia familiar infantil ha demostrado que el tamizaje universal de la dislipidemia permite identificar más del 90 % de las dislipidemias familiares (Gidding S., et al., 2022).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Capacidad instalada de los Servicios de laboratorio clínico para realizar el tamizaje de dislipidemia. Consultas en el rango de edad enfocadas a la atención de la morbilidad y desaprovechando la oportunidad del tamizaje. Desconocimiento de los padres y encargados sobre la detección temprana de la dislipidemia en niños y adolescentes. Estrategias: Implementación paulatina del tamizaje de dislipidemia en las nuevas poblaciones blanco. Capacitación al personal. Educación en los diferentes escenarios a los padres y encargados sobre la importancia del tamizaje dislipidemia.
Normativa Técnica	Manual de procedimientos para la atención integral del niño y la niña. Primer nivel de atención. Anexo 17 Manejo de sobrepeso y la obesidad en niñas y niños (CCSS, 2016).
Costo / Efectividad	Estudios en diferentes países europeos han demostrado que realizar el tamizaje universal de dislipidemia en niños es una intervención de bajo costo por caso, en donde incluso se puede llegar a incrementar hasta 11 años de vida saludable a las personas identificadas como dislipidémicas (Gidding S. et al., 2022).

Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar la detección de la dislipidemia en la población infantil y adolescentes, con el fin de establecer las estrategias pertinentes para la prevención de futuras enfermedades cardiovasculares.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es el acceso efectivo de la población infantil y adolescente al tamizaje de dislipidemia? ¿Cuáles son los grupos de riesgo identificados mediante el tamizaje de dislipidemia? ¿Cuál es la magnitud de los componentes del perfil de lípidos en alto riesgo según estado nutricional?
Indicadores asociados a la intervención	03-04-01.0 Porcentaje de población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia. 03-05-01.0 Porcentaje de población de dos a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por dislipidemia.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Arroyo Díez F.J., Romero Albillos J.A., & López Valero G.N. (2019). Dislipemias en edad pediátrica. *Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos en Pediatría*. *1*, 125-140. https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/08_dislipemias.pdf Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2016). *Manual de procedimientos para la atención del niño y la niña. Primer nivel de atención*. CCSS. Gidding, S. S., Wiegman, A., Groselj, U., Freiberger, T., Peretti, N., Dharmayat, K. I., ... & Geanta, M. (2022). Paediatric familial hypercholesterolaemia screening in Europe: public policy background and recommendations. European Journal of Preventive Cardiology, *29*(18), 2301-2311. https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac200 National Institutes of Health [NIH]. (2012). Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and adolescents. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/integrated-guidelines-for-cardiovascular-health-and-risk-reduction-in-children-and-adolescents Noreña-Peña, A., García de las Bayonas López, P., Sospedra López, I., Martínez-Sanz, J. M., & Martínez-Martínez, G. (2018). Dislipidemias en niños y adolescentes: factores determinantes y recomendaciones para su diagnóstico y manejo. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, *22*(1), 72-91. https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.22.1.373 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). *Enfermedades cardiovasculares.* OMS. https://www.who.int/es/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1 Sharma, V., Coleman, S., Nixon, J., Nixon, J., Sharples, L., Hamilton-Shield, J., Rutter, H., Bryant, M. (2019). A systematic review and meta-analysis estimating the population prevalence of comorbidities in children and adolescents aged 5 to 18 years. *Obesity Reviews, 20*, 1341–1349. https://doi.org/10.1111/obr.12904 US Department of Health and Human Services [HHS]. (2020). Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. https://www.hhs.gov/guidance/document/integrated-guidelines-cardiovascular-health-and-risk-reduction-children-and-adolescents

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 03-04-1.0

Elemento	Descripción	
Código	03-04-1.0	
Nombre	Porcentaje de población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia	
Definición conceptual	Porcentaje de la población entre nueve y 11 años con atención en el periodo evaluado, a quienes se les realiza al menos un perfil de lípidos completo en ese rango de edad, con el fin de detectar tempranamente la dislipidemia y gestionar las acciones necesarias para la prevención de futuras enfermedades cardiovasculares. • Tamizaje universal de dislipidemia: Realización de al menos un perfil de lípidos completo entre los nueve y 11 años, independientemente de los factores de riesgo cardiovasculares. • Perfil de lípidos completo: Perfil de lípidos cuyos componentes (Colesterol total, Colesterol HDL y Triglicéridos) cuentan con resultados realizados en la misma fecha. Incluye: • Consultas de población de nueve a 11 años con atención en el periodo definido: • Primera consulta en el periodo de la población de nueve a 11 años en la que se registre tanto el peso como la talla, ambos necesarios para el indicador complementario de estado nutricional. • Para la población en el rango de edad que no tenga registro de peso o de talla, se toma la primera consulta del año. • Pruebas de laboratorio clínico. Se toman en cuenta los perfiles de lípidos completos realizados tanto en el periodo evaluado como en periodos anteriores, que se encuentren en el rango de edad de nueve a 11 años y que tengan fecha de toma de la muestra y resultado. Excluye: • Población entre los nueve y 11 años tamizados por dislipidemia en años anteriores.	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de nueve a 11 años a quienes se les realiza el tamizaje universal de dislipidemia en el periodo. • Número de menores de nueve a 11 años atendidos en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de nueve a 11 años a quienes se les realiza el tamizaje universal de dislipidemia en el periodo}}{\text{Número de menores de nueve a 11 años atendidos en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	50 %	
Meta	Quinquenal: 59 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de menores con edades entre los 9 y 11 años 11 meses 29 días. • Resultados de perfiles de lípidos que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis correspondiente y realizados en edades entre los 9 y 11 años 11 meses 29 días. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de perfiles de lípidos realizados en edades entre los 9 y 11 años 11 meses 29 días (Colesterol total, HDL Colesterol, Triglicéridos).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	

Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje de población de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional. • Porcentaje de población de dos a 19 años con componentes del perfil de lípidos en alto riesgo. • Porcentaje de población de nueve a 11 años tamizados con al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo según clasificación del estado nutricional.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 03-05-1.0

Elemento	Descripción	
Código	03-05-1.0	
Nombre	Porcentaje de población de dos a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por dislipidemia	
Definición conceptual	Porcentaje de la población de dos a 19 años con obesidad atendidos en el periodo evaluado, a quienes se les realiza al menos un perfil de lípidos completo, con el fin de detectar tempranamente la dislipidemia y gestionar las acciones necesarias para la prevención de futuras enfermedades cardiovasculares. • Tamizaje de dislipidemia: Realización de al menos un perfil de lípidos completo en el periodo. • Perfil de lípidos completo: Perfil de lípidos cuyos componentes (Colesterol total, Colesterol HDL y Triglicéridos) cuentan con resultados realizados en la misma fecha. Obesidad [1]: • Población infantil de dos a cuatro años (cuatro años 11 meses 29 días), que según el "indicador peso/talla": P/T ≥ +3pZ. • Población de cinco a 19 años, según "indicador Índice de Masa Corporal", IMC ≥ +2pZ.ç Puntaje Z (pZ): consiste en especificar en qué medida un valor determinado se aparta de la mediana. Incluye: • Consultas de la población de dos a 19 años (19 años, 11meses y 29 días) con obesidad atendidos en el periodo evaluado: • Para establecer los casos con obesidad se emplea la primera consulta del año en la que se registre tanto el dato del peso como el de la talla. • Pruebas de laboratorio clínico (perfiles de lípidos) realizadas en el periodo en el rango de edad, que tengan fecha de toma de la muestra y resultado. Excluye: • Población entre dos y 19 años a los que no se les registre en ninguna consulta tanto el peso como la talla. • Población entre dos y 19 años con diagnóstico de dislipidemia en el periodo anterior al evaluado. (Código CIE-10: E78 Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias).	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos a quienes se les realiza el tamizaje de dislipidemia en el periodo. • Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos en el periodo.	
Fórmula de cálculo	• Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos a quienes se les realiza el tamizaje de dislipidemia en el periodo / Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos en el periodo x 100	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación del año 2024	
Meta	Quinquenal: En construcción	
Periodicidad	Anual	

Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de la población con edades entre los dos a 19 años. • Resultados de perfiles de lípidos que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis correspondiente. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de perfiles de lípidos realizados en edades entre los dos y los 19 años (Colesterol total, HDL Colesterol, Triglicéridos).
Clasificación	Indicador de proceso
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	(1) Rangos establecidos en el "Manual de procedimientos para la atención del niño y la niña. Primer nivel de atención" de la CCSS, 2016. Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje de población de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional. • Porcentaje de población de dos a 19 años con componentes del perfil de lípidos en alto riesgo.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Porcentaje de población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia	
Indicador Complementario	Porcentaje de población de nueve a 11 años tamizados con al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo según clasificación del estado nutricional (V-1.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de la población de nueve a 11 años tamizados con componentes del resultado del perfil en alto riesgo según clasificación del estado nutricional (sin clasificación, desnutrición, normal, sobrepeso, obesidad), con el fin de analizar su relación de riesgo. Incluye: • Consultas: Definidas en el indicador de evaluación código 03-04-1.0 • Estado nutricional: Definido en el indicador de evaluación código 03-04-1.0 • Pruebas de laboratorio clínico: Definidas en el indicador de evaluación código 03-04-1.0 • Componentes del perfil en alto riesgo: definidos en el indicador complementario "Porcentaje de población de dos a 19 años con componentes del perfil de lípidos en alto riesgo". Excluye: • Población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia con perfil de lípidos en rangos normales.	
Variables involucradas en la medición	• Número de menores de nueve a 11 años tamizados por dislipidemia con al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo según clasificación del estado nutricional en el periodo. • Número de menores de nueve a 11 años con al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de menores de nueve a 11 años tamizados por dislipidemia con al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo según clasificación del estado nutricional en el periodo}}{\text{Número de menores de nueve a 11 años con al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de menores con edades entre los 9 y 11 años 11 meses 29 días. • Resultados de perfiles de lípidos que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis correspondiente realizadas en edades entre los 9 y 11 años 11 meses 29 días. Sistemas de laboratorio (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de perfiles de lípidos realizados en edades entre los 9 y 11 años 11 meses 29 días (Colesterol total, HDL Colesterol, Triglicéridos).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	• Porcentaje de población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia. • Porcentaje de población de dos a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por dislipidemia.	
Indicador Complementario	Porcentaje de población de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional (V-1.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de población de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional, según las siguientes categorías: a) Sin clasificación b) Desnutrición c) Normal d) Sobre peso e) Obesidad. Incluye: • Primera consulta en el periodo de la población de dos a 19 años en la que se registre tanto el peso como la talla. Para la población en el rango de edad que no tengan registro de peso o de talla, se toma la primera consulta del año. • Estado nutricional: Definido en los indicadores de evaluación códigos 03-04-1.0 y 03-05-1.0 Excluye: • Definidos en los indicadores de evaluación códigos 03-04-1.0 y 03-05-1.0	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional en el periodo. • Número de personas de dos a 19 años atendidos en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional en el periodo}}{\text{Número de personas de dos a 19 años atendidos en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de la población con edades entre los dos y 19 años.	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td colspan="2">• Porcentaje de población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia.
• Porcentaje de población de dos a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por dislipidemia.</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td colspan="2">Porcentaje de población de dos a 19 años con componentes del perfil de lípidos en alto riesgo (V-1.0).</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Porcentaje de la población de dos a 19 años con tamizaje de dislipidemia y que tienen al menos un componente del perfil de lípidos en alto riesgo.
La clasificación de los componentes del perfil de lípidos según el riesgo se establece utilizando la información que se encuentra en el Manual de Procedimientos de Atención Integral al Niño y la Niña en el Primer Nivel de Atención, y definen los siguientes rangos:
<table>
<tr><th>Componentes del perfil lipídico</th><th>Normal[1]</th><th>Riesgo[1]</th><th>Alto riesgo[1]</th></tr>
<tr><td>Colesterol total</td><td><170</td><td>170-199</td><td>≥200</td></tr>
<tr><td>LDL-colesterol</td><td><110</td><td>110-129</td><td>≥130</td></tr>
<tr><td>HDL-colesterol</td><td>>45</td><td>40-45</td><td><40</td></tr>
<tr><td>Triglicéridos menores de 10 años</td><td><75</td><td>75-99</td><td>≥100</td></tr>
<tr><td>Triglicéridos edad de 10-19 años</td><td><90</td><td>90-129</td><td>≥130</td></tr>
</table>
[1] Cifras en mg/dL.
Incluye:
• Consultas de la población de dos a 19 años con tamizaje de dislipidemia en el periodo evaluado.
• Pruebas de laboratorio clínico: Definidas en los indicadores de evaluación códigos 03-04-1.0 y 03-05-1.0
Excluye:
• Definidos en los indicadores de evaluación códigos 03-04-1.0 y 03-05-1.0</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Número de personas de dos a 19 años con perfil de lípidos en alto riesgo según componente en el periodo.
• Número de personas de dos a 19 años con tamizaje de dislipidemia en el periodo.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\text{Número de personas de dos a 19 años perfil de lípidos en alto riesgo según componente en el periodo}}{\text{Número de personas de dos a 19 años con tamizaje de dislipidemia en el periodo}} \times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Niñez y Adolescencia</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Se define con el resultado de la evaluación 2024</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes):
• Consultas de la población con edades entre los dos y 19 años.
• Resultados de perfiles de lípidos que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis correspondiente y realizados entre los dos y 19 años.
Sistemas de laboratorio (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®):
• Resultados de perfiles de lípidos realizados en edades entre los dos y 19 años (Colesterol total, HDL Colesterol, Triglicéridos).</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos).
• Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

04-SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

INTERVENCIÓN – VALORACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La posibilidad de tener una expectativa de vida mayor en la población es una realidad por la que está pasando muchos países, esto gracias a los logros en los temas sociales y económicos. Sin embargo, el crecimiento de la población adulta mayor tiene un ritmo acelerado y este es mayor en los países en desarrollo (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2022). Ejemplo de esto es que a nivel mundial para el año 2020 la población de 60 años y más superaron los niños menores de 5 años; al término de la década 2020-2030 las personas de 60 años y más tendrá un aumento de 34 % y para el 2050 alcanzaría los 2 100 millones de personas. Siendo las regiones con mayor crecimiento África, América Latina y el Caribe y Asia, en donde se encontrarán casi el 80 % de las personas de este grupo etario (OPS, 2022). En el documento *Década del Envejecimiento Saludable* se sugiere que las personas mayores tengan una atención coordinada y centrada en la persona, con el objetivo de optimizar su capacidad funcional, además, la atención necesaria en caso de pérdida significativa de la capacidad intrínseca (OPS, 2022). El mantener a las personas de 60 años y más funcionales es un trabajo arduo ya que debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de este grupo, las inequidades, los estereotipos, el entorno y su propia perspectiva de funcionalidad; pero de lograr esta meta este grupo puede realizar contribuciones fundamentales a la sociedad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). Por su parte en Costa Rica el Ministerio de Salud (MINSA) creó la *Estrategia Nacional para el Envejecimiento saludable basado en el curso de vida 2018-2020* y su posterior actualización para los años 2022-2026. Dentro de esta última se encuentra un ámbito de actuación relacionado con esta intervención "prestar servicios de atención integrada y atención primaria de salud centrados en la persona, que respondan a las necesidades de las personas adultas mayores" (Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA], 2023), con la visión de que conforme se avanza en el curso de la vida, las necesidades en salud tienden a ser crónicas y complejas por lo que este tipo de atención se vuelve más eficaz que el tipo en donde se enfoca en enfermedades específicas. Desde el alcance que tiene la CCSS y para articularse con los documentos internacionales en el tema, se creó el *Protocolo de Atención clínica para la aplicación del énfasis a la persona adulta mayor en el Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES) para el Primer Nivel de Atención*, el cual tiene como objetivo que se valore la capacidad funcional de la persona adulta mayor desde el primer nivel de atención y que esta permita realizar un plan integral, integrado, continuado y articulado en red, todo lo anterior con el enfoque centrado en la persona. Respecto a la legislación en Costa Rica, existen varias leyes que se relacionan al tema, sin embargo, la Ley para la Persona Adulta Mayor (Nº 7935) es la que define acciones al MINSA para la atención integral a esta población y así garantizar el nivel óptimo del bienestar en todas sus esferas. La CCSS se alineó a esta ley desde 2016 y la integró en su plan de acción (MINSA, 2023).
Evidencia	El mantener y fomentar la capacidad funcional durante el curso de vida permite que las personas de 60 años y más tengan bienestar (OMS, 2015); sin embargo, para lograrlo se tiene que tomar en cuenta la capacidad funcional de la persona, que comprende todo lo relacionado con su salud y capacidad de tomar las decisiones importantes para ella; esta se encuentra muy relacionada con la capacidad intrínseca, que es la unión de las capacidades físicas y mentales; y por último se encuentra el entorno, el cual no es menos importante. La ubicación geográfica, el hogar, la comunidad y la sociedad juegan un papel muy importante para las capacidades anteriormente citadas. Por otra parte, al ver como la capacidad intrínseca se desarrolla permite evaluar a las personas y predecir sus posibles trayectorias (se mantiene o disminuye), con base en los datos relacionados con: los hábitos, características de salud, genética y factores personales (OMS, 2015). Esta evaluación de datos puede ayudar a realizar planes de acción para mitigar los efectos relacionados. Las evidencias encontrada son (U.S. Preventive Services TASK FORCE, s.f.): • Tamizaje de depresión en el adulto mayor (grado B). • Tamizaje de abuso de drogas (grado B). • Tamizaje por hipertensión arterial (grado A) • Consejería para promover la salud dietética y actividad física en personas con riesgo cardiovascular (grado B)

	• Intervenciones para la prevención de caídas en la comunidad (grado B).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Capacitación deficiente de los colaboradores asistenciales en el tema de adulto mayor y su valoración. Estrategias: Capacitación continua para los colaboradores asistenciales en el tema de adulto mayor y su valoración.
Normativa Técnica	• Protocolo de Atención clínica para la aplicación del énfasis a la persona adulta mayor en el Sistema Integrado de Expediente en salud (SIES) para el Primer Nivel de Atención. • Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable, Basado en el curso de vida 2022-2026.
Costo / Efectividad	El poder llegar a los 60 años o más no es sinónimo de enfermedad, y por tanto tampoco es de altos costos en servicios de salud, por lo que el enfoque en el curso de vida y mantenimiento de salud a esa edad es fundamental para tener una vejez saludable en donde se pueda contribuir a la sociedad (OPS, 2022). Las intervenciones que procuran una abordaje preventivo asociado a un enfoque: geriátrico, integral, sanitario y anticipado, son costo efectivas e implican actuaciones disponibles en el contexto de buenas prácticas en salud, que no requieren de tecnologías (Ministerio de Salud Pública de Uruguay, 2018). En diferentes estudios, la prevención y el tratamiento oportuno de la pérdida de la visión está entre las intervenciones de salud más costo-efectivas entre ellas está el grupo de catarata y retinopatía diabética en adulto mayor, al compararlo con otras patologías (Ministerio de Salud del Perú, 2013).
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar el porcentaje de personas de 65 años y más a las que se les atiende y tamiza por medio del énfasis de adulto mayor en el primer nivel de atención, para contribuir a mejorar las estrategias de acceso a los servicios de salud y valoración de riesgo, de manera que se pueda incidir en los factores protectores del envejecimiento y la salud, aplicando un enfoque de curso de vida.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la diferencia entre áreas de salud respecto a la cobertura de atención de personas de 65 años y más en el primer nivel de atención? ¿Cuál es el porcentaje de personas de 65 años y más a las que se le realizó el énfasis de adulto mayor en el primer nivel de atención y la diferencia entre áreas de salud? ¿Cuál es la variación interanual de la cobertura de personas de 65 años y más con atención bajo el énfasis de adulto mayor en el primer nivel de atención?
Indicadores asociados a la intervención	04-01-1.0 Cobertura de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Protocolo de Atención clínica para la aplicación del énfasis a la persona adulta mayor en el Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES) para el Primer Nivel de Atención. San José: CCSS. Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA]. (2023). Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable, basado en el curso de vida 2022-2026. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/ministerio-de-salud/planes-y-politicas-institucionales/planes-estrategicos-institucionales/5079-estrategia-nacional-para-un-envejecimiento-saludable-2018-2020/file Ministerio de Salud del Perú. (julio de 2013). Plan Estratégico Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera Evitable (2014-2021). https://www3.paho.org/per/images/stories/FtPage/2013/PlanENSOPC-RD-6julio2013_1v.pdf Ministerio de Salud Pública de Uruguay. (2018). Recomendaciones-Guía Nacional, Abordaje Integral de Caídas en el Adulto Mayor Prevención, Diagnóstico y Tratamiento. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-saludpublica/files/documentos/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20ca%C3%ADdas.pdf Organización Mundial de la Salud [OMS]. (29 de septiembre de 2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241565042 Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (14 de junio de 2022). Década del envejecimiento Saludable 2020-2030. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-proposal-final-apr2020rev-es.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_25&download=true U.S. Preventive Services TASK FORCE [USPSTF]. (s.f.). Recommendations. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/topic_search_results?searchterm=senior&topic_status=All&PAGE=1

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 04-01-1.0

Elemento	Descripción	
Código	04-01-1.0	
Nombre	Cobertura de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor.	
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas de 65 años y más que fueron atendidos a quienes se les aplicó el énfasis de Adulto Mayor completo, contenido en EDUS-SIES en alguna de las consultas del periodo, en relación con la cantidad de personas de este rango de edad de la pirámide poblacional estimada más reciente. Incluye: • Consultas de primera vez de personas de 65 años y más, en las áreas de salud del primer nivel durante periodo. Excluye: • Clínica la reforma.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 65 años y más atendidas con énfasis de adulto mayor completo en el periodo • Número de personas de 65 años y más de la pirámide poblacional	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 65 años y más atendidas con énfasis de adulto mayor completo en el periodo}}{\text{Número de personas de 65 años y más de la pirámide poblacional del periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Persona adulta mayor
Línea base	30 %	
Meta	Quinquenal: 33 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Reporte suministrado por el Área de Estadística y Salud (AES) de la CCSS: • Consultas de personas de 65 años y más con énfasis realizado. Dirección Actuarial y Económica (pirámide poblacional): • Población de 64 años de la pirámide poblacional del periodo con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo) • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor.	
Indicador Complementario	Cobertura de atención a personas de 65 años y más (V-1.0)	
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas de este grupo de 65 años y más que son atendidos en el periodo, en relación con la cantidad de personas de este rango de edad de la estimación de población por año elaborada por la Dirección Actuarial y Económica (DAE). Incluye: • Consultas de primera vez de personas de 65 años y más en el periodo. Excluye: • Clínica la reforma.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 65 años y más atendidas de primera vez en el periodo. • Número de personas de 65 años y más de la estimación de población por año elaborada por la DAE.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 65 años y más atendidas de primera vez en el periodo}}{\text{Número de personas de 65 años y más de la estimación de población por año elaborada por la DAE}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Persona adulta mayor
Línea base	Se define según los resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2024.	
Periodicidad	Quinquenal.	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Reporte de HTA o Cubo Cardiovascular): • Consultas de primera vez de personas de 65 años y más Dirección Actuarial y Económica: • Población de 64 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Indicador de Proceso.	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo) • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor.	
Indicador Complementario	Porcentaje de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor en los servicios de salud del Primer Nivel de Atención (V-1.0)	
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas de 65 años y más que fueron atendidos a quienes se les aplicó el énfasis de adulto mayor completo contenido en EDUS-SIES en alguna de las consultas del periodo. Incluye: • Consultas de primera vez de personas de 65 años y más en el periodo. Excluye: • Clínica la reforma.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 65 años y más atendidas con énfasis de adulto mayor completo en el periodo • Número de personas de 65 años y más atendidas en el primer nivel de atención	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 65 años y más atendidas con énfasis de adulto mayor completo en el periodo}}{\text{Número de personas de 65 años y más atendidas en el primer nivel de atención}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Persona adulta mayor
Línea base	Se define según los resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2024	
Periodicidad	Quinquenal: en construcción	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo Adulto Mayor): • Consultas de primera vez en personas de 65 años y más Reporte suministrado por el Área de Estadística y Salud (AES) de la CCSS: • Consultas de personas de 65 años y más con énfasis realizado.	
Clasificación	Indicadore de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo). • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.	

05-ECNT: OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS CON OBESIDAD

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	En la última encuesta de nutrición realizada por el Ministerio de Salud el 59,7 % de las mujeres de 20 a 44 años presentaron sobrepeso y obesidad, y el 77,3 % en el grupo de 45 a 64 años, mientras en el grupo de hombres de 20 a 64 años los resultados fueron de 62,4 % (MINSA, 2013). Posteriormente, la encuesta de vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular indicó una alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población costarricense, 39,5 % y 31,2 % respectivamente (CCSS, 2018). De mantenerse este comportamiento, se espera que para el año 2030 más del 40 % de la población mundial tendría problemas de sobrepeso y más de la quinta parte sería obesa, y en Costa Rica, se prevé que para el año 2060 la prevalencia de sobrepeso en la población será del 94 % (OECD Health Policy Sudies, 2019). Por otra parte, según estudios económicos para la CCSS la atención por obesidad en citas médicas y hospitalización alcanzaron los ₡65 000 millones en el año 2011, sin considerar el impacto que tuvo la pandemia sobre las atenciones por esta enfermedad. Adicionalmente, este grupo de personas con sobrepeso y obesidad tienen un 1,6 veces más riesgo de prevalencia para hipertensión y un 2,3 respectivamente. Se estima que entre el 2020 – 2050 el tratamiento de las enfermedades causadas por la obesidad costará en promedio 8,4 % del gasto total en atenciones médicas. En los países de la OCED el sobrepeso es responsable del 70 % de los costos de tratamiento en Diabetes Mellitus, el 23 % de los costos de tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y el 9 % del costo de tratamiento en cáncer. Adicionalmente, a causa de la obesidad se esperan tres millones de muertes prematuras entre personas de 30 y 70 años (OECD Health Policy Sudies, 2019). En este contexto, Costa Rica ha planteado en la estrategia nacional para el abordaje de las Enfermedades no transmisibles y la obesidad (ENTO) una meta que indica actuar sobre el aumento relativode la obesidad en la población (CCSS, 2023). Asimismo, la CCSS realiza una evaluación de la población con obesidad, con su diagnóstico respectivo y referencia a un profesional en Nutrición, acciones básicas de la atención en la red de servicios de salud. Este tipo de análisis que se obtiene del índice de masa corporal (IMC) se ha realizado en la institución desde el año 2019, como una estrategia para monitorear a la enfermedad en el sistema de salud. Por lo tanto, es momento de reconocer a la obesidad como una patología compleja, recurrente y multifactorial, que requiere de un sistema sólido para su prevención y tratamiento, pero alimentado de un seguimiento permanente y recursos que permitan la toma de decisiones (ElSayed et al., 2023).
Evidencia	El tratamiento recomendado para la persona con obesidad se basa en la modificación del comportamiento o terapia conductual, cuyos objetivos están dirigidos a promover cambios a largo plazo en su comportamiento alimentario con profesionales especializados en nutrición, lo cual involucra tres pilares: modificar y controlar su ingesta de alimentos, modificar su actividad física y controlar las señales y estímulos en el entorno que desencadenan comer en exceso (Morgan et al., 2023) (Raynor & Champagne, 2016) (Slawson et al., 2013). La evidencia recomienda a los médicos que ofrezcan y refieran a los adultos con un IMC ≥ 30 kg/m^2 a intervenciones conductuales y de componentes múltiples (involucran pérdida y mantenimiento de peso basadas en el comportamiento), ya que pueden conducir a mejoras clínicas significativas en el estado de peso, reducir la incidencia de DM tipo 2 y los niveles elevados de la glicemia (US Preventive Services Task Force, 2018) (Freshwater et al., 2022). La evidencia indica (Dobbie et al., 2023): • Un IMC de 40 – 45 kg/m^2 corresponde a una reducción de aproximadamente 10 años en la esperanza de vida. • La motivación de las personas que viven con obesidad para alcanza los objetivos se amplifica cuando hay interacciones positivas con los profesionales de la salud. • La atención primaria juega un papel esencial en el inicio de la evaluación clínica de las personas con obesidad y debe incluir diagnóstico, clarificación del riesgo metabólico, la optimización de

	las complicaciones asociadas (ej. presión arterial, lípidos, DM tipo 2), así como el inicio de la intervención y la continuidad de la atención a largo plazo. • El manejo de la obesidad debe involucrar a médicos, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales de la salud relacionadas con la enfermedad (Peckmezian & Hay, 2017).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Subdiagnóstico de la obesidad en las áreas de salud. Falta de recurso humano en nutrición en todas las áreas de salud para atender las referencias, lo cual causaría en el personal de salud una posible reducción de referencias emitidas para evitar la saturación del servicio en la red institucional. Estrategias: Sensibilizar al personal en salud sobre la necesidad de consignar el diagnóstico de obesidad en todas las personas que tengan un IMC asociado a la patología, para que estas reciban la atención que el sistema de salud ha definido en la red de servicios según la normativa técnica vigente. Apoyo técnico local y regional en las unidades que así lo requieran para mejorar la atención de las personas con obesidad, lograr mayor equidad y accesibilidad al tratamiento de la enfermedad.
Normativa Técnica	• Lineamiento técnico atención en salud a personas con obesidad en el I Nivel de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2019. • Lineamiento de referencia y contrarreferencia de las personas usuarias de los servicios de consulta externa en los establecimientos de salud de la CCSS. 2020. • Guía usuario módulo de Nutrición consulta externa, 2021. • Estrategia nacional de abordaje integral de las enfermedades No transmisibles y obesidad 2022 – 2030, Ministerio de Salud, 2021. • Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad, CCSS, 2023.
Costo / Efectividad	El estudio Look AHEAD demostró la efectividad y reducción en los costos en salud y los beneficios para las personas cuando se someten a un programa de pérdida de peso y modificación de la conducta (Glick et al., 2014). Cada dólar gastado en la prevención de la obesidad genera un beneficio económico seis veces mayor. El tratamiento de la obesidad y sus complicaciones de salud representan una carga económica, ya sea por gastos directos de atención u otros como la pérdida en la productividad laboral, aumento en el consumo de medicamentos, menor ingreso en el hogar (OECD Health Policy Sudies, 2019). Los beneficios logrados en los programas conductuales de control del peso son persistentes durante varios años y deberían alentar a los profesionales de la salud y a los formuladores de políticas a ofrecer tratamientos para la obesidad, ya que se consideran rentables para mejorar el control del peso a largo plazo. Adicionalmente, aumenta la calidad de vida de los participantes (Hartmann et al., 2023).
Objetivo (s) de la Evaluación	Identificar la población adulta con obesidad atendida en el primer nivel de atención que es diagnosticada y referida a Nutrición, para que las unidades tomen las medidas necesarias en el uso eficiente de los recursos disponibles en la red de servicios de salud y las personas reciban la atención requerida.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la proporción de los diferentes grados de obesidad entre la población atendida en el primer nivel según sexo? ¿Cuánto ha mejorado el registro del diagnóstico de la obesidad en la población atendida de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 entre las RIPSS? ¿Cuál es la proporción de mejora en el registro del diagnóstico de la obesidad entre las RIPSS en comparación con el comportamiento institucional? ¿Cuál es la proporción de personas atendidas con obesidad que son referidas a los servicios de Nutrición para una atención especializada? ¿Existen brechas en el nivel de referencia entre las diferentes RIPSS? ¿Cuáles son probables factores asociados a las brechas de referencia entre las RIPSS? ¿Cuál es la proporción de personas con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 que tiene algún factor de riesgo cardiovascular adicional a la obesidad que es atendida en el programa PINEC o consulta grupal de Nutrición?

Indicadores asociados a la intervención	05-01-1.0 Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 a quienes se les registra el diagnóstico de obesidad. 05-02-1.0 Porcentaje de personas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y un diagnóstico de obesidad que son referidas a Nutrición. 05-03-1.0 Porcentaje de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro factor de riesgo cardiovascular, que se atienden en consulta modalidad grupal de Nutrición.
Anexos	Anexo 1: Clasificación del estado nutricional según IMC, OMS. Anexo 2: Códigos CIE-10 utilizados para obesidad en el EDUS. Anexo 3: Códigos CIE-10 Embarazadas Anexo 4: Códigos CIE-10 Para la identificación la participación en el programa PINEC.
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2019). Lineamiento técnico atención en salud a personas con obesidad en el I nivel de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social. San José, Costa Rica: CCSS, Gerencia Médica, DDSS, Área de Atención Integral a las Personas. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2020). Lineamiento de referencia y contrarreferencia de las personas usuarias de los servicios de consulta externa en los establecimientos de salud de la CCSS. San José, Costa Rica.: CCSS, Gerencia Médica, DDSS, Área de Regulación y Sistematización al Diagnóstico y Tratamiento, Coordinación Nacional de Nutrición. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular. Tercera encuesta. CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Guía de usuario manejo integrado expediente en salud SIES y Módulo de Nutrición. Gerencia Médica, Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad. San José, Costa Rica: CCSS, Gerencia Médica. Data, A. &. D. (2023, 19 mayo). World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323. Dobbie, L., Matta-Coelho, C., Crane, J., & McGowan, B. (2023). Clinical evaluation of patients living with obesity. *Internal and Emergency Medicine*, 18(5),1273-1285. https://doi.org/10.1007/s11739-023-03263-2. ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., Bannuru, R. R., Brown, F. C., Bruemmer, D., Collins, B., Hilliard, M. E., Isaacs, D., Johnson, E. L., Kahan, S., Khunti, K., León, J., Lyons, S. K., Perry, M. L., Prahalad, P., Pratley, R. E., Seley, J. J., Stanton, R. C., & Gabbay, R. A. (2022). 8. Obesity and Weight Management for the prevention and treatment of Type 2 diabetes: Standards of Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Supplement_1), S128-S139. https://doi.org/10.2337/dc23-s008 Espeland, M. A., Glick, H. A., Bertoni, A. G., Brancati, F. L., Bray, G. A., Clark, J. M., Curtis, J. M., Egan, C., Evans, M., Foreyt, J. P., Ghazarian, S., Gregg, E. W., Hazuda, H. P., Hill, J. O., Hire, D., Horton, E. S., Hubbard, V. S., Jakicic, J. M., Jeffery, R. W., . . . Zhang, . (2014). Impact of an intensive lifestyle intervention on use and cost of medical services among overweight and obese adults with type 2 diabetes: the action for health in diabetes. *Diabetes Care*, 37(9), 2548-2556. https://doi.org/10.2337/dc14-0093. Freshwater, M., Christensen, S., Oshman, L., & Bays, H. (2022). Behavior, motivational interviewing, eating disorders, and obesity management technologies: an Obesity Medicine Association (OMA) Clinical Practice Statement (CPS) 2022. *Obesity Pillars*, 2, 1000014. https://doi.org/10.1016/j.obpill.2022.100014. Hartmann, J., Cobiac, L., Theodoulou, A., Oke, J., Butler, A., Scarborough, P., . . . Jebb, S. (2023). Weight regain after behavioral weight management programmes and its impact on quality of life and cost effectiveness: evidence synthesis and health economic analyses. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 25(2), 526-535. doi: 10.1111/dom.14895. Ministerio de Salud [MINSA]. (2021). Estrategia nacional de abordaje integral de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2022- 2030. San José, Costa Rica: MINSA. Ministerio de Salud [MINSA]. (2013). Encuesta nacional de nutrición 2008- 2009. Fascículo 1: Antropometría. San José: Costa Rica: El Ministerio. Morgan, M., Raynor, H., Domel, S., Halliday, T., Lynch, A., Malik, N., . . . Rozga, M. (2023). Medical nutrition therapy interventions provided by dietitians for adult overweight and obesity management: an academy of nutrition and dietetics evidence-based practice guideline. *Journal of Academy of Nutrition and Dietetics*, 123(3), 520-545.e10. https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.11.014. OECD Health Policy Studies. (2019). The heavy burden of obesity: The economics of prevention. Paris https://doi.org/10.1787/2074319x: OECD Publishing.

Peckmezian, T., & Hay, P. (2017). A systematic review and narrative synthesis of interventions for uncomplicated obesity: weight loss, well-being and impact on eating disorders. *Journal of eating disorders*, 5(1). https://doi.org/10.1186/s40337-017-0143-5.

Raynor, H., & Champagne, C. (2016). Position of the academy of nutrition and dietetics: interventions for the treatment of overweight and obesity in adults. Journal of the *Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(1), 129- 147. https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.10.031.

Slawson, D., Fitzgerald, N., & Morgan, K. (2013). Position of the academy of nutrition and dietetics: the role of nutritional in health promotion and chronic disease prevention. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 113(7), 972-979. https://doi.org/10.1016/j.jand.2013.05.005.

US Preventive Services Task Force. (2018). Behavioral weight loss interventions to prevent obesity-related morbidity and Mortality in adults. *JAMA*, 320(11):1163-1171. doi:10.1001/jama.2018.13022.

World Obesity Federation. (2022). The economic impact of overweight & obesity 2nd edition with estimates for 161 countries. World Obesity Federation.

World Obesity Federation. (2023). World obesity atlas 2023. World Obesity Federation.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 05-01-1.0

Elemento	Descripción	
Código	05-01-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 a quienes se les registra el diagnóstico de obesidad.	
Definición conceptual	El indicador refiere a la proporción de personas atendidas de 20 a 64 años con un índice de Masa Corporal (IMC) ≥ 30,0 Kg/m^2 a quienes se les registra el diagnóstico de obesidad según los códigos CIE-10 (E660: Obesidad debida a exceso de calorías; E668: Otros tipos de obesidad; E669: Obesidad, no especificado). Para medir el indicador se procede con la identificación de todas las personas de 20 a 64 años que consultan en el periodo con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2. Luego, se determina el total de personas de 20 a 64 años que consultan en el periodo con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y tiene el registro del diagnóstico de obesidad. • Primera consulta en el periodo con obesidad: Es la primera atención en el periodo con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2. • Persona con obesidad: Incluye la primera consulta de periodo de la población atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2. • Personas con obesidad y diagnóstico: Incluye las personas de 20 a 64 años que consultan en el periodo con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y tiene el registro del diagnóstico de obesidad. Incluye: • Primera consulta del año con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2. • Primera consulta del año con registro del diagnóstico de obesidad. Excluye: • Embarazadas según códigos CIE-10[1]. • IMC con inconsistencias (≤ 10,0 y ≥ 105,0 kg/m^2 o ausencia de peso y/o talla).	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30 kg/m^2 y un diagnóstico de obesidad. • Número de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30 kg/m^2, en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2 \text{ y un diagnóstico de obesidad}}{\text{Número de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2\text{, en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT- Obesidad y Síndrome Metabólico
Línea base	27 %	
Meta	Quinquenal: 33 % (corresponde al percentil 75)	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales): • Consultas de la población de 20 a 64 años. • Consultas de la población de 20 a 64 años con diagnóstico de obesidad. • Consultas de embarazadas.	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual) • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)	
Comentarios generales	La obesidad es una enfermedad de reporte obligatorio y su diagnóstico debe aparecer consignado en el expediente siempre que el paciente tenga un IMC asociado a la obesidad, independientemente del grado (I, II ó III).	

	Ver: Reglamento de vigilancia de la salud N°40556-S y la Reforma Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de vigilancia de la Salud N° 32980. [1]El listado de embarazadas se construye con los siguientes códigos CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 05-02-1.0

Elemento	Descripción	
Código	05-02-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y un diagnóstico de obesidad que son referidas a Nutrición.	
Definición conceptual	El indicador refiere a la proporción de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y un diagnóstico de obesidad que son referidas a Nutrición. Los códigos CIE-10 utilizados para el registro del diagnóstico de obesidad son los siguientes: E660: Obesidad debida a exceso de calorías; E668: Otros tipos de obesidad; E669: Obesidad, no especificado. Para su medición se realiza la identificación de todas las personas de 20 a 64 años que consultan en el periodo con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y tiene el registro del diagnóstico de obesidad. Luego, se identifican las personas del mismo rango de edad que tiene un registro de referencia a nutrición en el periodo. Finalmente, teniendo ambos listados se procede a identificar cuáles son las personas que cumplen los siguientes tres criterios: un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2, registro del diagnóstico de obesidad y registro de la referencia a Nutrición. • Primera consulta en el periodo con obesidad: Es la primera atención en el periodo con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2. • Personas con obesidad y diagnóstico: Incluye a las personas de 20 a 64 años que consultan en el periodo con IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y tiene el registro del diagnóstico de obesidad. • Personas referidas a Nutrición: Incluye a las personas de 20 a 64 años que tienen registro de referencia a Nutrición en el periodo. Incluye: • Primera consulta del año con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2. • Primera consulta del año con registro del diagnóstico de obesidad. • Referencias del periodo a Nutrición. Excluye: • Embarazadas según códigos CIE-10[(1)]. • IMC con inconsistencias (≤ 10,0 y ≥ 105,0 kg/m^2 o ausencia de peso y/o talla). • Población de 20 a 64 años con IMC ≥ 30,0 kg/m^2 y diagnóstico de obesidad referidos a Nutrición en los tres periodos anteriores a la evaluación [(2)].	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas atendidas de 20 a 64 años con IMC ≥ 30,0 kg/m^2 y diagnóstico de obesidad que tienen referencia a Nutrición en el periodo. • Número de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 kg/m^2 y un diagnóstico de obesidad.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas atendidas de 20 a 64 años con IMC} \geq 30{,}0\ \text{kg/m}^2\ \text{y diagnóstico de obesidad que tienen referencia a Nutrición en el periodo}}{\text{Número de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC} \geq 30{,}0\ \text{kg/m}^2\ \text{y un diagnóstico de obesidad}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Promoción y Prevención
	Temática	ECNT- Obesidad y Síndrome Metabólico
Línea base	13 %	
Meta	Quinquenal: 20 % (corresponde al percentil 75)	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales- Cubo Referencias Salud): • Consultas de la población de 20 a 64 años. • Consultas de la población de 20 a 64 años con diagnóstico de obesidad. • Consultas de embarazadas. • Referencias a Nutrición del periodo evaluado y anteriores.	
Clasificación	Indicador de proceso	

Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual). • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	(1) El listado de embarazadas se construye con los siguientes códigos CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado. (2) No es necesario realizar una nueva referencia a Nutrición si ya existe el registro en EDUS de esta acción en los últimos tres años, según se indica en acuerdo N°2 de la Minuta reunión DCSS_EPSS2024-2028_161023 con la Coordinación Nacional de Nutrición del 16/10/2023, asunto que será incluido y aclarado en los documentos de Instrucción de Trabajo para la atención nutricional de los pacientes con obesidad, en todos los niveles de atención de la CCSS y en la actualización del documento Lineamiento de referencias y contrarreferencia de las personas usuarias de los Servicios de consulta externa en los establecimientos de salud de la CCSS – CNN. La modalidad de atención de las personas con obesidad referidas a nutrición queda definida en el documento Instrucción de trabajo para la atención nutricional de los pacientes con obesidad, en todos los niveles de atención de la CCSS, el cual se encuentra en edición para publicación en el 2023.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 05-03-1.0

Elemento	Descripción	
Código	05-03-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro factor de riesgo cardiovascular, que se atienden en consulta modalidad grupal de Nutrición.	
Definición conceptual	El indicador mide la proporción de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro Factor de Riesgo Cardiovascular (FRC) que asisten a la consulta modalidad grupal en las áreas de salud que cuentan con profesional en Nutrición según lo indica la normativa técnica vigente. La Coordinación Nacional de Nutrición ha definido que todas las personas con obesidad deben atenderse en consulta modalidad grupal, utilizando las siguientes estrategias [1]: • Consulta grupal obesidad: atención definida para todas las personas con obesidad I y II, según códigos CIE-10 (E660-E668-E669). • Programa de Intervención Nutricional en Enfermedades Crónicas (PINEC): atención definida para las personas con obesidad grado III y otro factor de riesgo cardiovascular, según códigos CIE-10: E90X - Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte, Z728 - Otros problemas relacionados con el estilo de vida, E631 - Desequilibrio de los constituyentes de la dieta. Incluye: • Atenciones de primera vez de la población de 40 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y otro FRC en el periodo. • Atenciones de las personas de 40 a 64 años con un IMC ≥ 30,0 kg/m^2, otro FRC y registro de participación en la consulta modalidad grupal de Nutrición en el periodo. • Otro FRC: • Diabetes Mellitus: Código E11-Diabetes Mellitus tipo 2 • Hipertensión Arterial: Código I10X-Hipertensión esencial (Primaria) • Dislipidemia: Código E78-Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias. • Áreas de Salud con profesional en Nutrición. Excluye: • IMC con inconsistencias (≤ 10,0 y ≥ 105,0 kg/m^2 o ausencia de peso y/o talla). • Personas atendidas en consulta modalidad grupal de Nutrición en los tres o cinco periodos anteriores a la evaluación, según normativa.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 40 a 64 años con IMC ≥ 30,0 Kg/m^2, otro FRC y participación en consulta grupal de Nutrición en el periodo. • Número de personas atendidas de 40 a 64 años con IMC ≥ 30,0 Kg/m^2 y otro FRC en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 40 a 64 años con IMC} \geq 30{,}0\ \text{Kg/m}^2\text{, otro FRC y participación en consulta grupal de Nutrición en el periodo}}{\text{Número de personas atendidas de 40 a 64 años con IMC} \geq 30{,}0\ \text{Kg/m}^2\text{ y otro FRC en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT- Obesidad y Síndrome Metabólico
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024.	
Meta	Quinquenal: en construcción.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales): • Consultas de la población de 40 a 64 años. • Consultas modalidad grupales de Nutrición en periodo evaluado y previos. • Consultas de población de 40 a 64 años con diagnóstico de HTA o DM tipo 2 o dislipidemia.	
Clasificación	Indicador de proceso.	

Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual) • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)
Comentarios generales	Según el Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad, 2023, debe evidenciarse la incorporación de paciente con enfermedades crónicas al programa PINEC. (1) La modalidad de atención de las personas con obesidad queda definida en la Instrucción de Trabajo de la CNN, según Minuta de reunión DCSS_EPSS2024-2028_161023. La atención de las personas con obesidad I y II se programa durante 3 años y las personas con obesidad III durante 5 años.

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS CON SÍNDROME METABÓLICO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	El Síndrome Metabólico (SM) es un trastorno metabólico caracterizado por la presencia de obesidad abdominal y se diagnostica en las personas que presentan tres de los siguientes criterios (CCSS, 2015) (CCSS, 2017): • Circunferencia abdominal elevada: mayor o igual a 90 cm en los varones y mayor o igual a 80 cm en las mujeres. • Triglicéridos elevados: mayor o igual a 150 mg/dl o con diagnóstico de hipertrigliceridemia. • HDL colesterol disminuido: menor de 40 mg/dl en los varones o personas con tratamiento, menor de 50 mg/dl en las mujeres o personas con tratamiento. • Presión arterial elevada: población Pre HTA: PA sistólica entre 130-139 mmHg y PA diastólica entre 85- 89 mmHg la diastólica, o personas portadora de hipertensión arterial con tratamiento antihipertensivo (PA mayor o igual a 140/90 mm Hg). • Glucemia en ayunas: persona prediabética (100 mg/dl a 125 mg/dl) Las personas con SM tienen más enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo a desarrollarlas (Hu, Qiao, Tuomilehto, & et al., 2004). Incluso, estudios recientes refieren que el SM se asocia a un elevado riesgo de mortalidad por todas las causas, la enfermedad cardíaca y la Diabetes Mellitus (Li et al., 2023). En la encuesta NHANES III realizada en población de los Estados Unidos sobre factores de riesgo asociados, se identificó que el síndrome metabólico estaba presente en el 5 % de las personas con peso normal, el 22 % en personas con sobrepeso y el 60 % en personas con obesidad (Park et al., 2003). La prevalencia de SM oscila entre el 14 - 18 % en europeos, 23,4 % en Estados Unidos, entre otros (Tillin et al., 2005). La prevalencia general estandarizada del SM en Centroamérica fue del 30,3 % y del 9% para Costa Rica (Wong et al., 2015). Múltiples estudios mencionan la importancia que tiene la implementación de intervenciones de asesoramiento conductual para promover un estilo de vida saludable para la prevención de enfermedades cardiovasculares en personas con factores de riesgo cardiovascular (Patnode et al., 2022) (Dobrowolski et al., 2022) (O´Connor et al., 2020). Por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se cuenta con normativa técnica para el desarrollo de intervenciones de asesoramiento conductual, disponible en el Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles, el cual está enfocado en la prevención y control de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Adicionalmente, recibe el apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Nutrición y otras disciplinas para su implementación (CCSS, 2017).
Evidencia	Las intervenciones intensivas en estilo de vida pueden disminuir la mortalidad y estar asociadas con menor riesgo de eventos cardiovasculares. Además, la modificación en el estilo de vida y la reducción del peso representan la terapia de primera línea para esta patología (Magkos et al., 2009) (Guzmán et al., 2019) (Rosenzweig et al., 2008). La reducción de peso está recomendada para las personas con obesidad y se asocia a efectos favorables de la presión arterial y la dislipidemia que pueden resultar en menor incidencia de ECV (CCSS y OPS, 2015) (Morgan et al., 2022). Adicionalmente, las intervenciones que causan pérdida de peso son efectivas para mejorar los factores de riesgo cardiovascular (Zomer et al., 2016). Intervenciones en el estilo de vida reducen la incidencia de SM en un 41 % en comparación con las personas que no tienen SM (Lam & LeRoith, 2019, 11 febrero). La evidencia afirma que los hábitos alimentarios y la pérdida de peso a largo plazo son determinantes para el aumento o disminución del riesgo de ECV (CCSS y OPS, 2015) (Yeh et al., 2019). Mejorar los factores de riesgo cardiovascular que componen el SM (ej. Triglicéridos, valores de glicemia, circunferencia abdominal, etc.) podría revertir el síndrome e impulsar cambios en los criterios de valoración. Además, la reversión del SM se asocia a un menor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular mayor (Park et al., 2019). Después de terminar una intervención en personas con obesidad, los nutricionistas deben proporcionar seguimientos al menos cada tres meses durante el tiempo que el usuario desee, para

	facilitar el mantenimiento de la pérdida de peso y la mejorar de los resultados cardiometabólicos (Morgan et al., 2022)
Consideraciones de Implementación	Barreras: Subdiagnóstico de personas con Síndrome Metabólico. Falta de recurso humano en nutrición en 38 % de las áreas de salud al 2023. Bajo nivel de sensibilización del personal en salud por inscribir a las personas candidatas al programa de SM. No hay registro en EDUS de todas las pruebas de laboratorio para todas las personas que finalizan la atención multidisciplinaria durante el periodo evaluado, dificultando así el análisis del grupo que terminó las cinco atenciones para SM. Baja disponibilidad de espacios o áreas propicias para brindar una consulta grupal en los centros de salud. Bajo nivel de motivación de las personas para culminar el programa y mejorar su calidad de vida. Escasas o ausentes herramientas de evaluación local que permitan mejorar la calidad de las intervenciones que se desarrollan. Ausencia de herramientas automatizadas en la CCSS que permitan extraer información nutricional y antropométrica (ej. Circunferencia Abdominal) y bioquímica de los participantes en el programa de SM, para brindar un análisis de resultados más amplio o medir la efectividad de este. Estrategias: Capacitación y apoyo continuo en el programa de SM por parte de la Coordinación Nacional de Nutrición, los supervisores regionales de Nutrición y el nutricionista local. Apoyo regional en las unidades que están desarrollando el programa de SM para favorecer el trabajo en equipo y la implementación del programa con las disciplinas involucradas.
Normativa Técnica	• Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles, CCSS, 2017. • Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, OPS, 2015. • Indicadores para evaluar el manual de procedimientos multidisciplinario para la atención y enseñanza de las ECNT, Oficio ARSDT-NUT-0389-18. • Oficio ARSDT-E-NUT-0111-2022 emitido el 10/03/2022 por la Coordinación Nacional de Nutrición con el asunto “Registro del programa PINEC en SIAC y SIES”, indica que se registra el código Z863 cuando el paciente completa el programa con un total de 5 atenciones. • Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad 2022 – 2030.
Costo / Efectividad	La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que es posible evitar la pérdida de años de vida saludable causado por las enfermedades cardiovasculares, aplicando los conocimientos y las tecnologías existentes, lo cual permitiría ahorrar 395 millones de dólares al año. Adicionalmente, indica que el gasto en la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles es una inversión (OPS, 2011). Los autores mencionan la costo-efectividad de intervenciones grupales para el manejo de la obesidad y factores de riesgo cardiovascular en términos de costo por ganancia en años de vida ajustado por calidad, indicando que el costo es del $229 por intervención y $5 para el grupo control. La probabilidad de rentabilidad o proporción de pacientes que encontraría una intervención económicamente aceptable basada en la ganancia de los años de vida ajustados por calidad oscilan entre 0,77 y 1,0. Finalmente, estos resultados de costo efectividad son realizados en intervenciones que involucra un profesional en Nutrición (Morgan et al., 2022).
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar la efectividad del programa de atención multidisciplinaria para personas con Síndrome Metabólico en las áreas de salud que cuentan con profesional en Nutrición, con el fin de aportar elementos en la toma de decisiones institucionales en la atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la efectividad del programa de atención multidisciplinaria para las personas con síndrome metabólico considerando los valores de triglicéridos y el cambio de peso corporal? ¿Cuál es la proporción de personas con diagnóstico de Síndrome Metabólico que son beneficiarias del programa de SM cada 5 años?

	¿Cuál es la proporción de personas usuarias que logran terminar el programa de SM por RIPSS e institucional? ¿Cuál es la proporción de personas con resultados de triglicéridos disponibles al finalizar el programa de SM por área de salud, por RIPSS e institucional? ¿Cuál es la proporción de personas que ingresan al programa de SM sin registro del diagnóstico de SM?
Indicadores asociados a la intervención	05-04-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) que alcanzan valores normales de triglicéridos. 05-05-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con atención multidisciplinaria completa (AMC), que logran reducir al menos un 5 % del peso corporal.
Anexos	Códigos CIE-10 utilizados para síndrome metabólico en atención multidisciplinaria.
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2015). Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. San José, Costa Rica.: EDNASSS-CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017). Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles. San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención de la persona candidata a cirugía bariátrica en los establecimientos de salud de la CCSS. San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS. Dobrowolski, P., Prejbisz, A., Kuryłowicz, A., Baska, A., Burchardt, P., Chlebus, K., Dzida, G., Jankowski, P., Jaroszewicz, J., Jaworski, P., Kamiński, K., Kapłon-Cieślicka, A., Klocek, M., Kukla, M., Mamcarz, A., Mastalerz-Migas, A., Narkiewicz, K., Ostrowska, L., Śliż, D., . . . Bogdański, P. (2022). Metabolic syndrome – a new definition and management guidelines A joint position paper by the Polish Society of Hypertension, Polish Society for the Treatment of Obesity, Polish Lipid Association, Polish Association for Study of Liver, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Lifestyle Medicine, Division of Prevention and Epidemiology Polish Cardiac Society, "Club 30" Polish Cardiac Society, and Division of Metabolic and Bariatric Surgery Society of Polish Surgeons. *Archives of Medical Science*, 18(5), 1133-1156. https://doi.org/10.5114/aoms/152921 Guzmán, A., Navarro, E., Obando, L., Pacheco, J. A. Q., Quirós, K., Vásquez, L., Castro, M., & Ramírez, F. (2019). Efectividad de las intervenciones para revertir el diagnóstico del síndrome metabólico: actualización de metaanálisis de comparación mixta de tratamientos. *Biomédica*, 39(4), 647-662. https://doi.org/10.7705/biomedica.4684. Hu, G., Qiao, Q., Tuomilehto, J., & et al. (2004). Prevalencia of the metabolic syndrome and its relation to all-cause and cardiovascular mortality in nondiabetic European men and women. *Archives of internal medicine*, 164(10), 1066. https://doi.org/10.1001/archinte.164.10.1066. Karam, G., Agarwal, A., Sadeghirad, B., Jalink, M., Hitchcock, C., Ge, L., Kiflen, R., Ahmed, W., Zea, A. M., Milenkovic, J., Chedrawe, M., Rabassa, M., Dib, R. E., Goldenberg, J. Z., Guyatt, G., Boyce, E., & Johnston, B. C. (2023). Comparison of seven popular structured dietary programmes and risk of mortality and major cardiovascular events in patients at increased cardiovascular risk: systematic review and network meta-analysis. *BMJ*, e072003. https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072003. Lam, D., & LeRoith, D. (2019, 11 febrero). Metabolic syndrome. Obtenido de Endotext- NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278936/ Li, W., Chen, D., Peng, Y., Lu, Z., Kwan, M., & Tse, L. A. (2023). Association between metabolic syndrome and mortality: prospective cohort study. *JMIR public health and surveillance*, 9, e44073. https://doi.org/10.2196/44073. Magkos, F., Yannakoulia, M., Chan, J. L., & Mantzoros, C. S. (2009). Management of the metabolic syndrome and type 2 diabetes through lifestyle modification. *Annual Review of Nutrition*, 29(1), 223-256. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-080508-141200. Morgan, M., Domel, S., Halliday, T., Lynch, A., Malik, N., Raynor, H., . . . Rozga, M. (2022). Weight management interventions provided by a dietitian for adults with overweight or obesity: an evidence analysis center systematic review and meta-analysis. *Academy of nutrition and dietetics*. https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.03.014. O´Connor, E., Evans, C., Rushkin, M., Redmond, N., & Lin, J. (2020, 1 mayo). Behavioral counseling interventions to promote a healthy diet and physical activity For cardiovascular disease prevention in adults with cardiovascular risk factors: Updated Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565468/. Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2011). La carga económica de las enfermedades no transmisibles en la región de las américas. Informe temático sobre enfermedades no transmisibles.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2011/paho-policy-brief3-sp1.pdf.

Park, S., Lee, S., Kim, Y., Lee, Y., Woo, M., Han, K., . . . Ki, D. (2019). Altered risk for cardiovascular events with changes in the metabolic syndrome status: a nationawide population-based study of approximately 10 million persons. *Ann Intern Med*, 171(12), 875-884. https://doi: 10.7326/M19-0563.

Park, Y., Zhu, S., Palaniappan, L., Heshka, S., Carnethon, M., & Heymsfield, S. (2003). The metabolic syndrome: prevalence and associated risk factor findings in th US population from the third national health and nutrition examination survey, 1988-1994. *Archives of internal medicine*, 163(4), 427-36. https://doi: 10.1001/archinte.163.4.427.

Patnode, C. D., Redmond, N., Iacocca, M. O., & Henninger, M. (2022). Behavioral counseling interventions to promote a healthy diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults without known cardiovascular disease risk factors. *JAMA*, 328(4), 375. https://doi.org/10.1001/jama.2022.7408.

Rosenzweig, J., Ferrannini, E., Grundy, S., Haffner, S., Heine, R., Horton, E., & Kawamori, R. (2008). Primary prevention of cardiovascular disease and type 2 diabetes in patients at metabolic risk: an endocrine society clinical practice guideline. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 93(10), 3671-3689 https://doi.org/10.1210/jc.2008-0222.

Tillin, T., Forouhi, N. G., Johnston, D. G., McKeigue, P., Chaturvedi, N., & Godsland, I. F. (2005). Metabolic syndrome and coronary heart disease in South Asians, African-Caribbeans and White Europeans: a UK population-based cross-sectional study. *Diabetologia*, 48(4), 649-656. https://doi.org/10.1007/s00125-005-1689-3.

Wong, R., Gregg, E., Barceló, A., Lee, K., Abarca, L., Sanabria, L., & Tortós, J. (2015). Prevalence of metabolic syndrome in Central America: a cross-sectional population-based study. *Rev Panam Salud Publica*, 38(3), 202-208.

Yeh, T., Chen, H., Tsai, S., Lin, C., Liu, S., & Chien, K. (2019). The relationship between metabolically healthy obesity and the risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 8(8), 1228. https://doi.org/10.3390/jcm8081228.

Zomer, E., Gurusamy, K., Trimmer, L., Lobstein, T., Morris, S., James, W., & Finer, N. (2016). Interventions that cause weight loss and the impact on cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 17(10),1001- 1011. https://doi.org/10.1111/obr.12433

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 05-04-1.0

Elemento	Descripción	
Código	05-04-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) que alcanzan valores normales de triglicéridos.	
Definición conceptual	Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) [(1)]: comprende la participación a cinco atenciones de Síndrome Metabólico (SM) registradas en EDUS en modalidad grupal con el código CIE - 10 Z728: Otros problemas relacionados con el estilo de vida. Se trabaja utilizando el manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles: • Metodología PINEC: Comprende cinco atenciones para cada participante, donde reciben las herramientas necesarias para el control de los factores de riesgo cardiovascular, manejo de alimentación, control de peso corporal, actividad física y autocuidado. • Material educativo: Disponible en el manual. • Gestor del programa: Profesional en Nutrición. Triglicéridos normales: es el resultado de la prueba de laboratorio clínico para triglicéridos con valores < 150 mg/dL, disponible a partir de la quinta consulta de la AMC. Incluye: • Consultas de personas de 20 años y más con síndrome metabólico que tienen al menos cinco atenciones bajo la modalidad grupal de atención multidisciplinaria para SM, según código CIE-10: Z728 • Pruebas de laboratorio clínico: Triglicéridos realizados posterior a la fecha de la cuarta atención de AMC. • Áreas de Salud con profesional en Nutrición. Excluye: • Personas con SM atendidos en AMC en los cinco años previos al periodo evaluado.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas atendidas con síndrome metabólico en la AMC y triglicéridos normales. • Número de personas con síndrome metabólico en la AMC.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas atendidas con síndrome metabólico en la AMC y triglicéridos normales}}{\text{Número de personas con síndrome metabólico en la AMC}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT- Obesidad y Síndrome Metabólico
Línea base	34 %	
Meta	Quinquenal: 43 % (correspondiente al percentil 75)	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales): • Consultas de personas con AMC. • Triglicéridos registrados en las Pruebas de laboratorio clínico proveniente del énfasis correspondiente. Sistema de Laboratorio Clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Triglicéridos	
Clasificación	Indicador de resultado	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual) • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)	

Comentarios generales	[1] Oficio ARSDT-E-NUT-0111-2022 emitido el 10/03/2022 por la Coordinación Nacional de Nutrición con el asunto "Registro del programa PINEC en SIAC y SIES", indica que se registra el código Z863 cuando el paciente completa el programa con un total de 5 atenciones. Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico que completan la atención multidisciplinaria. • Porcentaje de personas de 20 años y más con atención multidisciplinaria para Síndrome Metabólico (SM) y registro del diagnóstico CIE-10 E889.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 05-05-1.0

Elemento	Descripción	
Código	05-05-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC), que logran reducir al menos un 5 % del peso corporal.	
Definición conceptual	Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) [1]: comprende la participación a cinco atenciones de Síndrome Metabólico (SM) registradas en EDUS en modalidad grupal con el código CIE - 10 Z728: Otros problemas relacionados con el estilo de vida. Se trabaja utilizando el manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles: • Metodología: Comprende cinco atenciones para cada participante, donde recibe las herramientas necesarias para el control de los factores de riesgo cardiovascular, manejo de alimentación, control de peso corporal, actividad física y autocuidado. • Material educativo: Disponible en el manual. • Gestor del programa: Profesional en Nutrición. Al menos 5 % de reducción en el peso corporal: corresponde al porcentaje de peso perdido entre el peso de la primera consulta (PPC) y el peso de la quinta consulta (PQC), ambas consultas registradas con el código CIE-10: Z728 Otros problemas relacionados con el estilo de vida. El PPC y el PQC deben aparecer en kilogramos y con un decimal. Fórmula: $\frac{PPC - PQC}{PPC}$ X 100 = Porcentaje pérdida de peso logrado Incluye: • Consultas de personas de 20 años y más con síndrome metabólico que tienen al menos cinco atenciones bajo la modalidad grupal de atención multidisciplinaria para SM del periodo, según código CIE-10: Z728. • Peso en kilogramos: registrado en la primera y quinta consulta de atención multidisciplinaria para SM del periodo, según código CIE-10: Z728. • Áreas de Salud con profesional en Nutrición. Excluye: • Personas con SM atendidos en AMC en los cinco años previos al periodo evaluado.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas atendidas con síndrome metabólico en la AMC que reducen al menos un 5 % del peso corporal. • Número de personas con síndrome metabólico en la AMC.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas atendidas con síndrome metabólico en la AMC que reducen al menos un 5 \% del peso corporal}}{\text{Número de personas con síndrome metabólico en la AMC}}$ x 100	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT- Obesidad y Síndrome Metabólico
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Meta	Quinquenal: en construcción.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales): • Consultas de personas con AMC según código CIE-10 Z728.	
Clasificación	Indicador de resultado	

Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual) • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)
Comentarios generales	(1) Oficio ARSDT-E-NUT-0111-2022 emitido el 10/03/2022 por la Coordinación Nacional de Nutrición con el asunto "Registro del programa PINEC en SIAC y SIES", indica que se registra el código Z863 cuando el paciente completa el programa con un total de 5 atenciones. Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico que completan la atención multidisciplinaria. • Porcentaje de personas de 20 años y más con atención multidisciplinaria para Síndrome Metabólico (SM) y registro del diagnóstico CIE-10 E889.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicadores de Evaluación	05-04-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) que alcanzan valores normales de triglicéridos. 05-05-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC), que logran reducir al menos un 5 % del peso corporal.	
Indicador Complementario	Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico que completan la atención multidisciplinaria (V-1.0).	
Definición conceptual	Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) [(1)]: comprende la participación a cinco atenciones de Síndrome Metabólico (SM) registradas en EDUS en modalidad grupal con el código CIE - 10 Z728: Otros problemas relacionados con el estilo de vida. Se trabaja utilizando el manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles: • Metodología: Comprende cinco atenciones para cada participante, donde recibe las herramientas necesarias para el control de los factores de riesgo cardiovascular, manejo de alimentación, control de peso corporal, actividad física y autocuidado. • Material educativo: Disponible en el manual. • Gestor del programa: Profesional en Nutrición. Incluye: • Consultas de personas de 20 años y más atendidas con síndrome metabólico en la modalidad grupal de atención multidisciplinaria, según código CIE-10: Z728. • Áreas de Salud con profesional en Nutrición. Excluye: • Personas con SM atendidos en AMC en los cinco años previos al periodo evaluado.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas con síndrome metabólico en la AMC. • Número de personas con síndrome metabólico en la atención multidisciplinaria.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas con síndrome metabólico en la AMC}}{\text{Número de personas con síndrome metabólico en la atención multidisciplinaria}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT- Obesidad y Síndrome Metabólico
Línea base	7 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales): • Consultas de las personas en atención multidisciplinaria modalidad grupal según código CIE - 10: Z728.	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual) • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)	
Comentarios generales	[(1)] Oficio ARSDT-E-NUT-0111-2022 emitido el 10/03/2022 por la Coordinación Nacional de Nutrición con el asunto "Registro del programa PINEC en SIAC y SIES", indica que se registra el código Z863 cuando el paciente completa el programa con un total de 5 atenciones.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	05-04-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC) que alcanzan valores normales de triglicéridos. 05-05-1.0 Porcentaje de personas de 20 años y más con síndrome metabólico con Atención Multidisciplinaria Completa (AMC), que logran reducir al menos un 5 % del peso corporal.	
Indicador Complementario	Porcentaje de personas de 20 años y más con atención multidisciplinaria para Síndrome Metabólico (SM) y registro del diagnóstico CIE-10 E889 (V-1.0).	
Definición conceptual	El indicador mide la proporción de personas de 20 años y más que ingresan a la atención multidisciplinaria para SM y tienen registrado en el EDUS el diagnóstico CIE-10: E889. Dicha acción la realiza el profesional de la salud cuando verifica el cumplimiento de los criterios para SM establecidos en la normativa técnica vigente. • Código CIE-10: Z728 Otros problemas relacionados con el estilo de vida (Atención Multidisciplinaria para SM, registrada como consulta modalidad grupal) • Código CIE-10: E889[(1)] Trastorno metabólico, no especificado (Diagnóstico para SM). Incluye: • Consultas de las personas de 20 años y más en modalidad grupal en el periodo, según código CIE-10: Z728. • Consultas de las personas de 20 años y más con diagnóstico en el periodo, según código CIE-10 E889. • Áreas de Salud con profesional en Nutrición. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas en la atención multidisciplinaria que tiene el diagnóstico para síndrome metabólico. • Número de personas con síndrome metabólico en la atención multidisciplinaria.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas en la atención multidisciplinaria que tiene el diagnóstico para síndrome metabólico}}{\text{Número de personas con síndrome metabólico en la atención multidisciplinaria}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT- Obesidad y Síndrome Metabólico
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales): • Consultas de las personas de 20 años y más en modalidad grupal en el periodo, según código CIE-10: Z728. • Consultas de las personas de 20 años y más con diagnóstico en el periodo, según código CIE-10 E889.	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual) • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)	
Comentarios generales	[(1)] Acuerdo N°6 de la Minuta reunión DCSS_EPSS2024-2028_161023 con la Coordinación Nacional de Nutrición del día 16/10/2023. Incluir el diagnóstico de las personas con síndrome metabólico en la actualización del lineamiento de obesidad que se desarrolla con el equipo del AAIP, DDSS, GM.	

06-ECNT: DIABETES MELLITUS TIPO 2

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La Diabetes Mellitus tipo 2(DM2) se ha convertido en un problema mayor de salud pública, tanto por su frecuencia como por el impacto en la calidad de vida de las personas y el considerable costo para el sistema sanitario. La enfermedad ha sido seleccionada a nivel mundial como una de las cuatro enfermedades no transmisibles que deben intervenirse con carácter prioritario (Organización Mundial de la Salud, 2016). Actualmente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), número que se ha triplicado en la Región desde 1980; y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040. Se indica además que la prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. Adicionalmente, se mantienen en vigencia los datos estadísticos 2021 de la OPS en los que se indica que entre el 30 y 40 % de las personas están sin diagnosticar y entre el 50 y el 70 % de los casos en las Américas no están controlados (OPS, 2021). El Atlas de la Diabetes de la FID (Federación Internacional de Diabetes) en su 10ª edición, incluyó estimaciones del gasto sanitario debido a la diabetes. El aumento del gasto mundial en salud debido a la diabetes ha sido considerable, pasando de USD 232 000 millones en el año 2007 a USD 966 000 millones en el año 2021 para adultos de 20 a 79 años. Esto representa un aumento del 316 % en 15 años. Como parte de este aumento puede atribuirse a la mejora en el registro y calidad de los datos según el Atlas. La FID estima que el gasto total en salud relacionado con la diabetes alcanzará los USD 1,03 billones para 2030 y USD 1,05 billones para 2045, considerando respectivamente incrementos del 66,4 % y del 9,1 % respecto a la estimación de 2021 (FID, 2021). Costa Rica pertenece a una de las regiones con mayor prevalencia del continente. La Tercera Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular, reportó para el 2018 una prevalencia de 10,9 % para la diabetes diagnosticada y de 3,9 % para la diabetes no reconocida previamente o no diagnosticada, dando así una prevalencia total de 14,8 % en la población general. De igual forma, en dicha encuesta se evidenció que en más del 70 % de los casos requería tratamiento farmacológico vía oral y en más del 60 % se indicó que requerían seguimiento en los servicios de salud para el seguimiento en su alimentación (CCSS, 2018). Según datos del Ministerio de Salud, para el año 2021 en Costa Rica se diagnosticaron un promedio de 26 personas diariamente por diabetes mellitus, para un total anual de 9.588 casos con esta enfermedad; de igual forma, 1.025 decesos corresponden a mujeres y 1.028 a hombres (MINSA, 2023). En el manejo de la Diabetes se debe tener en cuenta no sólo el metabolismo de la glucosa, sino también a factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, alteraciones de lípidos, el hábito de fumar, las enfermedades cardiovasculares, infecciones, interacciones farmacológicas y los efectos secundarios del tratamiento (CCSS, 2020). Por ello, la DM2 se encuentra contemplada dentro de las estrategias de abordaje tanto en los planes nacionales como los Institucionales; en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 publicada en diciembre del 2022, la DM2 se encuentra contemplada en la estrategia sectorial de salud con la intención de mejorar el diagnóstico preventivo de enfermedades como cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas en personas que presentan condiciones de riesgo para su salud, a través de uso de modelos de salud predictivos (MIDEPLAN, 2022). Y con base a esa línea de trabajo, la DM2 se encuentra visualizada tanto en el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2033 en su eje estratégico *Salud, Bienestar y protección económica - social centrado en las personas",* en su línea estratégica *"**1.j** Fortalecimiento del modelo de prestación de servicios de salud y su capacidad de gestión hacia un modelo centrado en las personas con un enfoque en el curso de vida, cuyas intervenciones se basen en evidencia científica para abordar las necesidades de salud de la población y las demandas territoriales, promoviendo la innovación, eficiencia, calidad y oportunidad en la prestación de servicios y la satisfacción de los usuarios*

	con responsabilidad ambiental y sostenibilidad financiera.”, definiendo en este último metas Institucionales para los indicadores de cobertura y de control óptimo de A1c.
Evidencia	Numerosos estudios han mostrado la eficacia de controlar individualmente los factores de riesgo para prevenir o reducir la enfermedad cardiovascular en personas con diabetes. Además, se han observado grandes beneficios cuando se abordan de forma simultánea múltiples factores de riesgo. Se ha demostrado que estrategias como el apoyo para el autocontrol del paciente, cambios en el equipo de atención, variaciones en el manejo de la enfermedad y la educación del paciente, son efectivas para disminuir la hemoglobina glicosilada (American Diabetes Association[ADA], 2017). Las recomendaciones en los Estándares de atención de las personas diabéticas tipo 2 analizadas por el subcomité de Estándares de Atención de la ADA y basados en una revisión sistemática bibliográfica, incluyen acciones de detección, diagnóstico y terapéuticas que se sabe o se cree que afectan favorablemente los resultados de salud de las personas con diabetes, de igual forma cubren la prevención, detección, diagnóstico y manejo de complicaciones y comorbilidades asociadas con la diabetes. (ADA, 2023).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Limitada capacidad para influir sobre los determinantes del control óptimo. Dificultades de acceso a poblaciones que habitan lejos de los puestos de atención. Estrategias: Utilizar los programas complementarios de atención para casos de difícil manejo: consulta farmacéutica y atención multidisciplinaria de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Aprovechamiento de las diferentes modalidades de atención. Capacitación técnica a los equipos de atención sobre el proceso de ajuste terapéutico y aprovechar al máximo las oportunidades de contacto con el usuario para cumplir con los exámenes y las recomendaciones de importancia clínica para mejorar la calidad del seguimiento. Acceso oportuno a las pruebas de laboratorio Aprovechamiento del uso de la tecnología para temas de educación.
Normativa Técnica	Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2 (CCSS, 2020).
Costo / Efectividad	El costo de implementar intervenciones para mejorar el control glicémico generalmente se compensa con las reducciones en gastos en el corto plazo. En una revisión sobre *“Costo-efectividad de las intervenciones de prevención de las diabetes dirigidas a individuos de alto riesgo y poblaciones enteras: una revisión sistemática”* sobre el Cuidado de la Diabetes de la ADA en el 2020, mostró que las estrategias de prevención basadas en la población son aquellas que se centran en toda la población, independientemente del nivel de riesgo, creando un impacto en la salud pública a través de la implementación de políticas, campañas y otras estrategias ambientales, para evaluarlo, se utilizó la mediana del cociente incremental de costo-efectividad (ICER), medida en costo por año de vida ajustado por calidad (AVAC) o costo ahorrado para medir la costo efectividad de las intervenciones; en donde se encontró que entre las intervenciones de estilo de vida, las que siguieron un currículo del Programa de Prevención de la Diabetes (DPP) tuvieron una mediana de ICER de $ 6,212 / AVAC, mientras que las que no siguieron un currículo DPP tuvieron una mediana de ICER de $ 13,228 / AVAC. En comparación con las intervenciones en el estilo de vida administradas individualmente o por un profesional de la salud, las ofrecidas en un contexto grupal o proporcionadas por una combinación de profesionales de la salud y trabajadores sanitarios tuvieron ICER más bajas; por lo tanto, se encontró que la mayoría de las intervenciones de prevención de la DM2 incluidas en la revisión fueron costo-efectivas o ahorraron costos (ADA, 2020). Por otro lado, la misma ADA en el 2017 publicó *“Evaluación económica de las intervenciones de mejora de la calidad diseñadas para mejorar el control glucémico en la diabetes: una revisión sistemática y un análisis de regresión ponderada”*, en la que se examinó las evaluaciones económicas de 46 intervenciones para mejorar el control glicémico entre personas con DM2, las intervenciones de mejoras de la calidad estudiadas fueron efectivas, lo que llevó a disminuciones promedio en HbA1c de 0.26 %, según los datos del Ensayo controlado aleatorio. En segundo lugar, el costo de implementar intervenciones generalmente se vio compensado por reducciones en los gastos de atención médica a corto plazo, de modo que los costos netos para el sistema de salud no fueron significativamente diferentes de cero. En tercer lugar,

	durante 20 años o más, los costos aumentaron junto con la supervivencia, pero el ICER fue inferior a $ 115,000 por AVAC en todos los estudios y poblaciones (ADA. 2017). Por ello, la Intervención en la atención a la población diabética tipo 2 resulta necesaria en el sistema de salud costarricense.
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar los resultados de cobertura y controles óptimos brindados en la atención de las personas diabéticas tipo 2 en el primer nivel de atención, con el fin de apoyar la toma de decisiones en la gestión en cuanto a acceso y abordaje en la prestación de servicios de salud.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuáles son los porcentajes de cobertura y control óptimo producto de las gestiones en la prestación de servicios de salud brindada en cuanto a acceso y abordaje para la atención de las personas diabéticas tipo 2 en el primer nivel de atención y su brecha con las metas vigentes?
Indicadores asociados a la intervención	06-01-1.0 Cobertura de atención de personas con diabetes mellitus tipo 2 06-02-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo 06-03-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial 06-04-1.0 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo
Anexos	No hay
Referencias Bibliográficas	American Diabetes Association. (2017). Standars of medical care in diabetes. *Diabetes Care, 40*(Suppl.1), s1s135. American Diabetes Association. (2018). *Economic Evaluation of Quality Improvement Interventions Designed to Improve Glycemic Control in Diabetes* . Diabetes Care, ADA. Economic Evaluation of Quality Improvement Interventions Designed to Improve Glycemic Control in Diabetes: A Systematic Review and Weighted Regression Analysis | Diabetes Care | American Diabetes Association (diabetesjournals.org) American Diabetes Association. (2020). *Cost-effectiveness of Diabetes Prevention Interventions Targeting High-risk Individuals and Whole Populations: A Systematic Review*. Diabetes Care, Vol.(43). ADA. Cost-effectiveness of Diabetes Prevention Interventions Targeting High-risk Individuals and Whole Populations: A Systematic Review | Diabetes Care | American Diabetes Association (diabetesjournals.org) American Diabetes Association. (2023). *Standards of Care in Diabetes to Guide Prevention, Diagnosis, and Treatment for People Living with Diabetes*. Diabetes Care. ADA. https://diabetesjournals.org/care/article/46/Supplement_1/S5/148048/Summary-of-Revisions-Standards-of-Care-in-Diabetes Caja Costarricense de Seguro Social. (2018). *Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular.* San José: Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social (EDNASSS)-CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social. (2019). *Plan Estratégico Institucional.* San José, Costa Rica: CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social. (2020). *Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2.* San José, Costa Rica: CCSS. Federación Internacional de Diabetes [FID]. (2021). *Atlas de la diabetes de la* FID. 10 ed. FID. https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf International Diabetes Federation [IDF]. (2020). *IDF Diabetes atlas*. 9 ed. IDF. https://www.diabetesatlas.org/en/ Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. [MIDEPLAN]. (2022). *Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.* San José, Costa Rica: CCSS. Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA]. (2022). *Fallecimientos por diabetes mellitus.* MINSA. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/43-noticias-2021/1150-fallecimientos-por-diabetes-mellitus-aumentaron-32-6-del-2019-al-2020 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2016). *Informe mundial sobre la diabetes.* OMS. http://www.who.int/diabetes/global-report Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2021). *Reporte Diabetes Mellitus.* OMS. https://www.paho.org/es/temas/diabetes.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 06-01-1.0

Elemento	Descripción	
Código	06-01-1.0	
Nombre	Cobertura de atención de personas con diabetes mellitus tipo 2	
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas de primera vez en el año, del total de población estimada a partir de la prevalencia. • Población estimada: Es el cálculo de la cantidad de personas de 20 años y más de la estimación de población por año elaborada por la Dirección Actuarial y Económica (DAE), multiplicado por el porcentaje de la prevalencia de personas diabéticas tipo 2 determinada en la última Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular. Incluye: • Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año, con el siguiente código: CIE-10: E11 (Diabetes mellitus no insulinodependiente) Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de consultas de primera vez en el año de personas de 20 años y más con diagnóstico de DM2. • Número de personas mayores de 20 años con DM2 estimada según prevalencia en el año.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas de 20 años y más con diagnóstico de DM2}}{\text{Número de personas mayores de 20 años con DM2 estimada según prevalencia en el año}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	51 %	
Meta	Quinquenal: 56 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de las personas de 20 años y más con diagnóstico de DM2. Dirección Actuarial y Económica: • Población de 20 años y más de la estimación de población por año elaborada por la DAE, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular: • Prevalencia determinada en la última encuesta.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	Para la estimación de la cobertura en áreas de salud, se le asigna al área en la que se realizó la consulta de primera vez en el año.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 06-02-1.0

Elemento	Descripción	
Código	06-02-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo	
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con valores óptimos de hemoglobina glicosilada (A1c) en sus resultados, del total de las personas atendidas con dicho diagnóstico. Control glicémico óptimo: • Valor de hemoglobina glicosilada (A1c) inferior a 7 % en la última medición del período, en la persona con diabetes mellitus tipo 2. En el caso de las personas mayores de 80 años se define un valor inferior a 8 %. Para el seguimiento anual se considera únicamente la medición hecha en el segundo semestre. Control glicémico no óptimo: • Resultados de A1c que no cumplen con valores óptimos. • Personas que no cuenten con registro de realización (fecha y resultado) de la prueba de laboratorio. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año. • Pruebas de laboratorio clínico: Listado de últimas hemoglobinas glicosiladas del segundo semestre (a partir del 1° de julio hasta el 31 de diciembre, inclusive). Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo. • Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo}}{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT-Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	38 %	
Meta	Quinquenal: 52 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. • Pruebas de laboratorio clínico (A1c) registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • A1c.	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	Para efectos de análisis, este indicador cuenta con el apoyo del indicador complementario: Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos una hemoglobina glicosilada en cada semestre.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 06-03-1.0

Elemento	Descripción	
Código	06-03-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial	
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con valores óptimos en sus cifras de presión arterial, del total de las personas atendidas con dicho diagnóstico. <u>Control óptimo de presión arterial:</u> • Cifras de presión arterial menores a 140/80 mmHg en la persona con diabetes mellitus tipo 2, en la última consulta con registro de PAS (presión arterial sistólica) y PAD (presión arterial diastólica), en el período. <u>Control no óptimo de presión arterial:</u> • Resultados de presión arterial que no cumplen con valores óptimos. • Personas en cuyo apartado de signos vitales no tenga registro de toma de presión arterial en el período. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año. • Cifras de Presión Arterial: a partir de la información del Cubo DCSS EPSS-Cardiovascular-DM2, correspondiente al apartado de PAS y PAD, que incluye la última cifra de presión arterial registrada en la atención de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Excluye: • Listado de personas que no tengan registro de presión arterial en el Cubo descrito, cuya última consulta haya sido efectuada en un PVP (Puesto de Visita Periódica) y su registro se realizara en el expediente físico.	
Variables involucradas en la medición	• Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de presión arterial. • Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de presión arterial}}{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT-Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	50 %	
Meta	Quinquenal 60 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. • Cifras de presión arterial registradas en el énfasis correspondiente.	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 06-04-1.0

Elemento	Descripción	
Código	06-04-1.0	
Nombre	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo	
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con valores óptimos en sus resultados de LDL. Control óptimo de LDL: • Valor de colesterol-LDL menor a 100 mg/dL en la última medición del perfil lipídico en la persona con diabetes mellitus tipo 2 en el período. Control no óptimo de LDL: • Resultados de LDL que no cumplen con valores óptimos. • Cuando el valor de los triglicéridos en esa últimamedición es de 400 mg/dL o mayor. • Personas que no cuenten con registro de realización (fecha y resultado) de la prueba de laboratorio. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año. • Pruebas de laboratorio clínico: Listado de último perfil lipídico del año (incluye LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL con la misma fecha de realización). Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo. • Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo.}}{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT -Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	35 %	
Meta	Quinquenal 45 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. • Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente que incluya resultado y fecha de realización (LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL con la misma fecha de realización). Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Perfil lipídico (incluye LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL con la misma fecha de realización).	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	Para efectos de análisis, este indicador cuenta con el apoyo del indicador complementario: Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos un perfil lipídico al año.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo	
Indicador Complementario	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos una hemoglobina glicosilada en cada semestre (V-1.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con la realización de al menos una A1c en cada semestre, del total de las personas atendidas con dicho diagnóstico. Prueba de laboratorio realizado: • Corresponde a la A1c en la que conste fecha y resultado realizada en el período. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año. • Pruebas de laboratorio clínico: Listado de hemoglobinas glicosiladas de cada semestre (del 1° de enero al 30 de junio y del 1° de julio hasta el 31 de diciembre, inclusive). Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con al menos un resultado de hemoglobina glicosilada por semestre. • Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2.	
Fórmula de cálculo	Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con al menos un resultado de hemoglobina glicosilada por semestre / Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 x 100	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	67 %	
Periodicidad	Semestral	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. • Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente que incluya resultado y fecha de realización (LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL con la misma fecha de realización). Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • A1c.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud.	
Comentarios generales	No aplica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo	
Indicador Complementario	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con realización de al menos un perfil lipídico al año (V-1.0).	
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con la realización de al menos un perfil lipídico en el año, del total de las personas atendidas con dicho diagnóstico. Prueba de laboratorio realizado: • Corresponde al perfil lipídico (incluye LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL), en el que conste fecha y resultado realizado en el período. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año. • Pruebas de laboratorio clínico: Listado de último perfil lipídico del año (incluye LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL). Estos resultados deben de coincidir en fecha de realización. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con al menos un resultado de perfil lipídico. • Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con al menos un resultado de perfil lipídico}}{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	87 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. • Pruebas de laboratorio clínico (A1c) registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Perfil lipídico (incluye LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL).	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica.	

07-ECNT: HIPERTENSIÓN ARTERIAL

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial. En la región de las Américas, 30 % de la población tiene presión arterial alta, siendo responsable del 30 % de las muertes (Organización Panamerica de la Salud [OPS], 2023). Es considerado un problema de Salud Pública, ya que las personas con menos recursos tienen más riesgo de enfermedades cardiacas, eventos cerebrovasculares, así como menos acceso a la prevención o al tratamiento (OPS, 2023). Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de Costa Rica, durante el año 2022 se registró un aumento en las defunciones asociadas a la HTA (Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA], 2023). Para el año 2021 en Costa Rica, se notificaron 19 507 nuevos casos con hipertensión arterial, en promedio, 53 personas diagnosticadas diariamente con esta enfermedad (MINSA, 2023). Según la Encuesta de Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, 2018; en la población general, la prevalencia de HTA diagnosticada fue de 32,4 %, mientras que para la no diagnosticada fue de 4,8 % (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2021). El abordaje de esta patología y otras enfermedades crónicas está contenido en las Líneas Estratégicas Institucionales, en los puntos 2.a, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g y 2.h (CCSS, 2023).
Evidencia	En el 2021 el US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomendó el tamizaje de HTA usando la toma de la presión arterial en el consultorio, para adultos de 18 años y más, y el monitoreo de esta fuera de los consultorios para el diagnóstico y confirmación antes de iniciar el tratamiento (Grado A). Los beneficios del tamizaje de la hipertensión son altamente certeros; además, cuando se fija un objetivo de Presión arterial (PA) más bajo (140 mmHg de PAS en la población general y 130 mmHg de PAS en una población de alto riesgo), estos compensan los daños de forma evidente. La certidumbre general varió de moderada a alta, dependiendo del valor de PA y el fármaco utilizado (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). La OMS recomienda (OMS, 2022): • Inicio del tratamiento farmacológico antihipertensivo en personas con diagnóstico confirmado de HTA y PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg (Moderada a Alta). • Tratamiento farmacológico antihipertensivo: para las personas con enfermedades cardiovasculares existentes y PAS de 130-139 mmHg (Moderada a Alta); en personas sin enfermedades cardiovasculares, pero con riesgo cardiovascular alto, diabetes mellitus o insuficiencia renal crónica y PAS de 130-139 mmHg (Moderada a Alta). El objetivo de tratamiento establece una PA para los pacientes con HTA sin comorbilidades es de <140/90 mmHg; y de PAS <130 mmHg en los pacientes con HTA y enfermedades cardiovasculares (ECV) conocidas y en los de alto riesgo (aquellos con alto riesgo de ECV, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica) (Moderada).
Consideraciones de Implementación	Limitaciones: Áreas de Salud con Puestos de Visita Periódica (registros solo en Sistema Integrado de Agendas y Citas (SIAC)). Capacidad insuficiente de los servicios de salud para solventar la demanda (agendas saturadas y cupos reducidos). Horarios institucionales convencionales y semejantes a los laborales de la población. Proceso de toma de presión arterial inadecuado, donde no se cumple con el protocolo, existiendo deficiencias en la toma o el registro de cifras. Eventualidades en los sistemas informáticos de registro y almacenamiento (perdida de información e incapacidad de acceso). Normativa institucional desactualizada, 2009 Estrategias: Mejorar la conectividad en los puestos de visita periódica, y uso de EDUS/SIES. Instaurar horarios de atención vespertinos y estimular los medios alternativos de atención. Mejorar los registros de atenciones y de las cifras de presión arterial tanto en el Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF), como en Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES). Crear aplicativos que permitan acceso a la información necesaria para brindar una atención en salud al paciente en momentos de “caída” de los sistemas o de riesgos de seguridad informática, de manera que se permita el registro y consulta fuera de línea de las atenciones y luego estos datos se puedan migrar al EDUS. Está pendiente la publicación del nuevo protocolo de HTA.

Normativa Técnica	• Guías para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, 2009. • Guía para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, 2015. • Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad 2022-2030. • Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad, 2023.
Costo / Efectividad	Un estudio costo - efectividad arrojó una disminución de los costos si los pacientes con hipertensión están controlados y esta reducción es aún mayor si reciben atención farmacéutica (Castro et al., 2016). El tratamiento de la HTA (tratar a todos con PA ≥140/90 mmHg) ha demostrado ser rentable y una intervención idónea, según el estudio de Kostova. Tratar a los pacientes de alto riesgo o con ECV y PA basal de 130-139 mmHg ha demostrado ser rentable, pero no ahorra costos (análisis de rentabilidad del estudio SPRINT); el valor depende de mantener el efecto de la intervención durante más de cinco años (OMS, 2022). En lo que respecta a los costos, Jacob et al. resumieron los datos de 31 estudios (24 de los EE.UU.) e indicaron que los estudios que emplean estrategias de trabajo en equipo comunitario producen un ahorro de costos en general. La mayoría de las estimaciones de años de vida ajustados por costo/calidad (AVAC) oscilaron entre US$ 3 888 y US$ 24 000/AVAC, y en ellas, los programas dirigidos por farmacéuticos fueron más rentables que los dirigidos por profesionales de enfermería (OMS, 2022).
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar el porcentaje de acceso de las personas con HTA a los servicios de atención en salud y así, se controlen sus cifras de presión arterial. Establecer el porcentaje de personas con control óptimo de presión arterial, de acuerdo con sus factores de riesgo, grupo de edad y sexo, de manera que se contribuya a disminuir su riesgo cardiovascular, carga de enfermedad y morbimortalidad, desde una visión integral y articulada.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la variación interanual en la cobertura de atención personas con HTA? ¿Cuál es el porcentaje de personas atendidas en primer nivel de atención cuyas cifras de presión arterial son óptimas según sus factores de riesgo?
Indicadores asociados a la intervención	07-01-1.0 Cobertura de atención a personas con HTA. 07-02-1.0 Control óptimo de la presión arterial en personas con HTA.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Anstey, E., Bradley, C., Shimbo, D. (2021). USPSTF Recommendation Statement on Hypertension Screening in Adults—Where Do We Go From Here? *JAMA Netw Open*, *4*(4). doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.4203 Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018). Plan Estratégico Institucional 2019-2022. CENDEISSS. https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATÉGICO-INSTITUCIONAL-2019-2022.pdf Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, tercera encuesta 2018. San José: EDNASS-CCSS. Castro, L. P., Soria, I. C., Casco, E. C., & Vallejo, M. D. (2016). Análisis de costo-efectividad e impacto presupuestal de un programa de atención farmacéutica para pacientes hipertensos de un hospital de tercer nivel de México. *Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas*, 25. Ministerio de Salud de Costa Rica. (17 de mayo de 2023). Medí tu presión arterial con precisión, contrólala, viví más. Ministerio de Salud Gobierno de Costa Rica.https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1592-casos-notificados-de-hipertension-arterial-disminuyen-un-19-6-durante-2022#:~:text=Sin%20embargo%2C%20las%20defunciones%20asociadas,muertes%20asociadas%20a%20esta%20enfermedad. Organización Mundial de la Salud. (2022). Directriz para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en adultos. Organización Mundial de la Salud. https://iris.who.int/handle/10665/364491 Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (21 de agosto de 2023). Hipertensión. OPS. https://www.paho.org/es/temas/hipertension2Laquesis#Atropos

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 07-01-1.0

Elemento	Descripción	
Código	07-01-1.0	
Nombre	Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA)	
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más que son atendidas por HTA (código diagnóstico CIE-10: I10x), en el periodo, en relación con la cantidad de personas con HTA según el dato más reciente de prevalencia estimada. Incluye: • Consultas de primera vez de personas de 20 años y más con diagnóstico de HTA en el periodo. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas con HTA de 20 años y más atendidas de primera vez en el periodo • Número de personas de 20 años y más de la población estimada por año • Prevalencia de HTA de este grupo de edad	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas con HTA de 20 años y más atendidas de primera vez, en el periodo}}{\text{(Número de personas de 20 años y más de la pirámide poblacional) X (Prevalencia de HTA de este grupo de edad)}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HTA
Línea base	48 %	
Meta	Quinquenal: 52 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Reporte de HTA o Cubo Cardiovascular): • Consultas de primera vez por HTA Dirección Actuarial y Económica: • Población estimada de 20 años y más por año, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sub- Área de Vigilancia Epidemiológica: • Prevalencias determinadas en la última Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo) • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas. Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo. • Tamizaje de hipertensión arterial (HTA), en el escenario domiciliar	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 07-02-1.0

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Código</td><td>07-02-1.0</td></tr>
<tr><td>Nombre</td><td>Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA).</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td>Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más que fueron atendidas por HTA (código diagnóstico CIE-10: I10x), y presentan cifras óptimas de presión arterial (PA) en el periodo, según los siguientes parámetros.
<table>
<tr><th>Condición/Enfermedad</th><th>Cifras óptimas</th></tr>
<tr><td>Población General</td><td>PA < 140/90 mmHg</td></tr>
<tr><td>Población General mayor de 80 años</td><td>PA < 150/90 mmHg</td></tr>
<tr><td>Diabetes Mellitus</td><td>PA < 140/80 mmHg</td></tr>
<tr><td>Nefropatía</td><td>PA < 140/80 mmHg</td></tr>
</table>
Cifras óptimas de presión arterial: Valores menores a los limites superiores de presión arterial sistólica y diastólica (que han demostrado no aumentar el riesgo cardiovascular de las personas con HTA), según las guías de manejo de personas con esta patología.
Puesto de Visita Periódica (PVP): Edificación ubicada en localidades con problemas de accesibilidad geográfica o funcional: donde en forma periódica, un EBAIS se traslada desde la sede del área o de ebáis para brindar los servicios de atención integral en salud a la población.
Incluye:
• Consulta de primera vez en el año de personas de 20 años y más con diagnóstico de HTA, en el periodo.
• Última consulta con registro de PA en personas de 20 años y más con diagnóstico de HTA, en el periodo.
Excluye:
• Consultas con registro de cifras de PA inconsistentes (PAS< 50 mmHg, PAD < 40 mmHg).
• Consultas sin registro de PA, realizadas en puestos de visita periódica que no cuentan con SIES.</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td>• Número de personas con HTA de 20 años y más con últimas cifras de PA óptimas en el periodo
• Número de personas con HTA de 20 años y más atendidas de primera vez en el periodo</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td>$\frac{\text{Número de personas con HTA de 20 años y más con últimas cifras de PA óptimas en el periodo}}{\text{Número de personas con HTA de 20 años y más atendidas de primera vez en el periodo}} \times 100$</td></tr>
<tr><td>Desagregación</td><td>
<table>
<tr><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención / Tratamiento</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HTA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td>52%</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td>Quinquenal: 65 %</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>Expediente Digital Único en Salud (Reporte de HTA o Cubo Cardiovascular):
• Atenciones realizadas y cifras de presión arterial</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Indicador de Resultado</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td>• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo)
• Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td>Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.
Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementario:
• Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo.</td></tr>
</table>

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td>Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA)</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td>Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo (V-1.0)</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td>Corresponde al porcentaje de personas según grupo de edad y sexo atendidas por HTA (código diagnóstico CIE-10: I10x), en el periodo, en relación con la cantidad de personas con HTA según el dato más reciente de prevalencia estimada.
Incluye:
• Consultas de primera vez de personas con diagnóstico de HTA en el periodo, según: Grupos de edad (20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más) y sexo (Masculino y Femenino).
Excluye:
• No aplica</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td>• Número de personas con HTA según grupo de edad y sexo, atendidas de primera vez en el periodo.
• Número de personas según grupo de edad y sexo de la población estimada por año
• Prevalencia de HTA según grupo de edad y sexo</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td>$\frac{\text{Número de personas con HTA según grupo de edad y sexo atendidas de primera vez en el periodo}}{\text{(Número de personas según grupo de edad y sexo de la pirámide poblacional) X (Prevalencia de HTA según grupo de edad y sexo)}} \times 100$</td></tr>
<tr><td>Desagregación</td><td><table>
<tr><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HTA</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td><table>
<tr><th>Grupo de edad (años)</th><th>Resultado esperado (%)</th></tr>
<tr><td>20 a 39</td><td>17,7</td></tr>
<tr><td>40 a 64</td><td>50,5</td></tr>
<tr><td>65 y más</td><td>76,8</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Quinquenal</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>Expediente Digital Único en Salud (Reporte de HTA o Cubo Cardiovascular):
• Consultas de primera vez
Dirección Actuarial y Económica:
• Población estimada de 20 años y más por año, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por año.
Sub-Área de Vigilancia Epidemiológica:
• Prevalencias determinadas en la última Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular.</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Indicador de Proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td>Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td>Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.</td></tr>
</table>

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td>Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA)</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td>Cobertura de atención con control óptimo de presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo (V-1.0)</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td>Corresponde al porcentaje de personas según grupo de edad y sexo que son atendidas por HTA (código diagnóstico CIE-10: I10x), y presentan cifras óptimas de presión arterial (PA) en el periodo (parámetros abajo indicados), en relación con la cantidad de personas con HTA, según el dato más reciente de prevalencia estimada.
<table>
<tr><td>Condición/Diagnostico</td><td>Cifras óptimas</td></tr>
<tr><td>Población General</td><td>PA < 140/90 mmHg</td></tr>
<tr><td>Población General mayor de 80 años</td><td>PA < 150/90 mmHg</td></tr>
<tr><td>Diabetes Mellitus</td><td>PA < 140/80 mmHg</td></tr>
<tr><td>Nefropatía</td><td>PA < 140/80 mmHg</td></tr>
</table>
Cifras óptimas de presión arterial: Valores menores a los limites superiores de presión arterial sistólica y diastólica (que han demostrado no aumentar el riesgo cardiovascular de las personas con HTA), según las guías de manejo de personas con esta patología.
Puesto de Visita Periódica (PVP): Edificación ubicada en localidades con problemas de accesibilidad geográfica o funcional: donde en forma periódica, un EBAIS se traslada desde la sede del área o de ebáis para brindar los servicios de atención integral en salud a la población.
Incluye:
• Consultas de primera vez de personas de los grupos de edad de 20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más. Sexo Masculino y Femenino con diagnóstico de HTA en el periodo.
• Última consulta de personas de los grupos de edad de 20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más. Sexo Masculino y Femenino con diagnóstico de HTA en el periodo, con registro de PA.
• Última consulta con registro de PA en personas de los grupos de edad de 20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más. Sexo Masculino y Femenino con diagnóstico de HTA, en el periodo.
Excluye:
• Consultas con HTA y cifras de PA inconsistentes (PAS< 50 mmHg, PAD < 40 mmHg).
• Consultas sin registro de PA realizadas en puestos de visita periódica que no cuenta con SIES.</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td>• Número de personas con HTA según grupo de edad y sexo, con últimas cifras de PA óptimas, en el periodo
• Número de personas según grupo de edad y sexo de la pirámide poblacional.
• Prevalencia de HTA según grupo de edad y sexo.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td>$$\frac{\text{Número de personas con HTA según grupo de edad y sexo, con últimas cifras de PA óptimas en el periodo}}{\text{(Número de personas según grupo de edad y sexo de la pirámide poblacional) X (Prevalencia de HTA según grupo de edad y sexo)}} \times 100$$</td></tr>
<tr><td>Desagregación</td><td>
<table>
<tr><td>Nivel de atención</td><td>Primer nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención / Tratamiento</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HTA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td>Se define con los resultados de la EPSS 2024</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Quinquenal: en construcción</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>Expediente Digital Único en Salud (Reporte de HTA o Cubo Cardiovascular):
• Atenciones realizadas y cifras de presión arterial.
Dirección Actuarial y Económica:
• Población estimada de 20 años y más por año, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Sub-Área de Vigilancia Epidemiológica:
• Prevalencias estimadas en la última Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Indicador de Resultado</td></tr>
</table>

Presentación de resultados	Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de atención a personas con hipertensión arterial (HTA)	
Indicador Complementario	Porcentaje de personas de 20 años y más atendidas en el escenario domiciliar por el ATAP con registro de cifras de presión arterial en SIFF (V-1.0)	
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más que se les realizó una atención en una visita domiciliar efectiva por los Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP), y se les registraron sus cifras de presión arterial (PA), en relación con todas las personas de ese rango de edad atendidas en visita domiciliar, en el periodo. Visita Domiciliaria: es la actividad básica del programa de Atención Primaria. Por medio de ella se realiza un intercambio de información entre la familia y el funcionario. En esta actividad se tiene la oportunidad de conocer la situación familiar, el ambiente físico y sus recursos. Para tal efecto se utiliza la Ficha Familiar, la cual el Asistente de Atención Primaria (ATAP) debe portar como instrumento, en conjunto con otros y llenarlo conforme a la información obtenida de la familia. Para tal efecto se utiliza la Ficha Familiar, la cual el Asistente de Atención Primaria (ATAP) registra en el aplicativo SIFF del EDUS conforme a la información obtenida de la familia. Visita Domiciliaria Efectiva: Es considerada como tal, cuando el funcionario realiza un mínimo de tres actividades, por familia dependiendo del número de miembros de esta. Incluye: • Todas las personas de 20 años y más presentes en su domicilio cuando se les realizó una visita domiciliar efectiva por los ATAP, en el periodo. Excluye: • Todas las personas de 20 años y más no asociadas a un núcleo familiar registrado en las fichas familiares adscritas al sector correspondiente.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 20 años y más que recibieron una atención en la visita domiciliar por el ATAP y se les registraron sus cifras de PA en el SIFF, en el periodo. • Número de personas de 20 años y más a las que se realizó una atención en una visita domiciliar efectiva, en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 20 años y más que recibieron una atención en la visita domiciliar por el ATAP y se les registraron sus cifras de PA en el SIFF, en el periodo}}{\text{Número de personas de 20 años y más a las que se realizó una atención en una visita domiciliar efectiva, en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Visita Domiciliar
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HTA
Línea base	Se define con los resultados de la EPSS 2024	
Periodicidad	Quinquenal	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (EDUS), Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF): • Visitas domiciliares realizadas (efectivas y no efectivas), atenciones y cifras de presión arterial registradas.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 04

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura de atención a personas con HTA	
Indicador Complementario	Porcentaje de personas no conocidas con hipertensión arterial (no HTA), tamizadas por el ATAP en el escenario domiciliar (V-1.0)	
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más no conocidas con HTA (no HTA), a las que se les realiza una visita domiciliar efectiva; por los Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP), y se les registran sus cifras de PA en el Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF), en relación con la cantidad de personas no conocidas con HTA según prevalencia estimada, en el periodo. Visita Domiciliaria Efectiva: Es considerada como tal, cuando el funcionario realiza un mínimo de tres actividades, por familia dependiendo del número de miembros de esta. No conocido hipertenso: Persona de 20 años y más que en la ficha familiar no este consignada como persona con hipertensión arterial Incluye: • Todas las personas de 20 años y más no HTA presentes en el domicilio cuando se les realiza una visita domiciliar efectiva por los ATAP, en el periodo. Excluye: • Todas las personas de 20 años y más conocidas con HTA (código I10 a I15 de la CIE-10 en SIAC/SIES).	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 20 años y más, no conocidas HTA, presentes en el domicilio a las que el ATAP les registra medición de la PA en el SIFF en una visita domiciliar efectiva, en el periodo. • Número de personas de 20 años y más de la población estimada por año. • Prevalencia estimada de no HTA de este grupo de edad.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 20 años y más, no conocidas HTA, presentes en el domicilio a las que el ATAP les registra medición de la PA en el SIFF en una visita domiciliar efectiva, en el periodo.}}{\text{(Número de personas de 20 años y más de la pirámide poblacional) X (Prevalencia estimada de no HTA de este grupo de edad)}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Visita Domiciliar
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HTA
Línea base	Se define con los resultados de la Evaluación de la prestación de Servicios de Salud 2024	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (EDUS), Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF): • Visitas domiciliares efectivas, atenciones de primera vez en el año y cifras de presión arterial Expediente Digital Único en Salud (EDUS), Reporte de HTA o Cubo Cardiovascular: • Consultas de primera vez de personas con HTA Dirección Actuarial y Económica: • Población estimada de 20 años y más por año, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sub- Área de Vigilancia Epidemiológica: • Prevalencias determinadas en la última Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención en Salud	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 05

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td>Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA)</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td>Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA), según grupo de edad y sexo (V-1.0)</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td>Corresponde al porcentaje de personas según grupo de edad y sexo que son atendidas por HTA (código diagnóstico CIE-10: I10x) y presentan cifras de presión arterial (PA) controladas en el periodo, según los siguientes parámetros.
<table>
<tr><th colspan="2">Condición/Diagnóstico</th></tr>
<tr><td>Población General</td><td>PA < 140/90 mmHg</td></tr>
<tr><td>Población General mayor de 80 años</td><td>PA < 150/90 mmHg</td></tr>
<tr><td>Diabetes Mellitus</td><td>PA < 140/80 mmHg</td></tr>
<tr><td>Nefropatía</td><td>PA < 140/80 mmHg</td></tr>
</table>
Cifras de presión arterial controladas: Valores menores a los limites superiores de presión arterial sistólica y diastólica (que han demostrado no aumentar el riesgo cardiovascular de las personas con HTA), según las guías de manejo de personas con esta patología.
Puesto de Visita Periódica (PVP): Edificación ubicada en localidades con problemas de accesibilidad geográfica o funcional: donde en forma periódica, un EBAIS se traslada desde la sede del área o de ebáis para brindar los servicios de atención integral en salud a la población.
Incluye:
• Consulta de primera vez en el año de personas con diagnóstico de HTA, según grupos de edad (20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más) y sexo (Masculino y Femenino), en el periodo.
• Última consulta con registro de PA en personas con diagnóstico de HTA, según grupos de edad (20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más) y sexo (Masculino y Femenino), en el periodo.
Excluye:
• Consultas con registro de cifras de PA inconsistentes (PAS< 50 mmHg, PAD < 40 mmHg).
• Consultas sin registro de PA, realizadas en puestos de visita periódica que no cuentan con SIES.</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td>• Número de personas con HTA con última cifra de PA controlada en el periodo, según grupo de edad y sexo
• Número de personas con HTA atendidas de primera vez en el periodo, según grupo de edad y sexo</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td>$\frac{\text{Número de personas con HTA con última cifra de PA controlada en el periodo, según grupo de edad y sexo}}{\text{Número de personas con HTA atendidas de primera vez en el periodo, según grupo de edad y sexo}} \times 100$</td></tr>
<tr><td>Desagregación</td><td>
<table>
<tr><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención / Tratamiento</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HTA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td>
<table>
<tr><th>Grupo de edad (años)</th><th>Meta</th></tr>
<tr><td>20 a 64</td><td>58</td></tr>
<tr><td>65 y más</td><td>54</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Quinquenal</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>Expediente Digital Único en Salud (Reporte de HTA o Cubo Cardiovascular):
• Atenciones realizadas y cifras de presión arterial</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Indicador de Resultado</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td>Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td>Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas. Para efecto de análisis este indicador apoya al indicador:
• Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión arterial (HTA).</td></tr>
</table>

09-ECNT: CÁNCER

INTERVENCIÓN – PREVENCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	El cáncer de cuello uterino es el cuarto en frecuencia entre el sexo femenino en el mundo (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022); aunado a ello, datos estadísticos indican que en el año 2020 se reportaron 604 127 nuevos casos y una mortalidad de 341 831 personas a nivel mundial (Sung et al., 2021). En Costa Rica, las últimas estadísticas del Ministerio de Salud con respecto al cáncer colocaron al cervicouterino en tercer lugar en incidencia y en cuarto lugar en mortalidad (Ministerio de Salud [MINSA], 2019), lo cual resulta similar a los datos estadísticos mundiales del 2020. En Costa Rica para este tipo de cáncer se encuentra en el decreto ejecutivo Nº 33119-S, el cual expone las "Normas y Procedimientos de Atención Integral a la Mujer para la Prevención y Manejo del Cáncer de Cuello de Útero, para el I y II Nivel de atención y Normas de Laboratorios de Citología" siendo la población blanco toda mujer de 20 años y más que haya iniciado relaciones sexuales coitales; la frecuencia del tamizaje es cada dos años y por último propone una meta anual de 42,5 % de cobertura. Para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esta intervención se realiza por medio de Papanicolaou o Test de Virus de Papiloma Humano (VPH); este último todavía no se encuentra generalizado para todos los establecimientos.
Evidencia	A pesar de lo anterior, este tipo de cáncer tiene gran oportunidad de ser prevenible, diagnosticado en fases tempranas y, por ende, tener un tratamiento eficaz con una resolución satisfactoria; incluso, "podría convertirse en el primer cáncer en ser eliminado" (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2022). La frase anterior tiene como base la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino como un problema de salud pública (en inglés); en donde los principales procesos para lograr ese objetivo son: vacunación, tamizaje y tratamiento preventivo, lo cual llevaría a reducir la incidencia a menos de cuatro casos por cada 100 000 mujeres (OMS, 2020).
Consideraciones de Implementación	Barreras: En la parte asistencial, referente al sexo del personal que realiza la consulta, ya que, si el colaborador es hombre, la posibilidad de que la paciente se realice el tamizaje disminuye. Por otra parte, al incorporar en los sistemas se incluyen bajo el mismo código CIE-10 (como diagnóstico de consulta) o CIE-9 (como procedimiento), lo que imposibilita al 2023 la separación entre papanicolaou y test de VPH. Estrategias: Se han vistos varias estrategias exitosas como: participación de personal femenino para la toma de la muestra de estos tamizajes en el EBAIS, en fechas específicas. También se ha visto éxito con la implementación de ferias de salud. El "Cubo Citologías Salud" incorpora la variable "Tipo solicitud citológica" que permite separar entre "vaginal" (papanicolaou) y "molecular" (test de VPH), sin embargo, a la fecha no incorpora todos los establecimientos de salud.
Normativa Técnica	• Lineamiento en mejora de la prevención y detección del cáncer de cérvix (2014). • Manual de Normas y Procedimientos de Atención Integral a la Mujer para la Prevención y Manejo del Cáncer de Cuello de Útero, I-II y III Nivel de Atención y Normas de Laboratorio de Citología (Decreto Ejecutivo Nº 33119).
Costo / Efectividad	Las pruebas de tamizaje para cáncer de cuello de útero con mayor costo-efectividad son: Papanicolaou y VPH, ya que requieren menos cantidad de visitas a los centros de salud, siendo la segunda la de mayor costo-efectividad. Ambas pruebas son realizadas por la CCSS y son parte del numerador de los indicadores asociados a esta intervención.
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar la cobertura de tamizaje de cáncer de cuello uterino realizada en el primer nivel por la CCSS en mujeres de 20 a 64 años; de forma institucional, por red integrada de prestación de servicios de salud y área de salud, para contribuir a mejorar las estrategias de acceso y oportunidad.

Pregunta (s) de Evaluación	¿Cómo evolucionan los porcentajes de cobertura del tamizaje con citología cérvico-vaginal en comparación con los resultados obtenidos durante los años de pandemia por Covid-19? ¿Cuál es la diferencia entre áreas de salud respecto al porcentaje de realización de tamizaje de cáncer de cuello uterino a las mujeres que consultan en el primer nivel? ¿Cuál el avance en la implementación de la prueba de VPH por áreas de salud y por RIPSS?
Indicadores asociados a la intervención	09-01-1.0 Cobertura bienal de tamizaje con citología cérvico-vaginal por PAP en mujeres de 20 a 29 años. 09-02-1.0 Cobertura bienal de tamizaje con citología cérvico-vaginal en mujeres de 30 a 64 años.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Ministerio de Salud [MINSA]. (2019). Análisis de incidencia y mortalidad por cáncer. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas-y-bases-de-datos-vigilancia-de-la-salud/estadisticas-vigilancia-de-la-salud/estadistica-de-cancer-registro-nacional-tumores Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (5 de enero de 2022). El cáncer cervicouterino es prevenible, la OMS llama hacer historia eliminándolo. https://news.un.org/es/story/2022/01/1502202 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (20 de enero de 2022). Cáncer Cervicouterino. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (17 de noviembre de 2020). Por un futuro sin cáncer del cuello uterino: por primera vez el mundo se ha comprometido a eliminar un cáncer. https://www.paho.org/es/noticias/17-11-2020-por-futuro-sin-cancer-cuello-uterino-por-primera-vez-mundo-se-ha-comprometido Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: a cancer journal for clinicians*, *71*(3), 209–249. https://doi.org/10.3322/caac.21660

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 09-01-2.0

Elemento	Descripción	
Código	09-01-2.0	
Nombre	Cobertura bienal de tamizaje con citología cérvico-vaginal por PAP en mujeres de 20 a 29 años.	
Definición conceptual	Este indicador representa el porcentaje de mujeres de 20 a 29 años tamizadas con citología cérvico-vaginal por medio de papanicolaou (PAP) al menos una vez en los últimos dos años respecto a la población de mujeres de esa edad de la estimación de población por año elaborada por la Dirección Actuarial y Económica (DAE), utilizando para ello el dato del segundo año. Incluye: • El primer PAP realizada en el periodo. • Mujeres que se le realizó citología cérvico-vaginal con PAP. • Código diagnóstico CIE 10: Z014 y Z124 • Nombre del procedimiento: Citología cérvico-vaginal, Papanicolau, Tomar citología, Tomar citología cérvico-vaginal y Tomar muestra de pap. Excluye: • Tamizajes por medio de test de Virus de Papiloma Humano (VPH).	
Variables involucradas en la medición	• Número de mujeres de 20 a 29 años con PAP realizado en los últimos dos años. • Número de mujeres de 20 a 29 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres de 20 a 29 años con PAP realizado en los últimos dos años}}{\text{Número de mujeres de 20 a 29 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Cáncer
Línea base	19 %	
Meta	Quinquenal: 70 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes, Cubo DCSS EPSS-Procedimientos, Cubo Citologías Salud): • Mujeres de 20 a 29 años a las que se le realizó citología cérvico-vaginal con PAP. Dirección Actuarial y Económica: • Mujeres de 20 a 29 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Indicador de proceso	

Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (Anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje bienal de mujeres de 20 a 64 años atendidas a las que se les realizó el tamizaje con citología cervicovaginal. • Porcentaje de mujeres con citología cérvico-vaginal por grupo de edad según tipo de prueba.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 09-02-2.0

Elemento	Descripción	
Código	09-02-2.0	
Nombre	Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de cérvico-uterino en mujeres de 30 a 64 años.	
Definición conceptual	Este indicador representa el porcentaje de mujeres de 30 a 64 años tamizadas con citología cérvico-vaginal por medio de papanicolaou (PAP) y test de virus de papiloma humano (VPH) al menos una vez en los últimos dos años respecto a la población de mujeres de esa edad de la estimación de población por año elaborada por la Dirección Actuarial y Económica (DAE), utilizando para ello el dato del segundo año. Incluye: • El primer PAP o VPH realizado en el periodo. • Mujeres que se le realizó citología cérvico-vaginal con PAP o VPH. • Código diagnóstico CIE 10: Z014 y Z124 • Nombre del procedimiento: Citología cérvico-vaginal, Papanicolau, Tomar citología, Tomar citología cérvico-vaginal, Tomar muestra de pap, Realizar tamizaje virus papiloma humano y Tamizaje virus papiloma humano. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	Número de mujeres de 30 a 64 años con PAP o VPH realizado en los últimos dos años. Número de mujeres de 30 a 64 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres de 30 a 64 años con PAP o VPH realizado en los últimos dos años}}{\text{Número de mujeres de 30 a 64 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Cáncer
Línea base	27 %	
Meta	Quinquenal: 70 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes, Cubo DCSS EPSS-Procedimiento, Cubo Citologías Salud): • Listado de mujeres de 30 a 64 años a las que se le realizó citología cérvico-vaginal con PAP. Dirección Actuarial y Económica: • Mujeres de 30 a 64 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	

Clasificación	Indicador de proceso
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (Anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje bienal de mujeres de 20 a 64 años atendidas a las que se les realizó el tamizaje con citología cervicovaginal. • Porcentaje de mujeres con citología cérvico-vaginal por grupo de edad según tipo de prueba.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	• Cobertura bienal de tamizaje con citología cérvico-vaginal por PAP en mujeres de 20 a 29 años. • Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de cérvico-uterino en mujeres de 30 a 64 años.	
Indicador Complementario	Porcentaje bienal de mujeres de 20 a 64 años atendidas a las que se les realizó el tamizaje de cáncer cérvico-uterino (V-2.0)	
Definición conceptual	Porcentaje de mujeres atendidas en el primer nivel de atención de la CCSS a las que se les realizó una citología cérvico-vaginal PAP o VPH de tamizaje de cáncer cérvico-vaginal según los grupos de edad definidos en los indicadores de evaluación. Incluye: • Población de mujeres de 20 a 64 años a las que se le realizó tamizaje de cáncer cérvico-uterino (PAP o VPH): como definida en el indicador de evaluación. • Población de mujeres de 20 a 64 años que consultan en el primer nivel de atención en los últimos dos años. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Número de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino por grupo de edad según tipo de prueba en el periodo. • Número de mujeres que consultan al primer nivel de atención en el periodo por grupo de edad.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino por grupo de edad según tipo de prueba en el periodo}}{\text{Número de mujeres que consultan al primer nivel de atención en el periodo por grupo de edad}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisible-Cáncer
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación del año 2024.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes, Cubo DCSS EPSS-Procedimiento, Cubo Citologías Salud, Cubo Atenciones Salud): • Mujeres de 20 a 64 años a las que se le realizó tamizaje de cáncer cérvico-uterino. • Mujeres de 20 a 64 años que consultan en el primer nivel de atención.	
Clasificación	Identificador de proceso.	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	• Cobertura bienal de tamizaje con citología cérvico-vaginal por PAP en mujeres de 20 a 29 años. • Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de cérvico-uterino en mujeres de 30 a 64 años.	
Indicador Complementario	Porcentaje de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino por grupo de edad según tipo de prueba (V-2.0)	
Definición conceptual	Porcentaje de la población de mujeres a las que se les realiza tamizaje de cáncer cérvico-uterino por tipo de prueba (PAP o VPH), según los grupos de edad definidos en los indicadores de evaluación. Incluye: • Código diagnóstico CIE 10: definido en los indicadores de evaluación códigos 14-01-2.0 y 14-02-2.0. • Nombre del procedimiento: definido en los indicadores de evaluación códigos 14-01-2.0 y 14-02-2.0. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Número de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino por grupo de edad según tipo de prueba en el periodo. • Número de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino realizada en el periodo por grupo de edad.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino por grupo de edad según tipo de prueba en el periodo}}{\text{Número de mujeres con tamizaje de cáncer cérvico-uterino realizada en el periodo por grupo de edad}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisible-Cáncer
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación del año 2024.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes, Cubo DCSS EPSS-Procedimiento, Cubo Citologías Salud): • Mujeres de 20 a 64 años a las que se le realizó citología cérvico-vaginal.	
Clasificación	Identificador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica.	

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN DE TAMIZAJE DE CÁNCER DE MAMA

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	El cáncer de mama es el más frecuente y les causa la muerte a 685 000 mujeres en el mundo según la Organización Mundial de la Salud en el 2020; en donde la mayoría de estas fueron registrados en países de ingresos bajos y medios (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Para América Latina y el Caribe, el panorama es similar con una incidencia es de 210 000 mujeres y aproximadamente 68 000 muertes, ambas registradas para el 2020; haciendo que este cáncer sea el primero de la lista (OMS, s.f.). En Costa Rica este cáncer se encontraba en el primer lugar de incidencia y mortalidad en mujeres en el 2014, siendo las cifras más actualizadas del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud [MINSA], 2015; MINSA, 2019 & MINSA, 2021).
Evidencia	El tener un diagnóstico temprano de cáncer de mama es fundamental para que sea tratado oportunamente y de forma apropiada, lo que podría disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer; por tanto, el tamizaje es de suma importancia y la mamografía "es la tecnología de imagen diagnóstica comprobadamente más eficaz" (Organización Mundial de la Salud, 2016). Además, la mamografía puede encontrar cambios en las mamas que potencialmente pueden llegar a ser cáncer, años antes de que existan síntomas en la paciente por lo que "las mujeres que se hacen mamogramas regularmente tienen más probabilidades de encontrar temprano el cáncer de seno, menos probabilidades de necesitar tratamiento agresivo, como cirugía para extirpar el seno (mastectomía) y quimioterapia, y más probabilidades de curarse" (American Cancer Society, 2019) La incorporación de esta intervención está acorde con la relevancia que ha venido tomando y las estrategias para su abordaje, se tomó como base el Decreto Nº38377-S, en el cual se instruye a realizar una mamografía de tamizaje a las mujeres de 45 a 70 años cada dos años, independientemente de sus factores de riesgo; y para las que se encuentren fuera de ese rango se debe tomar en cuenta los factores de riesgo y expectativa de vida para realizarle la mamografía de tamizaje (MINSA, 2014).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Utilización de bases manuales en los centros que no ingresan los datos en el sistema institucional. Falta de variable de área de salud de adscripción en listados extraídos del cubo de procedimientos. Estrategias: Solicitud de bases manuales a los centros que no ingresan los datos en el sistema institucional. Extracción del área de salud de adscripción del cubo de adscripción el primer día hábil posterior al cierre del periodo de evaluación
Normativa Técnica	Decreto N°43263-S: "Norma Nacional para la prevención y el manejo del cáncer de mama en Costa Rica" (noviembre, 2020)
Costo / Efectividad	En lo relativo a costo-efectividad los estudios relacionados varían en la edad que se debe hacer la mamografía, desde 40 a 75 años. Sin embargo, todos concuerdan que es una intervención costo-efectiva. Para un estudio realizado en Colombia la edad es de 50 a 69 años, teniendo un total de 742 años de vida salvados (Rúa, Avendaño, 2019). El tamizaje en mujeres de 50-69 años fue el más costo efectivo en relación con otros grupos etarios (40-49 y 70-75) (López, 2006). Dentro de un metaanálisis que incluye Brasil, Perú, México y Costa Rica, se observó que las maneras de aumentar la demanda dependen de cada país; sin embargo; "lo más provechoso en función del dinero invertido, sobre todo en el nivel poblacional, es una combinación de medidas de tamizaje […] y medidas terapéuticas" (Watkin *et al*, 2017). La OMS en las directrices sobre el tamizaje por mamografía sugiere que los programas relacionados a este tema sean organizados según los recursos disponibles y lo robusto del sistema de salud, indicando los grupos poblacionales y la frecuencia según su segregación. Sin embargo, refiere que "con recursos limitados y sistemas de salud deficientes, puede que los

	programas de tamizaje por mamografía de base poblacional no sean ni costo-efectivos ni factibles"
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar la cobertura de tamizaje de cáncer de mama realizadas por la CCSS a mujeres de 40 a 74 años; de forma institucional y distribuidos por área de salud de adscripción para su agrupación en RIPSS y área de salud, para contribuir a mejorar las estrategias de acceso y oportunidad.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la evolución de la cobertura institucional del tamizaje de cáncer de mama por medio de mamografía y su distribución por área de salud de adscripción según los resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS)?
Indicadores asociados a la intervención	09-03-1.0 Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de mama con mamografía en mujeres de 40 a 74 años.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	American Cancer Society. (3 de octubre de 2019). Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para la detección temprana del cáncer de seno. https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-seno/pruebas-de-deteccion-y-deteccion-temprana-del-cancer-de-seno/guias-de-la-sociedad-americana-contra-el-cancer-para-la-deteccion-temprana-del-cancer-de-seno.html López, J. (2006). *Análisis coste-efectividad del cribado del cáncer de mama mediante mamografía en diferentes grupos de edad (40-49, 50 a 69 y 70 a 75)*. Canarias: Servicio Canario de la Salud, Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Ministerio de Salud [MINSA]. (20 de mayo de 2014). Decreto N°38377-S. Norma para la atención a personas con cáncer de mama. San José, Costa Rica. Ministerio de Salud [MINSA]. (2015). *Boletín estadístico de mortalidad por tumores malignos más frecuentes en Costa Rica del año 2014.* MINSA. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas-y-bases-de-datos-vigilancia-de-la-salud/estadisticas-vigilancia-de-la-salud/estadistica-de-cancer-registro-nacional-tumores/boletines-de-mortalidad-de-cancer/1726-boletin-de-mortalidad-por-cancer-2014/file Ministerio de Salud [MINSA]. (2019). *Análisis de incidencia y mortalidad por cáncer.* MINSA. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas-y-bases-de-datos-vigilancia-de-la-salud/estadisticas-vigilancia-de-la-salud/estadistica-de-cancer-registro-nacional-tumores Ministerio de Salud [MINSA]. (2021). *427 mujeres fallecieron en el 2020 producto del cáncer de mama.* MINSA.https://www.ministeriodesalud.go.cr/ministeriodesaludbk/index.php/noticias/noticias-2017/1132-costa-rica-no-bajara-la-guardia-contra-el-zika Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2016). Garantía de la calidad de los servicios de mamografía: Normas básicas para América Latina y el Caribe. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12681:manual-mamografia&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). *Cáncer de mama*. OMS. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (s.f.). *Cáncer de mama*. OMS. https://www.paho.org/es/temas/cancer-mama Rúa, M y Avendaño, C. (2019). *Costo-Efectividad de la mamografía como prueba de tamizaje para la detección precoz el cáncer de mama*. Universidad de la Costa. http://hdl.handle.net/11323/3244 Watkin, D., Poggio, R., Augustovski, F., Brouwer, E., Pichon, R., Rubinstein, A; et al. (2017). *La costo-efectividad de las intervenciones y políticas para el control de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo en América Latina y el Caribe: revisión sistemática* (pp 109-112). Organización Panamericana de la Salud. https://iris.paho.org/handle/10665.2/33994

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 09-03-2.0

Elemento	Descripción	
Código	09-03-2.0	
Nombre	Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de mama con mamografía en mujeres de 40 a 74 años.	
Definición conceptual	Este indicador representa el porcentaje de mujeres de 40 a 74 años tamizadas con mamografía al menos una vez en los últimos dos años respecto a la población de mujeres de esa edad de la estimación de población por año elaborada por la Dirección Actuarial y Económica (DAE), utilizando para ello el dato del segundo año. Se aclara que los resultados de la evaluación del indicador se calculan para cada una de las RIPSS, por lo que la meta planteada es para este nivel, no por área de salud. Incluye: • La primer mamografía realizada a mujeres de 40 a 74 años en el periodo. • Nombre del procedimiento: mamografía, mamografía unilateral, mamografía por tomosentesis. Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Número de mujeres de 40 a 74 años con mamografía realizada en el periodo. • Número de mujeres de 40 a 74 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres de 40 a 74 años con mamografía realizada en el periodo}}{\text{Número de mujeres de 40 a 74 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer, Segundo y Tercer nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Cáncer
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Meta	Quinquenal: en construcción (para RIPSS)	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Procedimientos): • Mujeres de 40 a 74 años a las que se le realizó mamografía. • Listados manuales. Expediente Digital Único en Salud (Cubo Adscripción Salud): • Listado de mujeres con último centro de salud de adscripción Dirección Actuarial y Económica: • Mujeres de 40 a 74 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Indicador de proceso	

Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (Anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Cobertura bienal de mujeres de 40 a 74 años con mamografía por grupo de edad.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de mama con mamografía en mujeres de 40 a 74 años.	
Indicador Complementario	Cobertura bienal de mujeres de 40 a 74 años con mamografía por grupo de edad (V-2.0)	
Definición conceptual	Este indicador representa el porcentaje de mujeres de 40 a 74 años tamizadas con mamografía al menos una vez en los últimos dos años respecto a la población de mujeres de esa edad de la estimación de población por año elaborada por la Dirección Actuarial y Económica (DAE). Donde esta población se dividirá en tres grupos, de 40 a 49 años, de 50 a 69 años y de 70 a 74 años. Incluye: • La primer mamografía realizada a mujeres de 40 a 74 años en el periodo. • Nombre del procedimiento: mamografía, mamografía unilateral, mamografía por tomosentesis. Excluye: • No aplica.	
Variables involucradas en la medición	• Número de mujeres con mamografía realizada en el periodo por grupo de edad. • Número de mujeres por grupo de edad de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de mujeres con mamografía realizada en el periodo por grupo de edad}}{\text{Número de mujeres por grupo de edad de la estimación de población por año elaborada por la DAE en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer, Segundo y Tercer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisible-Cáncer
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación del año 2024.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Procedimientos): • Mujeres de 40 a 74 años a las que se le realizó mamografía. Expediente Digital Único en Salud (Cubo Adscripción Salud) • Listado de mujeres con último centro de salud de adscripción. Dirección Actuarial y Económica: • Mujeres de 40 a 74 años de la estimación de población por año elaborada por la DAE, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	
Clasificación	Identificador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica.	

11-EFICIENCIA PRODUCTIVA

INTERVENCIÓN – EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	El reto general que enfrenta la CCSS en el ámbito de la Prestación de los Servicios de Salud (PSS) es alcanzar una prestación adecuada, oportuna y eficaz que permita hacer frente a la mayor cantidad de necesidades de salud de la población, sujeta tanto a un conjunto limitado de recursos como a una creciente demanda por los servicios de salud. En ese contexto, es apremiante hacer un uso óptimo de los recursos, para lo cual se requieren estrategias apropiadas y susceptibles de ser evaluadas, con el fin de realimentar la gestión. Es importante resaltar que la Atención Primaria de Salud (APS) es la estrategia más aceptada por la mayoría de los sistemas de Salud desde su proclama en Alma Ata, 1978, hasta su reafirmación en Astana, 2018. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no es la excepción, ya que cuenta con una organización de la Prestación de Servicios de Salud en tres niveles, en donde destaca la creación de Áreas de Salud conformadas en el Primer Nivel de Atención (PNA) por Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y sus respectivos Equipos de Apoyo, a fin de implementar el enfoque centrado en las personas y atender las necesidades de salud. (WHO, 1978; WHO, 2019; CCSS, 2019b). Cabe destacar que el PNA es el pilar de la APS, ya que permite una adecuada accesibilidad de la población a los servicios, con una atención oportuna y eficaz, por eso, APS también ha sido reconocida internacionalmente como una excelente estrategia para lograr una mayor eficiencia en el Segundo y Tercer Nivel de Atención.
Evidencia	La Prestación de Servicios de Salud con base en un PNA robusto y efectivo, ofrece la posibilidad de alcanzar mejoras sustantivas en accesibilidad, calidad, oportunidad de los servicios, así como en la eficacia de la atención y la reducción de costos. Abundante literatura internacional sustenta lo anterior: • Los sistemas de salud orientados a la atención primaria están asociados con menores costos de atención, mayor satisfacción de la población con sus servicios de salud, mejores niveles de salud y un menor uso de medicación (Starfield, 1994, p.1131). • La APS es más asequible y tiene una repercusión mayor en la prevención, la promoción de la salud y la prestación de servicios donde las personas viven (OPS, 2019, párr.2). • Las actividades de prevención primaria y promoción de la salud ofrecen la posibilidad de prevenir hasta el 70% de la carga de morbilidad (OMS, 2008, p.8). • En el PNA se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes; además de permitir una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz (Vignolo et al., 2011, p.12).
Consideraciones de Implementación	Barreras: • Crecimiento de las necesidades de salud Ocasionado por: sociedad más informada que demanda con mayor frecuencia servicios curativos y preventivos; aumento en la esperanza de vida y de mayores de 60 años que requieren más servicios y de mayor costo; cambio del perfil epidemiológico con predominio de enfermedades crónicas que requieren tratamientos largos y costosos, y; aparición de resistencia a tratamientos usuales y de bajo costo. (MINSA, 2003, p. 5). • Problemas en la Prestación de Servicios de Salud Tales como: brechas de acceso, aceptabilidad, efectividad, eficiencia y continuidad de la atención de la población; atención episódica, centrada en la enfermedad y en hospitales, con énfasis en la atención de cuadros agudos o las complicaciones debidas a las condiciones crónicas (que no garantiza ni integralidad ni integración, ni ofrece suficientes acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y participación de la comunidad en actividades de la prestación y autocuidado); prestación orientada a la oferta de servicios, con poca alineación a las necesidades de la población; Heterogeneidad de los establecimientos en, organización, dotación de recursos (EBAIS, Equipos de Apoyo) y servicios prestados; y, carencia de lineamientos técnicos institucionales que delimiten el trabajo en Red. (CCSS, 2019b, pp. 16- 18). Estrategias: De acuerdo con CCSS (2019b, pp. 31- 50) destacan:

Elemento	Descripción
	• Énfasis en promoción y prevención; enfoque de atención centrado en las personas; adecuada estructura organizativa y funcional del conjunto de profesionales que ejecutan la APS así como la ejecución de trabajo multidisciplinario; y organización de servicios de salud basada en componentes, niveles de atención y operación en Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS). • Además, no deben dejarse de lado estrategias tales como: La vigilancia de la ejecución eficiente del gasto y estimular la eficiencia en la implementación de las acciones en APS.
Normativa Técnica	General: • CCSS (2020). Reglamento del Seguro de Salud • CCSS. (2021). Política Presupuestaria Por disciplinas: *Medicina* • CCSS. (2018c). Manual para la gestión de los servicios de Consulta Externa *Enfermería* • CCSS. (2023). Manual Gestión Enfermería Atención primaria *Farmacia* • CCSS. (2015). Política Institucional de Atención Farmacéutica • CCSS. (2017a). Instructivo Cuadro No. 31B Informe Estadístico Atención Farmacéutica *Nutrición* • CCSS. (2018a). Manual de Instrucciones de Trabajo. Nutrición, Áreas de Salud, CCSS • CCSS. (2017b). Organización Funcional de la disciplina de Nutrición en los tres niveles de atención *Trabajo social* • CCSS. (2019a). Manual de Gestión de Servicios de Trabajo Social *Psicología* • CCSS. (2014). Manual de procedimientos de la consulta externa en psicología de la CCSS. *Odontología* • CCSS. (2018b). Manual de Procedimiento. Plan local de desarrollo de los servicios de odontología de primer y segundo nivel de atención.
Costo / Efectividad	• De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) Las intervenciones esenciales de alto impacto para enfermedades no transmisibles (ENTS) pueden realizarse mediante un enfoque de atención primaria de salud fortaleciendo la detección oportuna y el tratamiento temprano. La evidencia muestra que tales intervenciones son excelentes inversiones económicas, ya que, si se proporciona atención temprana a los pacientes, se puede reducir la necesidad por tratamientos más costosos. (WHO, 2020, p.1). • Con la implementación de las Áreas de Salud, según Rosero- Bixby (2004), se redujo significativamente la mortalidad de los niños en 8% y la de los adultos en 2%. El efecto fue de 14% en la mortalidad de adultos debida a enfermedades transmisibles o desencadenadas por procesos infecciosos, nulo en la debida a causas sociales y similar al total (2%) en la mortalidad debida a enfermedades crónicas; además, la brecha en la equidad del acceso a los servicios de salud en el primer nivel de atención se redujo significativamente. El porcentaje de personas sin acceso equitativo a los servicios de salud del primer nivel de atención se redujo en 15% entre 1994 y 2000 en las áreas que adoptaron la reforma en 1995–1996, mientras que en las áreas que no habían adoptado la reforma en 2000, la reducción fue solo de 3%. • De acuerdo con VanderZanden (2021), la reforma de APS de Costa Rica ha mejorado la calidad de la atención médica y los resultados de salud al tiempo que gasta menos en atención médica que el promedio mundial (7,6% del PIB versus el promedio mundial del 10,0% en 2016) y por el gasto per cápita ($889) versus el promedio mundial de $1,026 en 2016). En cuanto a resultados, existe evidencia de mejoras en acceso y calidad, por ejemplo, las muertes por enfermedades transmisibles disminuyeron de 65 por 100.000 personas en 1990 a 4,2 por 100.000 en 2010, y la mortalidad materna e infantil ha disminuido desde 1995; en la primera década de implementación hubo una reducción del 8 por ciento en la mortalidad infantil y una reducción del 2 por ciento en la mortalidad adulta general. • Hodes & Kovacevic (2021) señalan, que entre las ventajas que se pueden atribuir a las redes de atención primaria, se encuentran: economías de escala, el desarrollo de costo- efectividad, los

Elemento	Descripción
	servicios comunitarios, compartir las mejores prácticas y los sistemas de tecnologías de información, así como una mejora en la calidad de la atención.
Objetivo (s) de la Evaluación	Retroalimentar desde una perspectiva económica el proceso de conducción de la Prestación de Servicios de Salud, tanto en el Nivel Institucional como en las Direcciones de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (DRIPSS) y en el Nivel Local; buscando inducir a las unidades prestadoras a alcanzar un rendimiento óptimo de los recursos, así como a identificar insuficiencias en recursos que interfieren con su rendimiento y/o con las metas de cobertura de atención de las necesidades de salud prioritarias de la población.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es el comportamiento en el tiempo de la eficiencia en las Áreas de Salud? ¿Cuál es la variabilidad de la eficiencia en las Áreas de Salud y cuáles variables la podrían explicar? ¿Cuál es la relación entre la productividad y disponibilidad de recursos en las Áreas de Salud?
Indicadores asociados a la intervención	Gasto • Comportamiento del Gasto en Sueldos para Cargos Fijos por Consulta • Comportamiento del Gasto en Tiempos Extraordinarios
Anexos	No hay
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2014). Manual de procedimientos de la consulta externa en psicología de la CCSS. Código MT.GM. DDSS.ARSDT-PSI.001 Versión 02. Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento. Coordinación Nacional de Psicología. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2015). Política Institucional de Atención Farmacéutica. Versión 02. Gerencia Médica, Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Regulación y Sistematización, Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017a). Instructivo Cuadro No. 31B Informe Estadístico Atención Farmacéutica. Gerencia Médica, Dirección de Proyección de Servicios de Salud, Área de Estadística en Salud; Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Regulación de Diagnóstico y Tratamiento, Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017b). Organización Funcional de la disciplina de Nutrición en los tres niveles de atención. Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento. Coordinación Nacional de Nutrición. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018a). Manual de Instrucciones de Trabajo. Nutrición, Áreas de Salud, CCSS. M.IT.GM.DDSS.ARSDT.N.181018. Versión 02. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento, Coordinación Nacional de Nutrición. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018b). Manual de Procedimiento. Plan local de desarrollo de los servicios de odontología de primer y segundo nivel de atención. Código MT. GM. DDSS. ARSDT-CNO-240418 Versión 01 Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018c). Manual para la gestión de los servicios de Consulta Externa. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2019a). Manual de Gestión de Servicios de Trabajo Social. Código M.GM. DDSS- ARSDT-TS.211119. Versión 01. Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2019b). Marco Conceptual y Estratégico para el Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud. Versión 3.1 Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2020). Reglamento Del Seguro De Salud. Junta Directiva. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro De Salud, Régimen De Invalidez, Vejez Y Muerte Y Régimen No Contributivos De Pensiones. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Manual Gestión Enfermería Atención primaria. Herrera, J.(2002). Objetivos de la atención farmacéutica. Recuperado de: Objetivos de la atención farmacéutica (elsevier.es) Hodes, S., Kovacevic, L. (2021). Primary care networks: Where are we? Where is the evidence base? What might the future bring? BMJ. 375: n2925, 2021 11 26 Lauzán, O. (2020). Costos en salud: un asunto polémico. Revista Cubana de Salud Pública. 2020;46(2):e2054. Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA]. (2003). Gasto y financiamiento de la salud en Costa Rica: Situación actual, tendencias y retos. Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2008) Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención primaria de salud Más necesaria que nunca.

Elemento	Descripción
	Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2019). La Atención Primaria De Salud Hacia La Salud Universal. Consejo Directivo. 71ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. CD57/INF/5. 19 de julio del 2019 Puig- Junoy, Jaume. Eficiencia en la atención primaria de salud: una revisión crítica de las medidas de frontera. Rev. Esp. Salud Pública 200& 74: 483-495. N.” 5-6- Septiembre-Diciembre 2000. Rosero-Bixby, L. (2004). Assessing the impact of health sector reform in Costa Rica through a quasi-experimental study. Revista Panamericana de Salud Pública 15(2):94-103 Schram, A. (2009). Análisis de costo-efectividad y costo-beneficio Programa de Detección Temprana de Cáncer Gástrico en Costa Rica. Población y Salud en Mesoamérica, vol. 6, núm. 2, enero-junio, 2009. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. E-ISSN: 1659-0201, revista@ccp.ucr.ac.cr Starfield, B. (1994). Is primary care essential? The Lancet, Volume 344, Issue 8930,1994, Pages 1129-1133, ISSN 0140-6736,https://doi.org/10.1016/S0140-6736(94)90634-3. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673694906343) VanderZanden, A., et al. (2021). What Does Community-Oriented Primary Health Care Look Like? Lessons from Costa Rica (Commonwealth Fund, Mar. 2021). https://doi.org/10.26099/ehbv-g283 Vignolo, V., Vacarezza, M., Álvarez, C. y Sosa, A. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Arch Med Interna 2011; XXXIII (1):11-14 World Health Organization [WHO]. (1978). Declaration of Alma- Ata. International Conference on Primary Health Care, Alma- Ata, USSR, 6- 12 September 1978 World Health Organization [WHO]. (2019). Declaration of Astana. Global Conference on Primary Health Care. From Alma-Ata towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. Astana, Kazakhstan, 25 and 26 October 2018 World Health Organization [WHO]. (2020). WHO Package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care. Geneva. ISBN 978-92-4-000922-6.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 11-01-1.0

Elemento	Descripción	
Código	11-01-1.0	
Nombre	Comportamiento del Gasto en Sueldos para Cargos Fijos por Consulta	
Definición conceptual	Es un indicador económico que analiza el comportamiento de la relación existente entre los recursos humanos y la producción de atenciones directas a la población. Este indicador mide la variación del gasto medio real[1] por atención, respecto al periodo anterior. La subpartida Gasto en Sueldos para Cargos Fijos [SPCF, código (2001)] determina el tamaño de las unidades y de su producción, por reflejar de manera directa la cantidad de recurso humano de que dispone una unidad. Asimismo, está correlacionada con el gasto total de las unidades, variable respecto a la que muestra un coeficiente de correlación superior a 0,95, indicando que ambas variables se distribuyen de manera similar entre las mismas. Por otra parte, al centrarse el indicador en la subpartida SPCF se aíslan gastos no relacionados con producción, como son los pluses salariales, gastos asociados a características o condiciones del equipo y/o la infraestructura, entre otros. El indicador incluye la producción de consultas de todos los profesionales de salud (médicos y no médicos) en el periodo evaluado, y se calcula en el Nivel Institucional, por Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) y por Área de salud. Incluye: • Áreas de Salud de gestión interna. • Gasto en colones de la subpartida SPCF (2001) Excluye: • Áreas de salud de gestión externa.	
Variables involucradas en la medición	• Gasto en Sueldos para Cargos Fijos • Consultas de los profesionales de salud (médicos y no médicos)	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Gasto en Sueldos para Cargos Fijos}_{\text{año}}}{\text{Consultas de los profesionales de salud}_{\text{año}}}$ $\frac{\text{Gasto en Sueldos para Cargos Fijos}_{\text{año anterior}}}{\text{Consultas de los profesionales de salud}_{\text{año anterior}}}$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa y urgencias
	Componente de la atención integral	Todos los componentes
	Temática	Eficiencia productiva
Línea base	Se define con los resultados de la Evaluación del año 2024	
Meta	Menor o igual a uno	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	• Sistema Integrado de Información Presupuestaria (SIIP) de la Dirección de Presupuesto de la CCSS (DP): Gasto en la subpartida 2001 • EDUS (Cubos de Consulta Externa y de Urgencias): cantidad de atenciones por profesional	
Clasificación	• Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	

	• Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)
Comentarios generales	• Con la implementación del salario global la clasificación en las subpartidas de gasto podría cambiar, en cuyo caso, la definición conceptual del indicador deberá ser adaptada. No se prevén afectaciones significativas, y la única afectación prevista se daría, si el ritmo de cambio de una metodología a otra difiriera entre las unidades. • La producción de consultas incluye los siguientes grupos profesionales: Odontología, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, Farmacia, Optometría, Medicina General, Terapia física, Medicina Especializada, Odontología Especializada, Profesionales en Enfermería, Audiología, Terapia Respiratoria, Terapia de Lenguaje, Terapia Ocupacional. Incluye profesionales residentes, de servicio social y cualquier otro grupo profesional que reporte producción en el Cubo respectivo. [1] Corresponde al Gasto medio deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 11-02-2.0

Elemento	Descripción	
Código	11-02-2.0	
Nombre	Comportamiento del Gasto en Tiempos Extraordinarios	
Definición conceptual	Es un indicador económico que mide el cambio interanual en la relación existente entre el gasto real[1] en el pago de tiempos extraordinarios y la producción de atenciones directas a la población en horarios vespertinos o nocturnos. El indicador cuantifica la producción de consultas de todos los profesionales de salud (médicos y no médicos), en horario de 4:00 pm a 6:00am del día siguiente, en el periodo evaluado a Nivel Institucional, de RIPSS y por Área de Salud. Los resultados se analizan a partir de las tasas de crecimiento del gasto promedio en el Nivel Institucional, por Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) y por Área de Salud. Incluye: • Áreas de Salud de gestión interna • Gasto en las subpartidas de Tiempos Extraordinarios Excluye: • Áreas de Salud de gestión externa Áreas de Salud de gestión interna que en el período evaluado no registraron Gasto en Tiempos Extraordinarios o producción en horario de 4:00 p.m. a 6:00 a.m.	
Variables involucradas en la medición	• Gasto en Subpartidas de Tiempos Extraordinarios • Consultas producidas en Tiempos Extraordinarios	
Fórmula de cálculo	$\frac{\frac{\text{Gasto en Subpartidas de Tiempos Extraordinarios}_{\text{año}}}{\text{Consultas producidas en Tiempos Extraordinarios}_{\text{año}}}}{\frac{\text{Gasto en Subpartidas de Tiempos Extraordinarios}_{\text{año anterior}}}{\text{Consultas producidas en Tiempos Extraordinarios}_{\text{año anterior}}}}$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer y Segundo Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa Urgencias/ Emergencias
	Componente de la atención integral	Todos los componentes
	Temática	Eficiencia productiva
Línea base	Se define con el resultado de la evaluación 2024	
Meta	Menor o igual que uno	

[1] Gasto deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Periodicidad	Anual
Fuente de información	• Sistema Integrado de Información Presupuestaria (SIIP) de la Dirección de Presupuesto (SEIP Egresos): Gasto en subpartidas de tiempos extraordinarios • Módulo de Presupuesto del Sistema ERP (Se prevé que estará funcionando a cabalidad a partir del mes de julio 2025) • EDUS (Cubo de Consulta Externa): Atenciones realizadas entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente en el área de salud en el período
Clasificación	• Proceso
Presentación de resultados	• Monitoreos trimestrales (marzo, junio y septiembre) • Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual) • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)
Comentarios generales	• Las Subpartidas de Tiempos Extraordinarios según la Política Presupuestaria: Tiempo Extraordinario (2021), Recargos nocturnos (2022), Guardas Médicas (2023), Disponibilidad Médica (2024), Guardias Médicas (2026), Residentes, Extras Corrientes Médicas (2027). • Se entenderá por unidades que no registran producción aquellas cuyos registros no superan las dos mil atenciones en el año, lo que equivale a un promedio diario de alrededor de 8 atenciones. • Un promedio diario de atenciones igual o inferior a 8 podría responder a consultas dadas minutos antes de las 7am o posterior a las 4pm y no a un servicio vespertino o nocturno establecido y, por tanto, no financiado con tiempos extraordinarios.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Gasto en Sueldos Fijos por consulta	
Indicador Complementario	Gasto Per Cápita en Áreas de Salud, según complejidad (V-1.0)	
Definición conceptual	Es un indicador económico que mide la relación existente entre los recursos utilizados en la Prestación de Servicios de Salud ofrecida por la CCSS y la población adscrita durante un período determinado. Permite observar las diferencias en los recursos asignados a las unidades prestadoras de servicios de salud y facilita la generación de análisis acerca de las causas e implicaciones para la Prestación de Servicios de Salud. • Incluye: ○ Áreas de Salud ○ Gasto de efectivo y no efectivo • Excluye: No aplica Las Áreas de Salud se agruparán según el Perfil de Complejidad establecido por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud (DPSS), a fin de obtener una mejor comparación entre unidades prestadoras. También se realizarán cálculos agrupados para obtener el per-cápita de toda la RIPSS y la unidad.	
Variables involucradas en la medición	• Gasto total en un período • Población en un período	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Gasto total en el Período (t)}}{\text{Población en el Período (t)}}$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer, segundo y tercer nivel
	Componente de la prestación	Incluye todos los componentes de la prestación
	Componente de la atención integral	Todos
	Temática	Gestión y Eficiencia
Línea base	Se define con los resultados de la Evaluación del año 2024.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Sistema Integrado de Información Presupuestaria (SIIP) de la Dirección de Presupuesto de la CCSS (DP): Gasto total Dirección Actuarial Económica: Proyecciones de Población oficiales emitidas por la Dirección Actuarial Económica: Proyecciones de Población oficiales.	
Clasificación	Proceso	
Presentación de resultados	Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual) Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)	
Comentarios generales	Este indicador será un insumo para el análisis del indicador de Gasto en Sueldos Fijos por consulta. El propósito del análisis de la dispersión de los gastos per- cápita para las Áreas de Salud es contar con una primera aproximación a la eficiencia asignativa, aquella que corresponde a la capacidad de utilizar los recursos de acuerdo con las proporciones óptimas, así como contar con información acerca de la equidad de la asignación institucional. Se prevé una evolución en el análisis de este indicador, que permita determinar la correlación entre la asignación de recursos y aspectos tales como el modelo de prestación vigente, estrategias institucionales y las necesidades de salud de la población; así como la valoración de las reglas de asignación de recursos.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Comportamiento del gasto en sueldos para cargos fijos por consulta	
Indicador Complementario	Porcentaje de las horas médicas contratadas requerido para la cobertura de la población con DM2 y HTA. V.2.0	
Definición conceptual	Es un indicador que estima el tiempo médico requerido para la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, según las metas de cobertura establecidas y de conformidad con las normas técnicas de la CCSS. Permite observar el porcentaje del tiempo que teóricamente se requiere para la atención de las personas con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo 2, así como el tiempo que queda disponible para la atención de los otros programas de atención integral y de la morbilidad, en el primer nivel de atención, de acuerdo con la normativa y las metas de cobertura. Las atenciones requeridas se calculan con base en las poblaciones blanco-definidas en las metas de cobertura de personas con DM2 y personas con HTA. Dichas metas se calculan multiplicando la cantidad de población de 20 años y más por las respectivas prevalencias y por los porcentajes de cobertura establecidos como meta. La cantidad de personas a cubrir en cada uno de los programas se multiplica a su vez por las concentraciones establecidas según la norma, para cada grupo de población Incluye: • Consultas de primera vez y subsecuentes en medicina general de personas con Hipertensión Arterial (HTA) o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Horas médicas requeridas para atender a la población objetivo en el período (t)* • Horas médicas contratadas para atención integral en el período (t)* (*) Ver detalle del cálculo en la sección Comentarios Generales	
Fórmula de cálculo	$\frac{\textit{Horas médicas requeridas para atender a la población objetivo en el período (t)}}{\textit{Horas médicas contratadas para atención integral en el período (t)}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primero y Segundo Nivel de Atención
	Componente de la prestación	Incluye todos los componentes de la prestación

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Componente de la atención integral</td><td>Todos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Enfermedades Crónicas No Transmisibles</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Se define con los resultados de la Evaluación del año 2024.</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">CECOIN:

Cantidad de EBAIS (para calcular horas médicas contratadas/disponibles para atención integral en el período (t))
DCSS (EPSS):

Metas de cobertura
Protocolos de atención de DM2 y HTA:

Concentración

Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular:

Prevalencias HTA y DM2 determinadas en la última encuesta</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Estructura</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)

Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">Fórmulas de cálculo de las horas requeridas y de las horas contratadas

Horas médicas requeridas:

Horas médicas requeridas para atender a la Población con DM2 + Horas médicas requeridas para atender a la Población con HTA - Horas médicas requeridas para atender a la Población con DM2 y HTA

Horas médicas requeridas para atender a la Población con HTA

[POB-HTA * Meta HTA * CONC-HTA] / REND

Dónde:

POB-HTA: Población con Hipertensión Arterial:

Prevalencia HTA * Población de 20 años y más

Meta HTA: Meta de cobertura de HTA: 34,6 %

CONC-HTA: 4 atenciones al año

REND: Rendimiento: 4 atenciones por hora

Horas médicas requeridas para atender a la Población con DM2 y HTA

[POB-DM2&HTA * CONC-DM2&HTA] / REND</td></tr>
</table>

Elemento	Descripción
	Dónde: **POB-DM2&HTA**: Personas con DM2 y HTA (comorbilidad) **CONC-DM2&HTA**: Concentración: 4 atenciones al año **REND**: Rendimiento: 4 atenciones por hora **Horas médicas contratadas para atención integral:** Horas médicas contratadas al año para atención en los EBAIS * Porcentaje del tiempo destinado a consulta **Horas médicas contratadas al año para atención en los EBAIS** **EBAIS * HRAS-EFEC-ANIO** Dónde: **EBAIS**: Número de EBAIS (1) **HRAS-EFEC-ANIO**: Horas efectivas contratadas al año: [52 SEMANAS * 5 DÍAS LABORABLES - DÍAS FERIADOS] * 7,8 (HORAS LABORABLES) (2) **Porcentaje del tiempo destinado a consulta** Según el oficio DRSS-GR-0812-2023/ GM-13108-2023 del 08 de setiembre de 2023, es el 90% (1) Cada EBAIS está conformado por un médico, según la norma. (2) Horas que conforman la jornada laboral diaria menos el tiempo de alimentación. La jornada ordinaria en los EBAIS es de 44 horas semanales a las que se deben restar cinco horas por tiempo de alimentación, para un promedio de 7,8 horas diarias de trabajo efectivo.

V. ANEXO: INTERVENCIONES E INDICADORES DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.

10-SÍNDROME CORONARIO AGUDO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST-ELEVADO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	• Las enfermedades cardiovasculares (ECV), principalmente la cardiopatía isquémica, son las principales causas de mortalidad y discapacidad en los países de las Américas. Panamerican Health Organization PAHO. World Health Organization Regional Office in Americas/Panamerican Health Organization. Cardiovascular disease burden in the Region of the Americas, 2000-2019 • Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en Costa Rica los fallecimientos por infarto agudo de miocardio aumentaron en un 11% durante el año 2022, contabilizando un total de 2.144 casos ese año y 1.928 en el 2021. Del total de fallecimientos durante el 2022, 869 corresponden a mujeres (40%) y 1.275 a hombres. (60%). Asimismo, el grupo etario más afectado son las personas mayores de 75 años, las cuales registran 1.178 defunciones del total reportado en el 2022. Ministerio de Salud. Gobierno de Costa Rica. Fallecimientos por Infarto aumentaron en un 11% durante el año 2022. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1682-fallecimientos-por-infarto-agudo-de-miocardio- • En términos de legislación, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica no se encontró información relevante asociada a esta intervención en una búsqueda realizada en las fechas 1 y 14 de noviembre de 2023 con los términos: atención/infarto miocardio/terapia/ trombolítica. • El Plan Estratégico Institucional de la CCSS, en la línea estratégica 1-A se orienta hacia el reforzamiento de la atención integral de la salud mental, enfermedades crónicas y cardiovasculares y cáncer, asegurando el tratamiento de forma oportuna, con calidad y accesible a la población a fin de generar una disminución en la carga de la enfermedad. CCSS, Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2033. Dirección de Planificación Institucional.
Evidencia	• Cuando la terapia fibrinolítica está indicada o es elegida como estrategia de reperfusión primaria, debe administrarse dentro de los 30 minutos posteriores a la llegada al hospital. Evidencia: Clase I, Nivel B Referencia: 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. • La terapia de reperfusión debe administrarse a todos los pacientes elegibles con IAMCEST, dentro de las 12 horas posteriores al inicio de los síntomas. Evidencia: Clase I Nivel A. Referencia: 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines • Si no se puede realizar una PCI primaria oportuna después del diagnóstico de STEMI, la terapia fibrinolítica está recomendada dentro de las 12 horas posteriores al inicio de los síntomas en pacientes sin contraindicaciones. Evidencia: Clase I Nivel A. Referencia: 2017 ESC Guidelines for themanagement of acutemyocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force for the management of acute myocardial infarctionin patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)
Consideraciones de Implementación	Barreras: disponibilidad del agente trombolítico en el centro con capacidad de administrar la trombólisis. Estrategias: NA
Normativa Técnica	No se identificó normativa técnica institucional vigente que sea aplicable para los efectos de la evaluación, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 20 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes categorías: normas//políticas//leyes//manual// en el catálogo de publicaciones institucional de la CCSS (https://www.ccss.sa.cr/normativa) y a través del enlace "protocolos, normas y lineamientos" de la Biblioteca Nacional de Salud BINASSS (https://www.binasss.sa.cr/protocolos/protocolos.htm).

Costo / Efectividad	No se identificaron estudios de costo/efectividad relacionados con la aplicación oportuna de la terapia trombolítica en pacientes con IAMCEST que puedan ser aplicables a la realidad del país, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 21 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes descriptores en ciencias de la salud (MESH) de la biblioteca nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM): "Cost-Effectiveness Analysis"[Mesh]) AND "Myocardial Reperfusion "[Mesh] (("Análisis de Costo-Efectividad"[Mesh]) Y "Reperfusión Miocárdica"[Mesh]) en las bases de datos biomédicos de la National Library of Medicine NLM, Pub Med, Medscape, BMJ Best Practice, Scielo, Cochrane Library, Clinical Key, Medline, Ovid, Jaypee digital, New England of Medicine. A nivel local no se identificaron investigaciones sobre el tema, en el Hub virtual de economía de la salud "Imputs para mejorar el sistema de salud costarricense" https://www.binasss.sa.cr/economia/experto1.php#MATERIAL
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar la oportunidad de la aplicación de la terapia trombolítica a través de la medida del tiempo puerta-aguja
Pregunta (s) de Evaluación	¿El tiempo puerta-aguja es de 30 minutos o menos?
Indicadores asociados a la intervención	Proporción de atenciones con tiempo puerta-aguja menor o igual a 30 minutos.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Además de las que siguen, también deben considerarse como referencias la Lista Oficial de Medicamentos y cualquier otra normativa emitida por la Dirección de Farmacoepidemiología que aplique. Authors/Task Force Members: Robert A. Byrne *†,(Chairperson) (Ireland), Xavier Rossello ‡(Task Force Co-ordinator) (Spain), J.J. Coughlan ‡ ,(Task Force Co-ordinator) (Ireland), Emanuele Barbato (Italy), Colin Berry (United Kingdom), Alaide Chieffo (Italy), Marc J. Claeys (Belgium), Gheorghe-Andrei Dan (Romania), Marc R. Dweck (United Kingdom), Mary Galbraith (United Kingdom), Martine Gilard (France),Lynne Hinterbuchner (Austria), Ewa A. Jankowska (Poland), Peter Jüni (United Kingdom), Takeshi Kimura (Japan), Vijay Kunadian (United Kingdom), Margret Leosdottir (Sweden), Roberto Lorusso (Netherlands), Roberto F.E. Pedretti (Italy), Angelos G. Rigopoulos (Greece), Maria Rubini Gimenez (Germany), Holger Thiele (Germany), Pascal Vranckx (Belgium), Sven Wassmann (Germany), Nanette Kass Wenger (United States of America), Borja Ibanez *† (Chairperson) (Spain), and ESCScientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary síndromes. Developed by the task force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)(2023) European Heart Journal and European Heart Journal- Acute Cardiovascular Care Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, Bhatt DL, Birtcher KK, Blankstein R,Boyd J, Bullock-Palmer RP, Conejo T, Diercks DB, Gentile F, Greenwood JP, Hess EP, Hollenberg SM, Jaber WA, Jneid H, Joglar JA, Morrow DA, O'Connor RE, Ross MA, Shaw LJ. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR guideline for the evaluation and diagnosis of chest pain: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;144: e368–e454. doi: 10.1161/CIR.0000000000001029 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction.. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Aug 23. pii: S0735-1097(18)36941-9. doi: 10.1161/CIR.0000000000000617. Jneid H, Addison D, Bhatt DL, Fonarow GC, Gokak S, Grady KL, Green LA, Heidenreich PA, Ho PM, Jurgens CY, King ML, Kumbhani DJ, Pancholy S. 2017 AHA/ACC Clinical Performance and Quality Measures for Adults With ST-Elevation and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction: A Report of the American College of

Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures. J Am Coll Cardiol. 2017 Oct 17;70(16):2048-2090. doi: 10.1016/j.jacc.2017.06.032.

Schiele F, Gale CP, Bonnefoy E, Capuano F, Claeys MJ, Danchin N, Fox KA, Huber K, Iakobishvili Z, Lettino M, Quinn T, Rubini Gimenez M, Bøtker HE, Swahn E, Timmis A, Tubaro M, Vrints C, Walker D, Zahger D, Zeymer U, Bueno H. Quality indicators for acute myocardial infarction: A position paper of the Acute Cardiovascular Care Association. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 Feb;6(1):34-59. doi: 10.1177/2048872616643053.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 10-01-1.0

Elemento	Descripción	
Código	10-01-1.0	
Nombre	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-aguja de 30 minutos o menos.	
Definición conceptual	Población blanco: casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias, con terapia trombolítica i. v. como procedimiento de reperfusión primaria. Criterios de inclusión: • Clínicamente sugestivo de isquemia cardiaca al llegar. • Infarto agudo de miocardio ST-elevado o equivalente en el primer electrocardiograma realizado en el centro del procedimiento. • Infarto agudo de miocardio tipo 1. Criterios de exclusión: • Lapso de 12 horas o más desde el inicio/exacerbación de los síntomas hasta el momento más temprano de la atención en el centro del procedimiento. • Paro cardiaco antes del inicio de la terapia trombolítica i. v. • Contraindicación absoluta para el procedimiento. Criterios de excepción: • Demora por atención impostergable de alguna condición del paciente (p. ej., choque cardiogénico), antes del procedimiento. • Demora por sospecha/atención de alguna contraindicación, antes del procedimiento. • Demora para obtener el consentimiento informado que es atribuible al paciente o a sus familiares.	
Variables involucradas en la medición	Puerta: momento (en hh:mm) más temprano de la atención en el centro del procedimiento, registrado en EDUS. Aguja: momento (en hh:mm) del inicio de la aplicación de la terapia trombolítica i. v., registrado en EDUS por el personal de enfermería.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Casos en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-aguja ≤30 minutos}}{\text{Casos en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con terapia trombolítica i. v.}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Urgencias/Emergencias.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	68%	
Meta	100% Periodicidad: anual. Unidad de medida: proporción.	
Periodicidad	Otra: bienal.	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de las fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.	

Clasificación	Proceso.
Presentación de resultados	• Informe analítico PBI 115-Evaluación Infarto (IAM). • Informe de la evaluación.
Comentarios generales	Indicadores complementarios: • Proporción de atenciones con aguja. • Proporción de atenciones con tiempo puerta-aguja medible.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-aguja de 30 minutos o menos.	
Indicador Complementario	Proporción de atenciones con aguja (V-1.0)	
Definición conceptual	Población blanco: Casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias, con terapia trombolítica i. v. como procedimiento de reperfusión primaria. Los criterios de inclusión, exclusión y excepción que le aplican al indicador de evaluación.	
Variables involucradas en la medición	**Aguja:** momento (en hh:mm) del inicio de la aplicación de la terapia trombolítica i. v., registrado en EDUS por el personal de enfermería.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Atenciones en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con terapia trombolítica i. v. con aguja}}{\text{Atenciones en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con terapia trombolítica i. v.}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Urgencias/Emergencias.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	80%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de las fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.	
Clasificación	Indicador de Proceso.	
Presentación de resultados	- Informe de la evaluación.	
Comentarios generales	Ninguno	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-aguja de 30 minutos o menos.	
Indicador Complementario	Proporción de atenciones con tiempo puerta-aguja medible (V-1.0)	
Definición conceptual	Población blanco: Casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias, con terapia trombolítica i. v. como procedimiento de reperfusión primaria. Los criterios de inclusión, exclusión y excepción que le aplican al indicador de evaluación.	
Variables involucradas en la medición	Puerta: momento (en hh:mm) más temprano de la atención en el centro del procedimiento, registrado en EDUS. Aguja: momento (en hh:mm) del inicio de la aplicación de la terapia trombolítica i. v., registrado en EDUS por el personal de enfermería.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Atenciones en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con terapia trombolítica i. v. con tiempo puerta aguja medible}}{\text{Atenciones en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con terapia trombolítica i. v.}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Urgencias/Emergencias.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	80%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. Fuentes secundarias: • Reporte del infarto. Unidades encargadas de las fuentes primarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.	
Clasificación	Indicador de Proceso.	
Presentación de resultados	- Informe analítico PBI 115-Evaluación Infarto (IAM). - Informe de la evaluación.	
Comentarios generales	Ninguno	

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST-ELEVADO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	• Las enfermedades cardiovasculares (ECV), principalmente la cardiopatía isquémica, son las principales causas de mortalidad y discapacidad en los países de las Américas. Panamerican Health Organization PAHO. World Health Organization Regional Office in Americas/Panamerican Health Organization. Cardiovascular disease burden in the Region of the Americas, 2000-2019 • Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en Costa Rica los fallecimientos por infarto agudo de miocardio aumentaron en un 11% durante el año 2022, contabilizando un total de 2.144 casos ese año y 1.928 en el 2021. Del total de fallecimientos durante el 2022, 869 corresponden a mujeres (40%) y 1.275 a hombres. (60%). Asimismo, el grupo etario más afectado son las personas mayores de 75 años, las cuales registran 1.178 defunciones del total reportado en el 2022. Ministerio de Salud. Gobierno de Costa Rica. Fallecimientos por Infarto aumentaron en un 11% durante el año 2022. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1682-fallecimientos-por-infarto-agudo-de-miocardio- • En términos de legislación, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica no se encontró información relevante asociada a esta intervención en una búsqueda realizada en las fechas 2 y 3 de noviembre de 2023 con los términos: atención/infarto miocardio/intervención coronaria percutánea • El Plan Estratégico Institucional de la CCSS, en la línea estratégica 1-A se orienta hacia el reforzamiento de la atención integral de la salud mental, enfermedades crónicas y cardiovasculares y cáncer, asegurando el tratamiento de forma oportuna, con calidad y accesible a la población a fin de generar una disminución en la carga de la enfermedad. CCSS, Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2033. Dirección de Planificación Institucional.
Evidencia	• La Intervención Coronaria Percutánea (ICP) primaria es la estrategia de clasificación recomendada para pacientes con IAMCEST, con un primer contacto con el sistema, y debe aplicarse en un tiempo de 90 minutos o menos. Evidencia: Clase I, Nivel B. Referencia: 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines • La ICP primaria es el método recomendado de reperfusión. cuando pueda realizarse oportunamente por operadores experimentados. Evidencia: Clase I Nivel A. Referencia: 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines • Se recomienda una estrategia de ICP primaria por sobre fibrinólisis dentro de los plazos indicados. Evidencia: Clase I Nivel A. Referencia: 2017 ESC Guidelines for themanagement of acutemyocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force for the management of acute myocardial infarctionin patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)
Consideraciones de Implementación	Barreras: disponibilidad limitada de centros con laboratorio de hemodinamia y capacidad para la realización del procedimiento. Estrategias: NA
Normativa Técnica	No se identificó normativa técnica institucional vigente que sea aplicable para la implementación de esta intervención, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 14 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes categorías: normas//políticas//leyes//manual// en el catálogo de publicaciones institucional de la CCSS (https://www.ccss.sa.cr/normativa) y a través del enlace "protocolos, normas y lineamientos" de la Biblioteca Nacional de Salud BINASSS (https://www.binasss.sa.cr/protocolos/protocolos.htm).
Costo / Efectividad	No se identificaron estudios de costo/efectividad relacionados con la realización de angioplastia primaria en pacientes con IAMCEST que puedan ser aplicables a la realidad del país, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 21 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes descriptores en ciencias de la salud (MESH) de la biblioteca nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM): "Cost-Effectiveness Analysis"[Mesh]) AND "Myocardial Reperfusion "[Mesh] (("Análisis de Costo-Efectividad"[Mesh]) Y "Reperfusión Miocárdica"[Mesh]) en las bases

	de datos biomédicos de la National Library of Medicine NLM, Pub Med, Medscape, BMJ Best Practice, Scielo, Cochrane Library, Clinical Key, Medline, Ovid, Jaypee digital, New England of Medicine. A nivel local no se identificaron investigaciones sobre el tema, en el Hub virtual de economía de la salud "Imputs para mejorar el sistema de salud costarricense" https://www.binasss.sa.cr/economia/experto1.php#MATERIAL
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar la oportunidad de la realización de Intervención Coronaria Percutánea (ICP) a través de la medida del tiempo puerta-balón (TPB).
Pregunta (s) de Evaluación	¿El tiempo puerta-balón es de 90 minutos o menos?
Indicadores asociados a la intervención	• Proporción de atenciones con tiempo puerta-balón menor o igual a 90 minutos.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Además de las que siguen, también deben considerarse como referencias la Lista Oficial de Medicamentos y cualquier otra normativa emitida por la Dirección de Farmacoepidemiología que aplique. Authors/Task Force Members: Robert A. Byrne *†,(Chairperson) (Ireland), Xavier Rossello ‡(Task Force Co-ordinator) (Spain), J.J. Coughlan ‡ ,(Task Force Co-ordinator) (Ireland), Emanuele Barbato (Italy), Colin Berry (United Kingdom), Alaide Chieffo (Italy), Marc J. Claeys (Belgium), Gheorghe-Andrei Dan (Romania), Marc R. Dweck (United Kingdom), Mary Galbraith (United Kingdom), Martine Gilard (France),Lynne Hinterbuchner (Austria), Ewa A. Jankowska (Poland), Peter Jüni (United Kingdom), Takeshi Kimura (Japan), Vijay Kunadian (United Kingdom), Margret Leosdottir (Sweden), Roberto Lorusso (Netherlands), Roberto F.E. Pedretti (Italy), Angelos G. Rigopoulos (Greece), Maria Rubini Gimenez (Germany), Holger Thiele (Germany), Pascal Vranckx (Belgium), Sven Wassmann (Germany), Nanette Kass Wenger (United States of America), Borja Ibanez *† (Chairperson) (Spain), and ESCScientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary síndromes. Developed by the task force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)(2023) European Heart Journal and European Heart Journal- Acute Cardiovascular Care Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, Bhatt DL, Birtcher KK, Blankstein R,Boyd J, Bullock-Palmer RP, Conejo T, Diercks DB, Gentile F, Greenwood JP, Hess EP, Hollenberg SM, Jaber WA, Jneid H, Joglar JA, Morrow DA, O'Connor RE, Ross MA, Shaw LJ. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR guideline for the evaluation and diagnosis of chest pain: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;144: e368–e454. doi: 10.1161/CIR.0000000000001029 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction.. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Aug 23. pii: S0735-1097(18)36941-9. doi: 10.1161/CIR.0000000000000617. Jneid H, Addison D, Bhatt DL, Fonarow GC, Gokak S, Grady KL, Green LA, Heidenreich PA, Ho PM, Jurgens CY, King ML, Kumbhani DJ, Pancholy S. 2017 AHA/ACC Clinical Performance and Quality Measures for Adults With ST-Elevation and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures. J Am Coll Cardiol. 2017 Oct 17;70(16):2048-2090. doi: 10.1016/j.jacc.2017.06.032. Schiele F, Gale CP, Bonnefoy E, Capuano F, Claeys MJ, Danchin N, Fox KA, Huber K, Iakobishvili Z, Lettino M, Quinn T, Rubini Gimenez M, Bøtker HE, Swahn E, Timmis A, Tubaro M, Vrints C, Walker D, Zahger D, Zeymer U, Bueno H. Quality indicators for acute myocardial infarction: A position paper of the Acute Cardiovascular Care Association. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 Feb;6(1):34-59. doi: 10.1177/2048872616643053.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 10-02-1.0

Elemento	Descripción	
Código	10-02-1.0	
Nombre	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-balón de 90 minutos o menos.	
Definición conceptual	Población blanco: casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias, con intervención coronaria percutánea como procedimiento de reperfusión primaria. Criterios de inclusión: • Clínicamente sugestivo de isquemia cardiaca al llegar. • Infarto agudo de miocardio ST-elevado o equivalente en el primer electrocardiograma realizado en el centro del procedimiento. • Infarto agudo de miocardio tipo 1. Criterios de exclusión: • Lapso de 12 horas o más desde el inicio/exacerbación de los síntomas hasta el momento más temprano de la atención en el centro del procedimiento. • Paro cardiaco antes del inicio de la intervención coronaria percutánea. • Contraindicación absoluta para el procedimiento. Criterios de excepción: • Demora por atención impostergable de alguna condición del paciente (p. ej., choque cardiogénico), antes del procedimiento. • Demora por sospecha/atención de alguna contraindicación, antes del procedimiento. • Demora para obtener el consentimiento informado que es atribuible al paciente o a sus familiares. • Demora por dificultades procedimentales (p. ej., acceso vascular).	
Variables involucradas en la medición	Puerta: momento (en hh:mm) más temprano de la atención en el centro del procedimiento, registrado en EDUS. Balón: momento (en hh:mm) de la activación del *dispositivo*, registrado en EDUS, Elektra u otro.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Casos en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-balón ≤90 minutos}}{\text{Casos en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado, con intervención coronaria percutánea}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	III.
	Componente de la prestación	Urgencias/Emergencias. Laboratorio de hemodinamia.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	Nd/i	
Meta	100% Periodicidad: anual. Unidad de medida: proporción.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. • Elektra. • Otra (cuando aplique). Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de la fuentes secundarias:	

	• Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.
Clasificación	Proceso.
Presentación de resultados	• Informe analítico PBI 115-Evaluación Infarto (IAM). • Informe de la evaluación.
Comentarios generales	Indicadores complementarios: • Proporción de atenciones con balón.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo puerta-balón de 90 minutos o menos.	
Indicador Complementario	Proporción de atenciones con balón. (V-1.0)	
Definición conceptual	Población blanco: Casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias, con intervención coronaria percutánea (ICP) como procedimiento de reperfusión. Los criterios de inclusión, exclusión y excepción que le aplican al indicador de evaluación.	
Variables involucradas en la medición	Balón: momento (en hh:mm) de la activación del *dispositivo*, registrado en EDUS, Elektra u otro.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Atenciones en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea, con balón}}{\text{Atenciones en Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Urgencias/Emergencias. Laboratorio de hemodinamia.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	Nd/i	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. • Elektra. • Otra (cuando aplique). Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de la fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	- Informe de Evaluación	
Comentarios generales	Ninguno	

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST-ELEVADO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	• Las enfermedades cardiovasculares (ECV), principalmente la cardiopatía isquémica, son las principales causas de mortalidad y discapacidad en los países de las Américas. Panamerican Health Organization PAHO. World Health Organization Regional Office in Americas/Panamerican Health Organization. Cardiovascular disease burden in the Region of the Americas, 2000-2019 • Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en Costa Rica los fallecimientos por infarto agudo de miocardio aumentaron en un 11% durante el año 2022, contabilizando un total de 2.144 casos ese año y 1.928 en el 2021. Del total de fallecimientos durante el 2022, 869 corresponden a mujeres (40%) y 1.275 a hombres. (60%). Asimismo, el grupo etario más afectado son las personas mayores de 75 años, las cuales registran 1.178 defunciones del total reportado en el 2022. Ministerio de Salud. Gobierno de Costa Rica. Fallecimientos por Infarto aumentaron en un 11% durante el año 2022. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1682-fallecimientos-por-infarto-agudo-de-miocardio- • En términos de legislación, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica no se encontró información relevante asociada a esta intervención en una búsqueda realizada en las fechas 2 y 3 de noviembre de 2023 con los términos: atención/infarto miocardio/intervención coronaria percutánea • El Plan Estratégico Institucional de la CCSS, en la línea estratégica 1-A se orienta hacia el reforzamiento de la atención integral de la salud mental, enfermedades crónicas y cardiovasculares y cáncer, asegurando el tratamiento de forma oportuna, con calidad y accesible a la población a fin de generar una disminución en la carga de la enfermedad. CCSS, Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2033. Dirección de Planificación Institucional.
Evidencia	• La transferencia inmediata a un hospital con capacidad para PCI, es la estrategia recomendada para pacientes con IAMCEST que inicialmente llegan o son trasladados a un hospital sin capacidad para PCI, con un tiempo desde el primer contacto médico de 120 minutos o menos. *83–86 Evidencia: Clase I, Nivel A. Referencia: 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. • La Intervención Coronaria Percutánea primaria es el método recomendado de reperfusión, cuando pueda realizarse oportunamente por operadores experimentados. Evidencia: Clase I, Nivel A. Referencia: 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. • Se recomienda una estrategia de PCI primaria dentro de los plazos indicados. Evidencia: Clase I Nivel A. Referencia: 2017 ESC Guidelines for themanagement of acutemyocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force for the management of acute myocardial infarctionin patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)
Consideraciones de Implementación	Barreras: disponibilidad limitada de centros con laboratorio de hemodinamia y capacidad para la realización del procedimiento. Estrategias: NA
Normativa Técnica	No se identificó normativa técnica institucional vigente que sea aplicable para la implementación de esta intervención, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 14 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes categorías: normas//políticas//leyes//manual/ en el catálogo de publicaciones institucional de la CCSS (https://www.ccss.sa.cr/normativa) y a través del enlace “protocolos, normas y lineamientos” de la Biblioteca Nacional de Salud BINASSS (https://www.binasss.sa.cr/protocolos/protocolos.htm).

Costo / Efectividad	No se identificaron estudios de costo/efectividad relacionados con la realización de angioplastia primaria en pacientes con IAMCEST que puedan ser aplicables a la realidad del país, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 21 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes descriptores en ciencias de la salud (MESH) de la biblioteca nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM): "Cost-Effectiveness Analysis"[Mesh]) AND "Myocardial Reperfusion "[Mesh] (("Análisis de Costo-Efectividad"[Mesh]) Y "Reperfusión Miocárdica"[Mesh]) en las bases de datos biomédicos de la National Library of Medicine NLM, Pub Med, Medscape, BMJ Best Practice, Scielo, Cochrane Library, Clinical Key, Medline, Ovid, Jaypee digital, New England of Medicine. A nivel local no se identificaron investigaciones sobre el tema, en el Hub virtual de economía de la salud "Imputs para mejorar el sistema de salud costarricense" https://www.binasss.sa.cr/economia/experto1.php#MATERIAL
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar la oportunidad de la realización de ICP a través de la medida del tiempo primera puerta-balón.
Pregunta (s) de Evaluación	¿El tiempo primera puerta-balón es de 120 minutos o menos?
Indicadores asociados a la intervención	• Proporción de atenciones con tiempo primera puerta-balón menor o igual a 120 minutos.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Además de las que siguen, también deben considerarse como referencias la Lista Oficial de Medicamentos y cualquier otra normativa emitida por la Dirección de Farmacoepidemiología que aplique. Authors/Task Force Members: Robert A. Byrne *†,(Chairperson) (Ireland), Xavier Rossello ‡(Task Force Co-ordinator) (Spain), J.J. Coughlan ‡ ,(Task Force Co-ordinator) (Ireland), Emanuele Barbato (Italy), Colin Berry (United Kingdom), Alaide Chieffo (Italy), Marc J. Claeys (Belgium), Gheorghe-Andrei Dan (Romania), Marc R. Dweck (United Kingdom), Mary Galbraith (United Kingdom), Martine Gilard (France),Lynne Hinterbuchner (Austria), Ewa A. Jankowska (Poland), Peter Jüni (United Kingdom), Takeshi Kimura (Japan), Vijay Kunadian (United Kingdom), Margret Leosdottir (Sweden), Roberto Lorusso (Netherlands), Roberto F.E. Pedretti (Italy), Angelos G. Rigopoulos (Greece), Maria Rubini Gimenez (Germany), Holger Thiele (Germany), Pascal Vranckx (Belgium), Sven Wassmann (Germany), Nanette Kass Wenger (United States of America), Borja Ibanez *† (Chairperson) (Spain), and ESCScientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary síndromes. Developed by the task force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)(2023) European Heart Journal and European Heart Journal- Acute Cardiovascular Care Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, Bhatt DL, Birtcher KK, Blankstein R,Boyd J, Bullock-Palmer RP, Conejo T, Diercks DB, Gentile F, Greenwood JP, Hess EP, Hollenberg SM, Jaber WA, Jneid H, Joglar JA, Morrow DA, O'Connor RE, Ross MA, Shaw LJ. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR guideline for the evaluation and diagnosis of chest pain: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;144: e368–e454. doi: 10.1161/CIR.0000000000001029 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction.. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction

(2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Aug 23. pii: S0735-1097(18)36941-9. doi: 10.1161/CIR.0000000000000617.

Jneid H, Addison D, Bhatt DL, Fonarow GC, Gokak S, Grady KL, Green LA, Heidenreich PA, Ho PM, Jurgens CY, King ML, Kumbhani DJ, Pancholy S. 2017 AHA/ACC Clinical Performance and Quality Measures for Adults With ST-Elevation and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures. J Am Coll Cardiol. 2017 Oct 17;70(16):2048-2090. doi: 10.1016/j.jacc.2017.06.032.

Schiele F, Gale CP, Bonnefoy E, Capuano F, Claeys MJ, Danchin N, Fox KA, Huber K, Iakobishvili Z, Lettino M, Quinn T, Rubini Gimenez M, Bøtker HE, Swahn E, Timmis A, Tubaro M, Vrints C, Walker D, Zahger D, Zeymer U, Bueno H. Quality indicators for acute myocardial infarction: A position paper of the Acute Cardiovascular Care Association. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 Feb;6(1):34-59. doi: 10.1177/2048872616643053.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 10-03-1.0

Elemento	Descripción	
Código	10-03-1.0	
Nombre	Proporción de casos trasladados por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo primera puerta-balón de 120 minutos o menos.	
Definición conceptual	Población blanco: casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias de un centro de salud con capacidad de aplicar terapia trombolítica i. v., que fueron traslados y se les realizó una intervención coronaria percutánea como procedimiento de reperfusión primaria. Criterios de inclusión: • Clínicamente sugestivo de isquemia cardiaca al llegar. • Infarto agudo de miocardio ST-elevado o equivalente en el primer electrocardiograma realizado en el centro de salud que trasladó y en el centro del procedimiento. • Infarto agudo de miocardio tipo 1. Criterios de exclusión: • Lapso de 12 horas o más desde el inicio/exacerbación de los síntomas hasta el momento más temprano de la atención en el centro del procedimiento. • Paro cardiaco antes del inicio de la intervención coronaria percutánea. • Contraindicación absoluta para el procedimiento. Criterios de excepción: • Demora por atención impostergable de alguna condición del paciente (p. ej., choque cardiogénico), antes del procedimiento. • Demora por sospecha/atención de alguna contraindicación, antes del procedimiento. • Demora para obtener el consentimiento informado que es atribuible al paciente o a sus familiares. • Demora por dificultades procedimentales (p. ej., acceso vascular).	
Variables involucradas en la medición	Primera puerta: momento (hh:mm) más temprano de la atención en el centro que trasladó, registrado en EDUS. Puerta: momento (hh:mm) más temprano de la atención en el centro del procedimiento, registrado en EDUS Balón: momento (hh:mm) de la activación del *dispositivo*, registrado en EDUS, Elektra u otra.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo primera puerta-balón ≤120 minutos}}{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado, con intervención coronaria percutánea}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II, III.
	Componente de la prestación	Subred de ICP primaria.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	Nd/i	
Meta	100% Periodicidad: anual. Unidad de medida: proporción.	
Periodicidad	Anual.	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. • Elektra. • Otra (cuando aplique). Fuentes secundarias:	

	• Reporte del Infarto. Unidades encargadas de las fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.
Clasificación	Proceso.
Presentación de resultados	• Informe analítico PBI 115-Evaluación Infarto (IAM). • Informe de la evaluación.
Comentarios generales	Indicadores complementarios: • Proporción de atenciones con balón. • Proporción de casos trasladados con tiempo primera puerta-puerta de 60 minutos o menos. • Proporción de casos trasladados con tiempo puerta-balón de 60 minutos o menos.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo primera puerta-balón de 120 minutos o menos.	
Indicador Complementario	Proporción de atenciones con balón. (V-1.0)	
Definición conceptual	Población blanco: Casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias de un centro de salud con capacidad de aplicar terapia trombolítica i. v., que fueron traslados y se les realizó una intervención coronaria percutánea como procedimiento de reperfusión primaria. Los criterios de inclusión, exclusión y excepción que le aplican al indicador de evaluación.	
Variables involucradas en la medición	**Balón:** momento (en hh:mm) de la activación del *dispositivo*, registrado en EDUS, Elektra u otro.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea, con balón}}{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Subred de ICP primaria.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	Nd/i	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. • Elektra. • Otra (cuando aplique). Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de la fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	-Informe de Evaluación	
Comentarios generales	Ninguno.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo primera puerta-balón de 120 minutos o menos.	
Indicador Complementario	Proporción de casos trasladados con tiempo primera puerta-puerta de 60 minutos o menos. (V-1.0)	
Definición conceptual	Población blanco: Casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias de un centro de salud con capacidad de aplicar terapia trombolítica i. v., que fueron traslados y se les realizó una intervención coronaria percutánea como procedimiento de reperfusión primaria. Los criterios de inclusión, exclusión y excepción que le aplican al indicador de evaluación.	
Variables involucradas en la medición	Primera puerta: momento (hh:mm) más temprano de la atención en el centro que trasladó, registrado en EDUS. Puerta: momento (hh:mm) más temprano de la atención en el centro del procedimiento, registrado en EDUS	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea, con tiempo primera puerta-puerta de 60 minutos o menos}}{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Subred de ICP primaria.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	Nd/i	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. • Elektra. • Otra (cuando aplique). Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de las fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. Área Estadística en Salud.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	-Informe de Evaluación	
Comentarios generales	Ninguno.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado con tiempo primera puerta-balón de 120 minutos o menos.	
Indicador Complementario	Proporción de casos trasladados con tiempo puerta-balón de 60 minutos o menos. (V-1.0)	
Definición conceptual	Población blanco: Casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más atendidos en Urgencias/Emergencias de un centro de salud con capacidad de aplicar terapia trombolítica i. v., que fueron traslados y se les realizó una intervención coronaria percutánea como procedimiento de reperfusión primaria. Los criterios de inclusión, exclusión y excepción que le aplican al indicador de evaluación.	
Variables involucradas en la medición	Puerta: momento (hh:mm) más temprano de la atención en el centro del procedimiento, registrado en EDUS Balón: momento (hh:mm) de la activación del *dispositivo*, registrado en EDUS, Elektra u otra.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea, con tiempo puerta-balón de 60 minutos o menos}}{\text{Casos trasladados de Urgencias/Emergencias por infarto agudo de miocardio ST-elevado con reperfusión primaria por intervención coronaria percutánea}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Subred de ICP primaria.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio
Línea base	Nd/i	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. • Elektra. • Otra (cuando aplique). Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de las fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. Área Estadística en Salud.	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	-Informe de Evaluación	
Comentarios generales	Ninguno.	

INTERVENCIÓN – ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST-ELEVADO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	• Las enfermedades cardiovasculares (ECV), principalmente la cardiopatía isquémica, son las principales causas de mortalidad y discapacidad en los países de las Américas. Panamerican Health Organization PAHO. World Health Organization Regional Office in Americas/Panamerican Health Organization. Cardiovascular disease burden in the Region of the Americas, 2000-2019 • Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en Costa Rica los fallecimientos por infarto agudo de miocardio aumentaron en un 11% durante el año 2022, contabilizando un total de 2.144 casos ese año y 1.928 en el 2021. Del total de fallecimientos durante el 2022, 869 corresponden a mujeres (40%) y 1.275 a hombres. (60%). Asimismo, el grupo etario más afectado son las personas mayores de 75 años, las cuales registran 1.178 defunciones del total reportado en el 2022. Ministerio de Salud. Gobierno de Costa Rica. Fallecimientos por Infarto aumentaron en un 11% durante el año 2022. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1682-fallecimientos-por-infarto-agudo-de-miocardio- • En términos de legislación, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica no se encontró información relevante asociada a esta intervención en una búsqueda realizada en las fechas 2 y 3 de noviembre de 2023 con los términos: atención/infarto miocardio/intervención coronaria percutánea • El Plan Estratégico Institucional de la CCSS, en la línea estratégica 1-A se orienta hacia el reforzamiento de la atención integral de la salud mental, enfermedades crónicas y cardiovasculares y cáncer, asegurando el tratamiento de forma oportuna, con calidad y accesible a la población a fin de generar una disminución en la carga de la enfermedad. CCSS, Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2033. Dirección de Planificación Institucional.
Evidencia	• Los programas de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria están recomendados en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST). Evidencia: Clase I, Nivel B. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. • Todos los pacientes hospitalizados con un diagnóstico primario de IAMCEST deben derivarse tempranamente a un programa de rehabilitación cardíaca ambulatoria y prevención secundaria. Thomas RJ, Balady G, Banka G, Beckie TM, Chiu J, Gokak S, Ho PM, Keteyian SJ, King M, Lui K, Pack Q, Sanderson BK, Wang TY. 2018 ACC/AHA clinical performance and quality measures for cardiac rehabilitation: a report of the American College ofCardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures. Circ Cardiovasc Qual Outcomes.2018;11: e000037. doi: 10.1161/HCQ.0000000000000037.
Consideraciones de Implementación	Disponibilidad y acceso a Programas de Rehabilitación Cardiovascular
Normativa Técnica	No se identificó normativa técnica institucional vigente que sea aplicable para los efectos de la evaluación, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1 al 14 de noviembre/2023, utilizando los siguientes términos: ccss/normativa/atención/infarto/miocardio en el catálogo de publicaciones institucional de la CCSS (https://www.ccss.sa.cr/normativa) y a través del enlace rápido “protocolos, normas y guías” de la Biblioteca Nacional de Salud BINASSS (https://www.binasss.sa.cr/protocolos/protocolos.htm)
Costo / Efectividad	Se consideran rentables y factibles de implementar en contextos de recursos bajos y medios, incluso si la implementación requiere fortalecer la fuerza laboral de rehabilitación en estos países. No se identificaron estudios de costo/efectividad específicos sobre la rehabilitación cardiovascular/prevención secundaria en pacientes egresados con IAMCEST que puedan ser aplicables a la realidad del país, en una búsqueda realizada en las siguientes fechas: 1° al 21 de noviembre, 2023, utilizando los siguientes descriptores en ciencias de la salud (MESH) de la biblioteca nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM): “Myocardial, Infarction"[Mesh]) AND " Cardiac Rehabilitation/economics"[Mesh] en las bases de datos biomédicos de la National Library of Medicine NLM, Pub Med, Medscape, BMJ Best Practice, Scielo, Cochrane Library, Clinical Key, Medline, Ovid, Jaypee digital, New England of Medicine. A nivel local no se identificaron

	investigaciones sobre el tema, en el Hub virtual de economía de la salud "Imputs para mejorar el sistema de salud costarricense". https://www.binasss.sa.cr/economia/experto1.php#MATERIAL
Objetivo (s) de la Evaluación	Identificar la proporción de casos por IAMCEST egresados, con referencia a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Los casos egresados por IAMCEST elevado son referidos a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria?
Indicadores asociados a la intervención	• Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado egresados con referencia a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Authors/Task Force Members: Robert A. Byrne *†,(Chairperson) (Ireland), Xavier Rossello ‡(Task Force Co-ordinator) (Spain), J.J. Coughlan ‡ ,(Task Force Co-ordinator) (Ireland), Emanuele Barbato (Italy), Colin Berry (United Kingdom), Alaide Chieffo (Italy), Marc J. Claeys (Belgium), Gheorghe-Andrei Dan (Romania), Marc R. Dweck (United Kingdom), Mary Galbraith (United Kingdom), Martine Gilard (France),Lynne Hinterbuchner (Austria), Ewa A. Jankowska (Poland), Peter Jüni (United Kingdom), Takeshi Kimura (Japan), Vijay Kunadian (United Kingdom), Margret Leosdottir (Sweden), Roberto Lorusso (Netherlands), Roberto F.E. Pedretti (Italy), Angelos G. Rigopoulos (Greece), Maria Rubini Gimenez (Germany), Holger Thiele (Germany), Pascal Vranckx (Belgium), Sven Wassmann (Germany), Nanette Kass Wenger (United States of America), Borja Ibanez *† (Chairperson) (Spain), and ESCScientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary síndromes. Developed by the task force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)(2023) European Heart Journal and European Heart Journal- Acute Cardiovascular Care

Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, Bhatt DL, Birtcher KK, Blankstein R,Boyd J, Bullock-Palmer RP, Conejo T, Diercks DB, Gentile F, Greenwood JP, Hess EP, Hollenberg SM, Jaber WA, Jneid H, Joglar JA, Morrow DA, O'Connor RE, Ross MA, Shaw LJ. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR guideline for the evaluation and diagnosis of chest pain: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;144: e368–e454. doi: 10.1161/CIR.0000000000001029

Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction.. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Aug 23. pii: S0735-1097(18)36941-9. doi: 10.1161/CIR.0000000000000617.

Jneid H, Addison D, Bhatt DL, Fonarow GC, Gokak S, Grady KL, Green LA, Heidenreich PA, Ho PM, Jurgens CY, King ML, Kumbhani DJ, Pancholy S. 2017 AHA/ACC Clinical Performance and Quality Measures for Adults With ST-Elevation and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures. J Am Coll Cardiol. 2017 Oct 17;70(16):2048-2090. doi: 10.1016/j.jacc.2017.06.032.

Schiele F, Gale CP, Bonnefoy E, Capuano F, Claeys MJ, Danchin N, Fox KA, Huber K, Iakobishvili Z, Lettino M, Quinn T, Rubini Gimenez M, Bøtker HE, Swahn E, Timmis A, Tubaro M, Vrints C, Walker D, Zahger D, Zeymer U, Bueno H. Quality indicators for acute myocardial infarction: A position paper of the Acute Cardiovascular Care Association. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 Feb;6(1):34-59. doi: 10.1177/2048872616643053 |

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 10-04-1.0

Elemento	Descripción	
Código	10-04-1.0	
Nombre	Proporción de casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado egresados con referencia a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria.	
Definición conceptual	Población blanco: casos por infarto agudo de miocardio ST-elevado de pacientes con 20 años o más, egresados. Criterios de inclusión: - Condición de salida: por indicación médica. Criterios de exclusión: - Pacientes que no aceptan la referencia. - Pacientes que asisten ya a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria. Criterios de excepción: - Pacientes cuya condición de salud, según el criterio del médico tratante, obliga a contraindicar o a posponer la referencia.	
Variables involucradas en la medición	Programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria: serie ordenada de actividades que cumplen en conjunto los *criterios mínimos de homologación* de la Dirección Compra de Servicios de Salud.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Casos egresados por infarto agudo de miocardio ST-elevado, con referencia a un programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria}}{\text{Casos egresados por infarto agudo de miocardio ST-elevado}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	II-III.
	Componente de la prestación	Hospitalización.
	Componente de la atención integral	Tratamiento.
	Temática	Síndrome coronario agudo- Infarto agudo de miocardio.
Línea base	20%	
Meta	100% Periodicidad: anual. Unidad de medida: proporción.	
Periodicidad	Otra: bienal.	
Fuente de información	Fuentes primarias: • EDUS. Fuentes secundarias: • Reporte del Infarto. Unidades encargadas de las fuentes secundarias: • Subárea Servicios Digitales Estratégicos. • Área Estadística en Salud.	
Clasificación	Proceso.	
Presentación de resultados	• Informe analítico PBI 115-Evaluación Infarto (IAM). • Informe de la evaluación.	
Comentarios generales	• Ninguno.	

12-GESTIÓN HOSPITALARIA

INTERVENCIÓN – PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La demanda de servicios de salud aumenta cada vez más en el mundo y aunque los recursos destinados al gasto público en salud también se han incrementado, estos siempre serán limitados (Palmer S, s.f.): las necesidades presupuestarias en salud son ilimitadas, sin embargo, ocurre todo lo contrario con los recursos (Pavarés, 2010). Lograr instituciones eficientes conlleva aunar las disminuciones del gasto, con el análisis sistemático de su relación con los resultados alcanzados y en comparación con unidades de objeto social similar y de acuerdo con las escalas de producción (Dilla, T,2009) Se debe realizar una correcta planificación de las necesidades de cada área y el ajuste del gasto al dinero asignado (Pavarés, 2010) por tanto surge la necesidad de implementar sistemas de monitoreo y evaluación que propicien el logro de los objetivos planteados en forma eficiente, eficaz y en lo posible con un alto grado de efectividad. En ese respecto, la institución presenta debilidades, no logrando, por ejemplo, implementar un sistema de costeo 100% eficiente. Esto obliga a la administración a utilizar indicadores de seguimiento más relacionados con la medición de la productividad (relación entre recursos y resultados, ejemplo cantidad de consultas por hora) que a indicadores de eficiencia propiamente dichos (costo de producción por unidad, ejemplo costo de una consulta en servicios específicos) Pero ¿Cuál es la importancia de lograr optimizar la productividad de los servicios en salud prestados a la población demandante asignada? Existe un impacto positivo sobre el nivel alcanzado en la resolución de problemáticas que afectan el estado de salud de un individuo cuando el abordaje desde los servicios de salud es oportuno y de calidad, resultando que, si se asegura parámetros de productividad adecuados, con utilización eficiente de los recursos, es más probable que se alcance ese abordaje óptimo, merced a una distribución más equitativa y suficiente. La problemática consiste en que no se ha logrado optimizar el uso de esos recursos: “En el informe de la Sugess del 2002, se documenta que el 28,7% de los pacientes en espera son "casos nuevos" y el 71 ,3% son "casos subsecuentes". Podemos deducir que casi 3 de cada 4 citas son originadas por los mismos médicos especialistas al establecer citas de control subsecuentes. La gran incógnita es cuántos de esos pacientes pueden continuar su control médico en el primero o segundo nivel con una contrarreferencia bien orientada, y cuántos efectivamente requieren continuar control y seguimiento en el tercer nivel.” (Díaz Salazar, 2003)
Evidencia	La temática se puede manejar desde múltiples aristas, siendo que todas demuestran la bondad que el manejo eficiente de los recursos hospitalarios produce sobre los procesos y resultados de la atención. Como ejemplo y por tratarse del eje sobre el que gira la razón de ser de los servicios de salud, interesa hacer mención del impacto sobre el resultado clínico que la atención oportuna asociada a una utilización eficiente y ordenada de los servicios conlleva, incluyendo aportes desde la disminución las listas de espera hasta la disponibilidad en tiempo para la atención inmediata de condiciones de urgencias, tenemos que el manejo farmacológico oportuno del infarto agudo de miocardio demuestra una disminución de la mortalidad inmediata del 6,7% al 3,8% y de mortalidad y re infarto a los 6 meses del 13,2% al 7,4%, p<0,01. (Pinar, 2009)

Consideraciones de Implementación	Barreras: Recursos limitados para satisfacer una demanda creciente de atenciones en salud y poca claridad respecto a la forma en que se distribuyen y aprovechan esos recursos. Poca sistematización en el seguimiento y estandarización de la Cultura organizativa y clima de trabajo en las distintas unidades funcionales de prestación del servicio. Existe un gran reservorio de información (EDUS), un porcentaje significativo de la cual no está sistematizada o con insuficientes herramientas para el reporte. Por ello todavía se percibe la necesidad local de satisfacer requerimientos para el seguimiento y monitoreo con herramientas individualizadas que complementan al EDUS, generalmente no difundidas, a veces poco estructuradas, lo que genera multiplicidad de reservorios de información valiosa, no estandarizada, que conlleva a la omisión en el registro de datos oficializados. Estrategias: Inclusión de herramientas para el monitoreo y control de los recursos, determinación de parámetros idóneos de funcionamiento y asignación de responsabilidades enfocadas en la mejora continua de los procesos desarrollados. Descripción y fortalecimiento de las buenas prácticas técnicas, clínicas y de relación intergrupal Implementación de sistemas de seguimiento a la calidad del dato registrado. Reforzamiento del grupo encargado de implementar mejoras al reservorio de información oficial, tanto en el aspecto de registro y seguridad, como el de entrega de reportes para uso individualizado (atención clínica) como gerencial (monitoreo, evaluación y toma de decisiones)
Normativa Técnica	Plan para la atención oportuna de las personas. Comisión técnica institucional de lista de espera. Ficha técnica de indicadores hospitalarios y SOP Dashboard. AES Fichas de indicadores claves de desempeño de servicios de salud. AES.
Costo / Efectividad	Aunque no se identifica un estudio de cuantifique el efecto total de los beneficios costo efectivos de optimizar la productividad de los servicios en forma global, basta con indicar que todos los esfuerzos por aprovechar al máximo la capacidad instalada de la unidad y brindar atención oportuna en tiempo y forma a usuarios con distintas patologías, traerán como resultado que la inversión logística, de aprovisionamiento, infraestructura y recurso humano, apareje mejoras en la efectividad para resolver la condiciones de salud específicas.
Objetivo (s) de la Evaluación	Evaluar la producción de las distintas áreas hospitalarias a fin de identificar brechas entre los logros obtenidos y los parámetros objetivo-institucionales a fin de recomendar acciones generales para la elaboración de planes de correctivos cuando corresponda
Pregunta (s) de Evaluación	¿Son suficientes los recursos asignados a atención de la demanda de servicios de salud? En orden de prioridad, ¿cuáles son los recursos que requieren optimización o implementación? ¿Es eficiente el uso de los limitados recursos destinados a la atención en los servicios de salud prestados por la institución? ¿Se puede mejorar la productividad en los servicios de salud hospitalarios y a disponible?
Indicadores asociados a la intervención	• Índice conjunto de utilización de tiempo en el servicio de emergencias • Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada • Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria • Relación índice de estancia ajustado por el riesgo vs porcentaje de ocupación • Índice de mortalidad ajustado por el riesgo
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social. Plan para la atención oportuna de las personas. Recuperado el 20 noviembre 2023, de https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/651/planatencion.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Díaz Salazar, Jorge. Persistencia de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social: un enfoque estratégico. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc vol.11 n.2 San José Jan. 2003 Dilla T, González de Dios J, Sacristán JA. Evaluación Económica en Medicina (I): Fundamentos y Metodología. Evid Pediatr [Internet]. 2009 [citado 17 Feb 2017]; 5(3): [aprox. 9 p.]. Disponible en:

http://www.aepap.org/EvidPediatr/numeros/vol5/2009_numero_3/2009_vol5_numero3.15.htm
Galva, Roberto. 2002. "Informe de la Superintendencia General de Servicios de Salud sobre listas de espera del año 2002". Caja Costarricense de Seguro Social. San José, Costa Rica.
George Q, Ramón, et al. Aspectos teóricos sobre eficacia, efectividad y eficiencia en los servicios de salud. Revista Información Científica, 96(6), 1153-1163,2017
Palmer S, Torgerson DJ. Definitions of efficiency. BMJ. 1999;318 (7191):1136.
Payarés Comas B, Garnica Morales L. Cultura y economía en el desarrollo social humano. Rev Hum Med [Internet]. 2010 Dic [citado 17 Feb 2017];10(3):[aprox. 12 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex&pid=t1025-02552010000500020&lng=es
Pinar, E; Bardoji, Alfredo. Manejo del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Guías de actuación clínica y el mundo real. Rev Esp Cardiol Supl. 2009; 9:71C-78C

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 12-01-1.0

Elemento	Descripción
Código	12-01-1.0
Nombre	Índice conjunto de rendimiento en el uso del tiempo en el servicio de emergencias
Definición conceptual	Proximidad del logro promedio del centro respecto a los parámetros meta en los tiempos de respuesta para la atención del usuario en el servicio de emergencias. Incluye: total de usuarios que solicitan atención en un servicio de emergencias dentro de la institución. Excluye: NA
Indicadores precursores	Proximidad del tiempo promedio de espera logrado respecto al parámetro objetivo según clasificación del triage (CTAS) (Indicador 1) Proximidad del tiempo promedio de permanencia logrado hasta el alta u hospitalización respecto al mismo tiempo calculado en el conjunto de centros clasificados como tipo similar según clasificación CTAS. (Indicador 2)
Variables involucradas en la medición	Meta según tipo y clasificación CTAS Promedio de tiempo de espera o permanencia de cada uno de los usuarios durante el período evaluado (Anexo 1 y 2) Cantidad de atenciones de urgencias.
Fórmula de cálculo	Paso 1: Proximidad por exceso: $\frac{\text{Logro promedio-Meta}}{\text{Meta}}$ aso 2: Índice conjunto de rendimiento: Proximidad global ajustada**: $\frac{\text{Proximidad del indicador 1 + Proximidad del indicador 2}}{2}$ **Los valores de proximidad negativos se sustituyen por cero. Para cada uno de los rangos en los tiempos definidos.
Desagregación	Nivel de atención: Unidades con servicios de atención de emergencias. Componente de la prestación: Emergencias Componente de la atención integral: Tratamiento Temática: Gestión hospitalaria
Línea base	Parámetros de proximidad para los indicadores 1 y 2 reflejados en el año 2023 con corte al tercer cuatrimestre.

Tipo de centro	CTAS	Prox. promedio Espera CTAS	Prox promedio permanencia	Proximidad Ajustada
Nacionales	AZUL	0,169	0,058	0,113
	ROJO	0,280	0,007	0,143
	AMARILLO	0,000	0,155	0,078
	VERDE	-0,304	0,738	0,369
	BLANCO	-0,610	0,500	0,250
	NO CLASIFICADO	-0,987	0,684	0,342
Regionales	AZUL	1,886	0,274	1,080
	ROJO	0,558	0,271	0,415
	AMARILLO	0,844	0,918	0,881
	VERDE	0,488	2,087	1,288

		BLANCO	-0,256	1,372		0,686
		NO CLASIFICADO	-0,997	-0,768		0,000
	Periféricos 3	AZUL	2,894	0,280		1,587
		ROJO	0,253	0,885		0,569
		AMARILLO	0,552	0,525		0,538
		VERDE	0,238	1,028		0,633
		BLANCO	-0,517	0,424		0,212
		NO CLASIFICADO	-0,996	-0,677		0,000
	Periféricos 1	AZUL	7,889	-0,627		3,944
		ROJO	0,135	-0,496		0,067
		AMARILLO	0,201	-0,350		0,101
		VERDE	-0,272	-0,126		0,000
		BLANCO	-0,588	-0,070		0,000
		NO CLASIFICADO	-0,995	0,268		0,134

Fuente: Cubos EDUS 2023.

Codificación de colores para el resultado de la proximidad:

Verde: Menor o igual a cero

Amarillo: 0>x<=0,25

Rosado: 0.25>x<0,50

Rojo: x>=0,50

Meta	Que los parámetros logrados reflejen una proximidad a la meta igual o menor a cero (Verde). Definición de los parámetros meta: Parámetros meta tiempo de espera: según clasificación CTAS, la primera atención al usuario no debe sobrepasar los siguientes lapsos: Nivel I (Azul CCSS) inmediato (a efectos del cálculo se acepta hasta 5 minutos). Nivel II (Rojo CCSS) máximo 15 minutos Nivel III (Amarillo CCSS) máximo 30 minutos Nivel IV (Verde CCSS) máximo 1 hora Nivel V (Blanco CCSS) máximo 2 horas. Según: Implementation Guidelines for The Canadian Emergency Department Triage & Acuity Scale (CTAS). Versión CTAS 16.DOC Diciembre 16, 1998. Tomado de: https://ctas-phctas.ca/wp-content/uploads/2018/05/ctased16_98.pdf, consultado 24/11/2023. Parámetros meta tiempo de permanencia hasta el egreso u hospitalización: considera el tiempo promedio del conjunto de centros con tipo similar al centro monitorizado según clasificación CTAS del caso. Se aplica en forma individual a cada centro.
Periodicidad	Monitoreo según requerimiento. Evaluación semestral
Fuente de información	Cubo urgencias EDUS
Clasificación	Proceso
Presentación de resultados	Reporte a partir de visor gráfico y tabla de resultados
Comentarios generales	NA

ANEXO 1. TIEMPO DE ESPERA PARA LA PRIMERA ATENCIÓN EN SERVICIO DE EMERGENCIAS DESDE EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Tiempo que transcurre desde la solicitud de atención hasta la primera intervención médica (generalmente el triage)</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Tiempo de espera para la primera atención en servicio de emergencias desde el momento de la solicitud del servicio.
Cantidad de atenciones en el servicio de emergencias segregadas según clasificación CTAS y tipo de centro.
Parámetros meta según tiempo evaluado.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(Hora\ inicio\ atención - Hora\ de\ registro\ en\ el\ servicio)i}{n}$$
Donde:
n: total de casos atendidos en el servicio de urgencias</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Unidades con servicios de atención de emergencias.</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Emergencias</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Tratamiento</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Rendimientos promedio para el año 2023 con corte al tercer trimestre (h:mm:ss)
<table>
<tr><th>Promedio espera</th><th colspan="5">Clasificación CTAS</th></tr>
<tr><th>Tipo de centro</th><th>AZUL</th><th>ROJO</th><th>AMARILLO</th><th>VERDE</th><th>BLANCO</th></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>0:05:51</td><td>0:19:12</td><td>0:30:01</td><td>0:41:45</td><td>0:46:46</td></tr>
<tr><td>Regional</td><td>0:14:26</td><td>0:23:22</td><td>0:55:20</td><td>1:29:18</td><td>1:29:14</td></tr>
<tr><td>Periférico 3</td><td>0:19:28</td><td>0:18:48</td><td>0:46:34</td><td>1:14:17</td><td>0:57:54</td></tr>
<tr><td>Periférico 2</td><td>0:16:54</td><td>0:23:13</td><td>0:48:14</td><td>1:09:32</td><td>0:41:54</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>0:44:27</td><td>0:17:01</td><td>0:36:03</td><td>0:43:40</td><td>0:49:25</td></tr>
<tr><td>AS TIPO 3</td><td>0:05:44</td><td>0:09:11</td><td>0:16:02</td><td>0:35:21</td><td>0:55:09</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Monitoreo según requerimiento.
Evaluación semestral</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Cubos urgencias EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Asociado al indicador principal</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">NA</td></tr>
</table>

ANEXO 2. TIEMPO DE PERMANENCIA REGISTRADO HASTA EL ALTA U HOSPITALIZACIÓN RESPECTO AL MISMO TIEMPO CALCULADO EN EL CONJUNTO DE CENTROS CLASIFICADOS COMO TIPO SIMILAR (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Tiempo que transcurre desde la solicitud de atención en el servicio de emergencias hasta el alta o la hospitalización del usuario</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Tiempo de permanencia hasta el alta o la hospitalización.
Cantidad de atenciones en el servicio de emergencias segregadas según clasificación CTAS y tipo de centro.
Parámetros meta según tiempo evaluado.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(Hora\ inicio\ retiro - Hora\ de\ registro\ en\ el\ servicio)i}{n}$$
Donde:
n: total de casos atendidos en el servicio de urgencias
hora de retiro: corresponde al alta o la hospitalización.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Unidades con servicios de atención de emergencias.</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Emergencias</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Tratamiento</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Rendimientos promedio para el año 2023 con corte al tercer trimestre (h:mm:ss)
<table>
<tr><th></th><th colspan="5">Clasificación CTAS</th></tr>
<tr><th>Tipo de centro</th><th>AZUL</th><th>ROJO</th><th>AMARILLO</th><th>VERDE</th><th>BLANCO</th></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>1:17:23</td><td>23:09:29</td><td>10:20:40</td><td>5:10:02</td><td>3:21:26</td></tr>
<tr><td>Regional</td><td>6:28:09</td><td>5:14:31</td><td>17:10:32</td><td>9:10:48</td><td>5:18:30</td></tr>
<tr><td>Periférico 3</td><td>6:36:21</td><td>19:20:36</td><td>13:39:29</td><td>6:01:43</td><td>3:11:17</td></tr>
<tr><td>Periférico 2</td><td>19:49:01</td><td>18:31:12</td><td>18:04:28</td><td>5:21:55</td><td>3:12:28</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>8:55:09</td><td>11:36:04</td><td>5:49:20</td><td>2:35:54</td><td>2:04:56</td></tr>
<tr><td>AS TIPO 3</td><td>6:57:11</td><td>3:46:12</td><td>2:05:14</td><td>1:38:38</td><td>1:34:58</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Monitoreo según requerimiento.
Evaluación semestral</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Cubos urgencias EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Asociado al indicador principal</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">NA</td></tr>
</table>

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Índice conjunto de utilización del tiempo en el servicio de emergencias	
Indicador Complementario	Tasa de reingreso en 24 horas por cada 100 atenciones al servicio de emergencias/urgencias. (V-1.0)	
Definición conceptual	Cantidad de personas atendidas en el servicio de emergencia/urgencia que reconsultan antes de 24 horas por cada 100 atenciones en el servicio. Incluye: • Reingreso al servicio independiente de la patología. Excluye: • NA	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de pacientes que ingresan al servicio 24 horas • Sumatoria de pacientes emergencia	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum \text{Pacientes que ingresa al servicios}_{24Hrs}}{\sum \text{Pacientes}_{emergencia}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	Emergencias/Urgencias Clasificación Citas Tiempo
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión hospitalaria
Línea base	Los parámetros fueron calculados a través del histórico utilizando el promedio más o menos una desviación estándar. Verde: Baja tasas de reingreso < 1.2 Amarillo: Reingreso promedio 1.2 a 1.75 Rojo: Alto reingreso > 1.75	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema Integrado de Expediente de Salud (SIES)	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud. • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Índice conjunto de utilización del tiempo en el servicio de emergencias	
Indicador Complementario	Tasa de reingreso en 72 horas por cada 100 atenciones al servicio de emergencias/urgencias. (V-1.0)	
Definición conceptual	Cantidad de personas atendidas en el servicio de emergencia/urgencia que reconsultan después de 24 horas y antes de 72 horas por cada 100 atenciones en el servicio. Incluye: • Reingreso al servicio independiente de la patología. Excluye: • NA	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de pacientes que ingresan al servicio 72 horas • Sumatoria de pacientes emergencia	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum \text{Pacientes que ingresa al servicios}_{72Hrs}}{\sum \text{Pacientes}_{emergencia}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	Emergencias/Urgencias Clasificación Citas Tiempo
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión hospitalaria
Línea base	Los parámetros fueron calculados a través del histórico utilizando el promedio más o menos una desviación estándar. Verde: Baja tasas de reingreso < 1.5 Amarillo: Reingreso promedio 1.5 a 2.6 Rojo: Alto reingreso > 2.6	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema Integrado de Expediente de Salud (SIES)	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud. • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 12-02-1.0

Elemento	Descripción	
Código	12-02-1.0	
Nombre	Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada	
Definición conceptual	Indica el grado de cumplimiento en el área de la consulta externa de un volumen aceptable de cupos por hora programada, la conversión de esos cupos en consultas sin sobrepasar las condiciones de tiempo disponible por funcionario y la gestión sostenible del flujo entrada salida de casos. Para este efecto se utiliza el cálculo de la proximidad lograda por el centro respecto a cada uno de los indicadores explorados durante el período evaluado. Incluye: total de usuarios que solicitan o son referidos para la atención por médico especialista en la consulta externa de las distintas especialidades hospitalarias. Excluye: NA	
Indicadores precursores	Indicador 1: Cupo por hora programada (Anexo 1) Indicador 2: Índice de productividad (Anexo 2) Indicador 3: Relación: altas vs. citas nuevas (Anexo 3)	
Variables involucradas en la medición	Cupos asignados Consultas ejecutadas Horas programadas Horas utilizadas Altas otorgadas Citas nuevas asignadas	
Fórmula de cálculo	Para cada uno de los rangos en los tiempos definidos. Paso 1: Según las características del indicador se determina: $\frac{\text{Meta- Logro promedio}}{\text{Meta}}$ b. Proximidad por exceso: $\frac{\text{Logro promedio-Meta}}{\text{Meta}}$ Paso 2: **Índice compuesto de aprovechamiento:** Proximidad global ajustada**: $\frac{\text{Proximidad del indicador 1 + Proximidad del indicador 2+ Proximidad indicador 3}}{3}$ **Los valores de proximidad negativos se sustituyen por cero. a. Proximidad por defecto:	
Desagregación	Nivel de atención	Segundo y tercer nivel ambulatorio de clínicas especializadas u hospitales
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	• Promoción • Prevención • Tratamiento (curación/mantenimiento) • Rehabilitación • - Cuidados paliativos
	Temática	GESTIÓN HOSPITALARIA
Línea base	Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022	

Tipo y centro	Proximidad IP	Proximidad A/C	Proximidad CHP	Proximidad Ajustada CE
Especializado	**0,172**	**0,381**	**0,174**	**0,242**
2802	0,000	0,459	-0,307	0,153
2202	0,204	0,234	0,118	0,185
2105	0,122	0,177	0,391	0,230
2203	0,033	0,422	0,312	0,256
2801	0,077	0,516	0,208	0,267
Nacional	**0,445**	**0,692**	**-0,118**	**0,379**
2101	0,440	0,853	0,211	0,501
2104	0,045	0,639	0,036	0,240
2102	0,026	0,591	0,016	0,211
Periférico 1	**0,000**	**0,649**	**0,052**	**0,234**
2702	0,166	0,669	0,042	0,292
2402	0,036	0,519	0,120	0,225
2703	0,000	0,458	0,065	0,175
2308	0,000	0,427	0,143	0,190
2504	0,093	0,431	0,070	0,198
Periférico 2	**0,045**	**0,638**	**0,176**	**0,286**
2206	0,183	0,688	0,147	0,339
2705	0,004	0,469	0,088	0,187
Periférico 3	0,044	0,403	0,094	0,180
2307	0,040	0,492	0,085	0,206
2503	0,113	0,467	0,033	0,204
2704	0,051	0,352	0,051	0,151
2602	0,135	0,250	0,073	0,153
2207	0,181	0,437	-0,066	0,206
Regional	**0,053**	**0,626**	**0,020**	**0,233**
2701	0,158	0,559	0,068	0,262
2306	0,032	0,557	0,063	0,217
2502	0,026	0,424	0,033	0,161
2401	0,084	0,487	0,017	0,196
2208	0,023	0,583	0,003	0,203
2501	0,123	0,459	0,033	0,205
2205	0,056	0,606	0,006	0,223
2601	0,063	0,557	0,147	0,256
Total	**0,037**	**0,624**	**0,115**	**0,258**

Donde:

IP: Índice de producción

A/C: Relación Altas/Citas primera vez

CHP: Cupos por hora programada

Codificación de colores para el resultado de la proximidad:

Verde: Menor o igual a cero

Amarillo: 0>x<=0,25

Rosado: 0.25>x<0,50

	Rojo: x>=0,50
Meta	Que los parámetros logrados reflejen una proximidad ajustada a la meta igual o menor a cero (Verde). Parámetro de referencia según indicador precursor. Consulta por hora programada: >3,5 Relación Altas vs. Citas nuevas: >=1 Índice de productividad: 0,97<=x<=1,03
Periodicidad	Monitoreo según requerimiento. Evaluación semestral
Fuente de información	Cubo Consulta Externa EDUS
Clasificación	Proceso
Presentación de resultados	Reporte a partir de visor gráfico y tabla de resultados
Comentarios generales	Aclaración: Los parámetros están dirigidos a la descripción de la eficiencia general, de manera tal que el gestor local pueda ubicar su centro dentro de un marco referencial global deseable, visualice la brecha que le separa de esa referencia y explore los requerimientos mínimos para cerrar la brecha. Además, de requerirse de adecuaciones, se debe considerar que existen parámetros no valorados en la ecuación, como es el caso del criterio clínico del prestador y la calidad del servicio, que son particulares a cada entorno y que, aunque pudiesen afectar los logros numéricos, adecuadamente encausados propician mejores resultados en el estado de salud y la satisfacción del usuario. En este tanto, la alerta por desviaciones a la baja en este indicador debe abordarse buscando, más que la obtención de mediciones recomendadas, la optimización de la cultura local de la atención con calidad, la identificación de nudos de conflicto para lograr esa optimización, ajustando recursos, así como la necesaria descripción de las necesidades específicas para posibles mejoras con el tiempo.

ANEXO 1: FICHA INDICADOR CUPO POR HORA PROGRAMADA (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Cantidad promedio de cupos asignados por hora médico especialista programada.
Refleja el volumen de consultas que se espera atender durante un período determinado.
Define si la cantidad de cupos que se programan aseguran un aprovechamiento deseable de la consulta médica especializada programada.
En términos del indicador compuesto, permite identificar si la proximidad del índice de productividad a la meta de uno (1), se acompaña de una programación de cupos mínima deseable.
Es una medida de eficiencia deseable, pero requiere de un análisis a profundidad al aplicar modificaciones, observando si las particularidades de una especialidad demandan una asignación promedio ideal de cupos por hora inferior a la meta general hospitalaria.
Incluye: consultas en el área de consulta externa de los hospitales y clínicas especializadas.
Excluye: NA</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Cupos programados
Horas programadas</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{\sum Cupos\ habilitados}{\sum Horas\ médico\ especialista\ programadas}$$
Meta deseable: 3,5 cupos por hora médico especialista programada</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Promoción
• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>GESTIÓN HOSPITALARIA</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022
<table>
<tr><th>Tipo de centro y UP</th><th>Razón Altas/ Citas Nuevas</th></tr>
<tr><td>Especializado</td><td>0,74</td></tr>
<tr><td>2802</td><td>0,60</td></tr>
<tr><td>2103</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>2203</td><td>1,04</td></tr>
<tr><td>2202</td><td>0,72</td></tr>
<tr><td>2105</td><td>0,62</td></tr>
<tr><td>2305</td><td>0,34</td></tr>
<tr><td>2801</td><td>0,17</td></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>0,43</td></tr>
<tr><td>2104</td><td>0,48</td></tr>
<tr><td>2101</td><td>0,42</td></tr>
<tr><td>2102</td><td>0,40</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>0,60</td></tr>
<tr><td>2702</td><td>0,74</td></tr>
<tr><td>2703</td><td>0,65</td></tr>
<tr><td>2308</td><td>0,70</td></tr>
<tr><td>2504</td><td>0,44</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	2402	0,40
	Periférico 2	**0,64**
	2705	0,71
	2206	0,61
	Periférico 3	**0,65**
	2704	0,80
	2307	0,89
	2503	0,70
	2602	0,45
	2207	0,55
	Regional	**0,54**
	2701	0,68
	2401	0,66
	2502	0,51
	2306	0,64
	2501	0,48
	2601	0,56
	2208	0,44
	2205	0,42
	Total	**0,55**
Periodicidad	Similar al indicador principal	
Fuente de información	Cubos Consulta Externa EDUS	
Clasificación	Proceso	
Presentación de resultados	Ídem. Indicador principal	
Comentarios generales	No aplica	

ANEXO 2: FICHA INDICADOR ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Mide el nivel de aprovechamiento de la cantidad de pacientes vistos por hora de acuerdo con el tiempo disponible.
(Área de estadística en salud. Fichas de Indicadores claves de desempeño de servicios de salud. CCSS, 2023)
Incluye global: atenciones en el área de consulta externa de los hospitales y clínicas especializadas.
Incluye específico: el total de consultas incluye recargos
Excluye específico: el total de cupo excluye recargos</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Cupos programadas
Horas programadas
Consultas realizadas
Horas utilizadas</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{\sum \frac{total\ consultas}{horas\ utilizadas}}{\sum \frac{total\ cupos}{horas\ programadas}}$$
Meta deseable: 0,97<=x<=1,03</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Promoción
• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>GESTIÓN HOSPITALARIA</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022

<table>
<tr><th>Tipo de centro y UP</th><th>índice Productividad</th></tr>
<tr><td>Especializado</td><td>0,80</td></tr>
<tr><td>2802</td><td>0,99</td></tr>
<tr><td>2103</td><td>0,77</td></tr>
<tr><td>2203</td><td>0,85</td></tr>
<tr><td>2202</td><td>0,94</td></tr>
<tr><td>2105</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>2305</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>2801</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>0,93</td></tr>
<tr><td>2104</td><td>0,94</td></tr>
<tr><td>2101</td><td>1,02</td></tr>
<tr><td>2102</td><td>0,81</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>0,94</td></tr>
<tr><td>2702</td><td>1,01</td></tr>
<tr><td>2703</td><td>0,98</td></tr>
<tr><td>2308</td><td>0,88</td></tr>
<tr><td>2504</td><td>1,08</td></tr>
<tr><td>2402</td><td>0,79</td></tr>
<tr><td>Periférico 2</td><td>1,03</td></tr>
<tr><td>2705</td><td>0,93</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	2206	1,07
	Periférico 3	**0,86**
	2704	1,08
	2307	0,84
	2503	0,79
	2602	0,92
	2207	0,82
	Regional	**0,94**
	2701	0,94
	2401	0,89
	2502	1,05
	2306	0,85
	2501	0,92
	2601	0,91
	2208	1,07
	2205	0,89
	Total	**0,91**
Periodicidad	Similar al indicador principal	
Fuente de información	Cubos Consulta Externa EDUS Dashboard AES Indicadores clave del desempeño de servicios de salud	
Clasificación	Proceso	
Presentación de resultados	Ídem. Indicador principal	
Comentarios generales	No aplica	

ANEXO 3: FICHA INDICADOR RAZÓN ALTAS VS. CITAS NUEVAS (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Puntualiza el flujo de casos que se atiende en la consulta externa, señalando si la asignación de cupos y tiempos destinados a la atención son suficientes para permitir una circulación óptima y oportuna de los usuarios.
Incluye atenciones en el área de consulta externa de los hospitales y clínicas especializadas.
Excluye: no aplica</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Altas en especialidad
Cantidad de citas nuevas asignadas en consulta de especialidad</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{Total\ altas}{Total\ citas\ nuevas}$$
Meta deseable: <=1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta Externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Promoción
• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>GESTIÓN HOSPITALARIA</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022
<table>
<tr><th>Tipo de centro y UP</th><th>Razón Altas/ Citas Nuevas</th></tr>
<tr><td>Especializado</td><td>0,62</td></tr>
<tr><td>2802</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>2103</td><td>0,77</td></tr>
<tr><td>2203</td><td>0,82</td></tr>
<tr><td>2202</td><td>0,58</td></tr>
<tr><td>2105</td><td>0,48</td></tr>
<tr><td>2305</td><td>0,31</td></tr>
<tr><td>2801</td><td>0,15</td></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>0,36</td></tr>
<tr><td>2104</td><td>0,41</td></tr>
<tr><td>2101</td><td>0,35</td></tr>
<tr><td>2102</td><td>0,33</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>0,48</td></tr>
<tr><td>2702</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>2703</td><td>0,57</td></tr>
<tr><td>2308</td><td>0,57</td></tr>
<tr><td>2504</td><td>0,36</td></tr>
<tr><td>2402</td><td>0,31</td></tr>
<tr><td>Periférico 2</td><td>0,53</td></tr>
<tr><td>2705</td><td>0,60</td></tr>
<tr><td>2206</td><td>0,51</td></tr>
<tr><td>Periférico 3</td><td>0,53</td></tr>
<tr><td>2704</td><td>0,65</td></tr>
<tr><td>2307</td><td>0,75</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	2503 0,56 2602 0,37 2207 0,44 **Regional 0,44** 2701 0,58 2401 0,51 2502 0,42 2306 0,54 2501 0,39 2601 0,44 2208 0,38 2205 0,34 **Total 0,45**
Periodicidad	Similar al indicador principal
Fuente de información	Cubos Consulta Externa EDUS
Clasificación	Proceso
Presentación de resultados	Ídem. Indicador principal
Comentarios generales	Importante: Es una medida general de eficiencia, un parámetro deseable al que apuntar, no obstante, su análisis requiere ahondar en las determinantes del comportamiento, priorizando siempre en que las estrategias que se apliquen para su puesta en control, cuando corresponda, no afecten la calidad de la atención, ni se oponga a la buena práctica de la clínica médica. La realidad de una especialidad, por sus características y capacidad de respuesta desde la red, podría requerir un aumento en la cantidad de horas especialista disponible antes que una disminución en el número de atenciones caso previo al alta.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td colspan="2">12-02-1.0. Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada.</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td colspan="2">Porcentaje de altas en consultorio médico especialista. (V-1.0)</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Indica el total de altas contabilizadas en las consultas médicas especializadas
Incluye:
• No aplica
Excluye:
• Altas generadas fuera de los servicios de la consulta externa
• Altas en consulta no médicas
• Altas en consultas médicas no especializadas</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Sumatoria de altas otorgadas en la consulta
• Sumatoria de consultas</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{\sum [\text{Altas}]}{\sum [\text{Consultas}]} \times 100$$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Segundo y tercer nivel ambulatorio de clínicas especializadas u hospitales</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>- Promoción
- Prevención
- Tratamiento (curación/mantenimiento)
- Rehabilitación
- Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Logros año 2022.
<table>
<tr><th>Tipo de centro</th><th>%Altas especializadas</th></tr>
<tr><td>Especializado</td><td>10,62%</td></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>6,93%</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>12,14%</td></tr>
<tr><td>Periférico 2</td><td>13,09%</td></tr>
<tr><td>Periférico 3</td><td>12,71%</td></tr>
<tr><td>Regional</td><td>10,49%</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>9,76%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Coincidente con el indicador de evaluación asociado</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Cubos Consulta Externa EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud.
• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud.</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	12-02-1.0. Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada.	
Indicador Complementario	Porcentaje de ausentismo neto. (V-1.0)	
Definición conceptual	Indica el ausentismo debido a la programación de agendas, considerando que ya se han aplicado las estrategias de sustitución y que corresponde a citas que fueron otorgadas. Incluye: • Consultas de recargos. Excluye: • Cupos de recargos.	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de la diferencia entre las citas perdidas y las citas sustituidas • Sumatoria de la diferencia entre el total de citas otorgadas, recargos y citas sustituidas	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum [\text{Citas perdidas} - \text{citas sustituidas}]}{\sum [\text{Total citas otorgadas} - \text{recargos} - \text{citas sustituidas}]} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	Especialidad Tiempo
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión Hospitalaria
Línea base	Los parámetros fueron calculados por el histórico utilizando los cuartiles para identificar el nivel de ausentismo neto. Se estableció los siguientes límites: Verde: Zona Normal < 3 % Amarillo: Riesgo Medio 3-5 % Rojo: Alto Riesgo > 5 %	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema de Identificación, Agenda y Citas (SIAC)	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud. • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada	
Indicador Complementario	Tiempo promedio de espera en días para la cita en especialidades médicas. (V-1.0)	
Definición conceptual	Plazo promedio en días de espera que tiene una persona usuaria de los servicios de salud desde la fecha de registro de la cita de especialidades médicas. Incluye: • Se considera únicamente las citas pendientes que al momento de consultar (fecha actual) y las fechas de registros inferiores a la fecha de actual y las fechas de citas superiores a la fecha de actual. Fecha cita: día en que el usuario será atendido en la especialidad médica Fecha de registro: día en que al usuario se le otorga una cita en la especialidad médica. Fecha actual: se actualiza diariamente de forma automática y corresponde al día anterior. Excluye: • NA.	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de la diferencia entre la fecha de cita y la fecha de registro • Total de citas de especialidades	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum (\text{Fecha de cita} - \text{Fecha de registro})}{\text{Total de citas de especialidades}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	Especialidad Tiempo
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión hospitalaria
Línea base	NA	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema de Identificación, Agenda y Citas (SIAC)	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 04

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada	
Indicador Complementario	Tiempo promedio de espera en días para procedimientos médicos ambulatorios. (V-1.0)	
Definición conceptual	Plazo promedio en días de espera que tiene una persona usuaria de los servicios de salud desde la fecha de registro de la cita de procedimiento. Incluye: • Se considera únicamente las citas pendientes que al momento de consultar (fecha actual) y las fechas de registros inferiores a la fecha de actual y las fechas de citas superiores a la fecha de actual. Fecha cita: día en que el usuario será atendido por el profesional en salud Fecha de registro: día en que al usuario se le otorga una cita en la consulta externa. Fecha actual: se actualiza diariamente de forma automática y corresponde al día anterior. Excluye: • NA	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de la diferencia entre la fecha de cita y la fecha de registro • Total de citas de procedimientos	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum (\text{Fecha de cita} - \text{Fecha de registro})}{\text{Total de citas de procedimientos}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	Procedimiento Tiempo
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión hospitalaria
Línea base	NA	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema de Identificación, Agenda y Citas (SIAC)	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 05

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada	
Indicador Complementario	Tiempo promedio de espera para cirugía ambulatorias. (V-1.0)	
Definición conceptual	El tiempo de espera promedio se calcula para los registros con estado "Pendiente". Incluye: • Para seleccionar las cirugías pendientes se utiliza la variable "Estado_cita" y se selecciona “Pendiente”. Excluye: • NA	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria del plazo de espera de exportación en registros con estado “Pendiente” • Sumatoria de registros con estado “Pendiente”	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum \text{PlazoEsperaExportacion en registros con estado “Pendiente”}}{\sum \text{Registros con estado “Pendiente”}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	Especialidad
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión Hospitalaria
Línea base	Se establecen como parámetros los percentiles 60 y 75 de la distribución de tiempos de espera, que corresponden a 501 días y 789 días respectivamente. Verde: Menos de 501 días Amarillo: De 501 días a menos de 789 días Rojo: 789 días o más	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Módulo Quirúrgico, Sistema Integrado de Atenciones Hospitalarias (SIAH)	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 06

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td colspan="2">12-02-1.0. Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada.</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td colspan="2">Porcentaje de ambulatorización quirúrgica. (V-1.0)</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Cantidad de procedimientos quirúrgicos que se ejecutan bajo la modalidad de recuperación ambulatoria y cumplen con el procedimiento de cirugía mayor ambulatoria
Incluye:
• Egresos operados de tipo quirúrgico registrados en los servicios de cirugía ambulatoria y cirugía vespertina que no se registran en una cama hospitalaria.
Excluye:
• Casos con ingreso vía urgencias.</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Cantidad de egresos operados
• Cantidad de egresos operados para convalecer en forma ambulatoria
• Servicios CMA (6)
• Servicio cirugía vespertina (11)</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\sum [\text{Egresos de los servicios 6 u 11 operados con ingreso electivo}]}{\sum [\text{Egresos operados con ingreso electivo}]} \times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Segundo y tercer nivel ambulatorio de clínicas especializadas u hospitales</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Sala de operaciones ambulatoria</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>- Tratamiento (curación/mantenimiento)
- Rehabilitación
- Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Logros año 2022.
<table>
<tr><th>Tipo centro</th><th>Porcentaje Cirugía Ambulatoria</th></tr>
<tr><td>Especializado</td><td>58,81%</td></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>46,27%</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>66,99%</td></tr>
<tr><td>Periférico 2</td><td>81,08%</td></tr>
<tr><td>Periférico 3</td><td>58,18%</td></tr>
<tr><td>Regional</td><td>55,87%</td></tr>
<tr><td>Global</td><td>54,90%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Coincidente con el indicador de evaluación asociado</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Cubos Consulta Externa EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud.
• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud.</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 07

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	12-02-1.0. Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada.	
Indicador Complementario	Citas en especialidades médicas pendientes (V-1.0)	
Definición conceptual	Pretende cuantificar las citas en especialidades médicas que se encuentran pendientes a partir del día actual Incluye: • No aplica Excluye: • Citas programadas fuera de los servicios de la consulta externa • Citas programadas en consulta no médicas • Citas programadas en consultas médicas no especializadas	
Variables involucradas en la medición	• Fecha de cita: Día en que el usuario será atendido en la especialidad médica. • Fecha de Registro: Día en que al usuario se le otorga una cita en la especialidad médica. • Fecha de Actual: Se actualiza diariamente de forma automática y corresponde al día anterior.	
Fórmula de cálculo	∑ [Citas de especialidad posterior a la fecha de corte] Se considera únicamente las citas pendientes que al momento de consultar (fecha actual) y las fechas de registros inferiores a la fecha de actual y las fechas de citas superiores a la fecha de actual.	
Desagregación	Nivel de atención	Segundo y tercer nivel ambulatorio de clínicas especializadas u hospitales
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	- Promoción - Prevención - Tratamiento (curación/mantenimiento) - Rehabilitación - Cuidados paliativos
	Temática	Gestión hospitalaria
Meta	En consulta.	
Periodicidad	Coincidente con el indicador de evaluación asociado	
Fuente de información	Cubos Citas Salud EDUS	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud. • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 08

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	12-02-1.0. Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada.	
Indicador Complementario	Brecha oferta-demanda en la consulta externa especializada-LE-(V-1.0)	
Definición conceptual	Pretende monitorear brechas de desempeño por especialidad y global con el fin de establecer acciones dirigidas a áreas con mayor demanda (Caja Costarricense de Seguro Social, UTLE, 2018). Corresponde a la diferencia entre la cantidad de ingresos a la lista de espera y los casos resueltos, depurados, en tránsito o derivados en un período de tiempo Se entenderá por brecha a la diferencia de casos que se resuelven mediante alguna vía de resolución en la lista de espera respecto los ingresando a la lista de espera durante el último mes Incluye • No aplica Excluye: • No aplica	
Variables involucradas en la medición	• Ingresos a la lista de espera • Casos: resueltos depurados, en tránsito o derivados en un período de tiempo.	
Fórmula de cálculo	Brecha= ∑ [Resueltos+ derivados+ depurados]- ∑ingresos a la LE	
Desagregación	Nivel de atención	Segundo y tercer nivel ambulatorio de clínicas especializadas u hospitales
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	- Promoción - Prevención - Tratamiento (curación/mantenimiento) - Rehabilitación - Cuidados paliativos
	Temática	Gestión hospitalaria
Meta	En consulta.	
Periodicidad	Coincidente con el indicador de evaluación asociado	
Fuente de información	Módulo Quirúrgico, Sistema Integrado de Atenciones Hospitalarias (SIAH)	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud. • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	
Referencias	Caja Costarricense de Seguro Social, Unidad Técnica de Lista de Espera. *Requerimientos dashboards unidad técnica de listas de espera (cirugía)*. 15 de noviembre de 2018. San José, Costa Rica	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 12-03-1.0

Elemento	Descripción	
Código	12-03-1.0	
Nombre	Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria	
Definición conceptual	Determina si el cumplimiento del centro en los indicadores de estancia promedio, giro cama, porcentaje de ocupación e índice de sustitución de pacientes, alcanza los parámetros aceptables seleccionados para cada medición. (Ver Anexos 1-4) Incluye: usuarios de los servicios de hospitalización de hospitales de segundo y tercer nivel de atención en los servicios de medicina, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría y psiquiatría. Excluye: Egresos que cumplen los parámetros de cirugía ambulatoria y se registran en los correspondientes servicios	
Indicadores precursores	Indicador 1: Estancia promedio (Anexo 1) Indicador 2: Porcentaje de ocupación (Anexo 2) Indicador 3: Giro Cama (Anexo 3) Indicador 4: Índice de sustitución pacientes (Anexo 4)	
Variables involucradas en la medición	Egresos Estancias Camas de dotación normal	
Fórmula de cálculo	Para cada uno de los rangos en los tiempos definidos: Paso 1: Según las características del indicador se determina: a. Proximidad por defecto: $\frac{\text{Meta - Logro promedio}}{\text{Meta}}$ Aplica a los indicadores de porcentaje de ocupación y Giro Cama c. Proximidad por exceso: $\frac{\text{Logro promedio - Meta}}{\text{Meta}}$ Aplica a los indicadores estancia promedio e índice de sustitución. Considera como referencia para determinar el rango de proximidad el centro con el máximo registro según el tipo de centro analizado. Paso 2: <u>Índice compuesto de aprovechamiento:</u> Proximidad global ajustada**: $\frac{\sum_{i=1}^{4} Proximidad\ indicador\ i}{4}$ **Los valores de proximidad negativos se sustituyen por cero.	
Desagregación	Nivel de atención	Segundo y tercer nivel con área de hospedería hospitalaria
	Componente de la prestación	Hospitalización
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento (curación/mantenimiento) • Rehabilitación • - Cuidados paliativos
	Temática	Gestión Hospitalaria
Línea base	Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022	

	Proximidad GC	Proximidad PO	Proximidad EP	Proximidad IS	Proximidad Ajustada
Nacional	**0,163**	**0,009**	**0,529**	**0,277**	**0,245**
2101	-0,025	-0,064	0,109	-0,408	0,027
2102	0,263	0,006	1,000	0,435	0,426
2104	0,228	0,086	0,526	1,000	0,460
Periférico 1	**0,361**	**0,261**	**0,422**	**0,489**	**0,383**
2308	0,226	0,191	0,124	0,287	0,207
2402	0,454	0,422	0,160	0,884	0,480
2504	0,237	0,330	-0,331	0,469	0,259
2702	0,512	0,417	0,523	1,000	0,613
2703	0,419	0,205	1,000	0,462	0,522
2705	0,215	-0,053	0,926	-0,018	0,285
Periférico 3	**0,236**	**0,102**	**0,516**	**0,432**	**0,321**
2206	0,341	0,167	0,776	0,794	0,520
2207	0,172	0,184	-0,040	0,596	0,238
2307	0,260	0,134	0,498	0,560	0,363
2503	0,076	-0,087	0,518	-0,184	0,149
2602	0,265	0,120	0,577	0,524	0,372
2704	0,397	0,191	1,000	1,000	0,647
Regional	**0,203**	**0,051**	**0,463**	**0,487**	**0,301**
2205	0,321	0,096	0,802	1,000	0,555
2208	0,193	-0,002	0,586	0,177	0,239
2306	0,137	0,133	0,011	0,814	0,274
2401	0,117	0,131	-0,039	0,764	0,253
2501	0,338	0,065	1,000	0,840	0,561
2502	0,202	0,019	0,553	0,307	0,270
2601	0,129	0,000	0,360	0,119	0,152
2701	0,142	-0,064	0,582	-0,200	0,181

Donde:
IP: Índice de producción
A/C: Relación Altas/Citas primera vez
CHP: Cupos por hora programada
Hay que considerar que existe una diferencia significativa entre el comportamiento de los dos centros periféricos 2 razón por la cual el centro con UP 2206 se agregó a los periféricos 3 y el UP 2705 a los periféricos 1.

Codificación de colores para el resultado de la proximidad:
Verde: Menor o igual a cero
Amarillo: 0>x<=0,25
Rosado: 0.25>x<0,50
Rojo: x>=0,50

Meta	Que los parámetros logrados reflejen una proximidad ajustada a la meta igual o menor a cero (Verde). Parámetro de referencia según indicador precursor (ver anexos 1-4)
Periodicidad	Monitoreo según requerimiento. Evaluación semestral
Fuente de información	Base de egresos hospitalarios AES
Clasificación	Indicador de Proceso
Presentación de resultados	Reporte a partir de visor gráfico y tabla de resultados
Comentarios generales	NA

ANEXO 1: FICHA INDICADOR ESTANCIA PROMEDIO (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Permite evaluar el grado de aprovechamiento de las camas (sub-utilización o sobre-utilización).
Indirectamente mide la calidad de los servicios prestados, ya que tiempos excesivos de hospitalización pueden reflejar entre otras causas, deficiencias técnicas.
(Ministerio de salud. Ficha Técnicas: indicadores de desempeño y compromisos de mejora. Convenio 2016. Perú. En https://www.saludarequipa.gob.pe/wp/wp-content/uploads/2016/04/Fichas-Hospitales-e-Institutos-75032016.pdf)
Incluye: usuarios de los servicios de hospitalización de hospitales de segundo y tercer nivel de atención en los servicios de medicina, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría y psiquiatría.
Excluye: Egresos que cumplen los parámetros de cirugía ambulatoria y se registran en los correspondientes servicios</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Estancias totales
Egresos totales</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">Fórmula general
$$\frac{Total\ estancias}{Total\ egresos}$$
Meta deseable:
Calcula la estancia promedio deseable suponiendo, además de considerar el tipo de centro, la eliminación de aquellos días que se considera estancia prolongada.
De tal forma, el límite de corte para determinar la estancia prolongada se determina de la siguiente forma
Límite de estancia prologada (LEP): promedio de la estancia real más una desviación estándar (μ+1σ)
Este cálculo divide el total de egresos en dos grupos: egresos que no exceden la estancia promedio (NEEP) y egresos que excede la estancia promedio (SEEP)
La estancia promedio deseable para cada tipo de centro se definiría así:
$$\frac{\sum estancias\ egresos\ NEEP + \sum(egresos\ SEEP * LEP)}{\sum egresos\ totales}$$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Hospitalización</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión Hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022
<table>
<tr><th>Tipo de centro</th><th>Estancia promedio</th></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>7,23</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>4,40</td></tr>
<tr><td>Periférico 3</td><td>5,06</td></tr>
<tr><td>Regional</td><td>5,65</td></tr>
</table>
Nota: se realiza la misma distribución de centros periféricos 2 mencionada en el indicador principal.
Estancia promedio meta aceptable calculada para el período según fórmula: 4,92 días.</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Similar al indicador principal</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Base de egresos hospitalarios EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de Proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Ídem. Indicador principal</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

ANEXO 2: FICHA INDICADOR PORCENTAJE DE OCUPACIÓN (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Relaciona el número de pacientes día (estancias) y el total de días cama disponible.
Similar a lo observado con la estancia promedio permite medir el grado de utilización del recurso cama
Incluye: usuarios de los servicios de hospitalización de hospitales de segundo y tercer nivel de atención en los servicios de medicina, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría y psiquiatría.
Excluye: Egresos que cumplen los parámetros de cirugía ambulatoria y se registran en los correspondientes servicios</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Días paciente (estancias)
Días cama (camas de dotación normal multiplicado por el tiempo de medición)
Tiempo de medición: normalmente 30 o 365 días según se defina en el cálculo</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{\sum \textit{pacientes día (estancias en período)}}{\sum \textit{días cama disponible en el mismo período}}$$
Meta deseable para evaluación o monitoreo ex post: Entre el 85% y el 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Hospitalización</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión Hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022
<table><tr><th>Tipo de centro</th><th>Porcentaje ocupación</th></tr><tr><td>Nacional</td><td>84,23%</td></tr><tr><td>Periférico 1</td><td>62,81%</td></tr><tr><td>Periférico 3</td><td>76,37%</td></tr><tr><td>Regional</td><td>80,65%</td></tr></table>Nota: se realiza la misma distribución de centros periféricos 2 mencionada en el indicador principal.</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Similar al indicador principal</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Base de egresos hospitalarios EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de Proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Ídem. Indicador principal</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">Este indicador requiere una valoración diferenciada en los servicios con dotación normal de camas bajo pues desde un punto de vista práctico se hace difícil mantener ocupaciones altas con poca disponibilidad de campos emergentes.
Se observa además una variación significativa entre centros de más de 50 camas y aquellos cuya dotación es menor a ese número.</td></tr>
</table>

ANEXO 3: FICHA INDICADOR GIRO CAMA (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Cuantifica el número de egresos por cada cama de dotación normal en un período determinado
Incluye: usuarios de los servicios de hospitalización de hospitales de segundo y tercer nivel de atención en los servicios de medicina, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría y psiquiatría.
Excluye: Egresos que cumplen los parámetros de cirugía ambulatoria y se registran en los correspondientes servicios</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Egresos
Camas de dotación normal</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{Egresos\ en\ un\ período}{Dotación\ promedio\ de\ camas\ en\ el\ mismo\ período}$$
Meta deseable: Existe una correlación directa entre este indicador, la estancia promedio y el porcentaje de ocupación.
Dado que se sugiere una estancia promedio aceptable variable, la meta aceptable de este indicador también varía con la EP como sigue:
$$\frac{PO * t}{EP}$$
Donde:
PO: porcentaje de ocupación aceptable 85%
EP: Estancia promedio aceptable según la descripción de la ficha anexo 1
t: tiempo evaluado según se trate de mes (30) o año (365)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Hospitalización</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión Hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022
<table><tr><th>Tipo de centro</th><th>Giro Cama</th></tr><tr><td>Nacional</td><td>42,55</td></tr><tr><td>Periférico 1</td><td>52,13</td></tr><tr><td>Periférico 3</td><td>55,10</td></tr><tr><td>Regional</td><td>52,12</td></tr></table>Nota: se realiza la misma distribución de centros periféricos 2 mencionada en el indicador principal.
Giro cama meta aceptable calculado para el período según fórmula: 63, 03 pacientes/cama-año</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Similar al indicador principal</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Base de egresos hospitalarios EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de Proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Ídem. Indicador principal</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

ANEXO 4: FICHA INDICADOR ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN PACIENTE POR CAMA (V-1.0)

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Indicador indirecto del lapso en días que le toma al servicio o centro, sustituir un paciente, contabilizado desde el momento en que se desocupa la cama hasta que el siguiente usuario se instala en la misma.
También es un indicador de eficiencia en el uso de la cama.
Incluye: usuarios de los servicios de hospitalización de hospitales de segundo y tercer nivel de atención en los servicios de medicina, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría y psiquiatría.
Excluye: Egresos que cumplen los parámetros de cirugía ambulatoria y se registran en los correspondientes servicios</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Estancias
Egresos
Camas de dotación normal</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{(Promedio\ camas\ dotación\ normal * t) - dias\ paciente\ (estancias}{Egresos}$$
Meta deseable:
La literatura supone un valor adecuado entre 0,5 y 1 día.
Sin embargo, existe una correlación directa entre este indicador, la estancia promedio y el porcentaje de ocupación por lo que al sugerirse una estancia promedio aceptable variable, la meta aceptable de este indicador también varía con la EP para cada tipo de centro y servicio como sigue:
$$\left(\frac{EP}{PO}\right) - EP$$
Donde:
PO: porcentaje de ocupación aceptable 85%
EP: Estancia promedio aceptable según la descripción de la ficha del anexo 1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Hospitalización</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión Hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Base calculada a partir de los logros correspondientes al año 2022
<table>
<tr><th>Tipo de centro</th><th>Índice sustitución de paciente por cama</th></tr>
<tr><td>Nacional</td><td>1,35</td></tr>
<tr><td>Periférico 1</td><td>2,60</td></tr>
<tr><td>Periférico 3</td><td>1,57</td></tr>
<tr><td>Regional</td><td>1,36</td></tr>
</table>
Nota: se realiza la misma distribución de centros periféricos 2 mencionada en el indicador principal.
Índice de sustitución de paciente por cama promedio aceptable calculado para el período según fórmula: 0,87 días.</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Similar al indicador principal</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Base de egresos hospitalarios EDUS</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de Proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Ídem. Indicador principal</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
</table>

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	12-03-1.0. Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria	
Indicador Complementario	Porcentaje de reingresos hospitalarios a los 30 días. (V-1.0)	
Definición conceptual	Indica el porcentaje de pacientes que luego del alta vuelven a ser hospitalizados por la misma patología (mismo grupo de la CIE-10) dentro de los 30 días posteriores al alta, respecto al total de egresos en un periodo de tiempo determinado. Incluye: • Se deben identificar los pacientes que reingresan por la misma patología (mismo grupo de la CIE-10) dentro de los 30 días posteriores al egreso. Para esto se debe calcular el tiempo transcurrido entre el egreso y el ingreso, luego verificar que el diagnóstico sea del mismo grupo CIE-10. Excluye: • NA	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de pacientes que reingresan por la misma patología dentro de los 30 días • Sumatoria de egresos hospitalarios	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum \text{Pacientes que reingresan por la misma patología dentro de los 30 días}}{\sum \text{Egresos hospitalarios}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	NA
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión hospitalaria
Línea base	Se establecen como parámetros el percentil 50 y el máximo de la serie histórica, los cuales corresponden a 3,5% y 4,6% respectivamente. Verde: Menos de 3,5% Amarillo: De 3,5% a menos de 4,6% Rojo: 4,6% o más	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema Integrado de Atenciones Hospitalarias (SIAH)	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud. • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 02

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria	
Indicador Complementario	Proporción de egresos hospitalarios con estancia prolongada. (V-1.0)	
Definición conceptual	Una estancia prolongada es cuando la estancia del paciente es mayor a la estancia media más una desviación estándar. Incluye: • NA Excluye: • La estancia de los egresos de los servicios de cirugía mayor ambulatoria y cirugía vespertina	
Variables involucradas en la medición	• Media • Desviación estándar	
Fórmula de cálculo	$$Media = \frac{\Sigma_{i=1}^{n} x_i}{n}$$ $$Desviación\ estándar = \sqrt{\frac{\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$ Al obtener la media y la desviación estándar de la estancia se define una estancia prolongada cuando: *Estancia > (Media + Desviación estándar)*	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	NA
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión Hospitalaria
Línea base	Se establecen como parámetros el percentil 50 y el máximo de la serie histórica, los cuales corresponden a 7% y 15,7% respectivamente. Verde: Menos de 7% Amarillo: De 7% a menos de 15,7% Rojo: 15,7% o más	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema Integrado de Atenciones Hospitalarias (SIAH)	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 03

Elemento	Descripción	
Indicador de Evaluación	12-03-1.0. Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria	
Indicador Complementario	Porcentaje de hospitalizaciones prevenibles. (V-1.0)	
Definición conceptual	Las hospitalizaciones evitables o prevenibles son un grupo de patologías que deberían tratarse en las áreas de salud y que no deberían generar una hospitalización. Incluye: • Los diagnósticos que se deberían resolver en el primer de atención están clasificados en 20 grupos: Inmunización, Condiciones Evitables, Infecciones Gastrointestinales y Complicaciones, Anemia, Deficiencias Nutricionales, Infección de Oídos, Nariz y Garganta, Neumonía Bacteriana, Asma, Enfermedades de las Vías Aéreas Inferiores, Hipertensión, Angina de pecho, Insuficiencia Cardiaca, Enfermedad Cerebrovascular, Diabetes Mellitus, Epilepsias, Infección en el Riñón y su Vías Urinarias, Infección de la Piel y Tejido Subcutáneo, Enfermedad Inflamatoria de Órganos Pélvicos Femeninos, Úlcera Gastrointestinal y Enfermedades relacionadas al Embarazo y Parto. Excluye: • NA	
Variables involucradas en la medición	• Sumatoria de egresos con diagnósticos que se deberían resolver en el primer nivel de atención • Sumatoria de egresos	
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum \text{Egresos con diagnósticos que se deberían resolver en el primer nivel de atención}}{\sum \text{Egresos}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Establecimiento de salud. Red Integrada de Servicios de Salud (RIPSS)
	Componente de la prestación	NA
	Componente de la atención integral	NA
	Temática	Gestión Hospitalaria
Línea base	Se establecen como parámetros el percentil 50 y el máximo de la serie histórica, los cuales corresponden a 8,6% y 12,22% respectivamente. Verde: Menos de 8,6% Amarillo: De 8,6% a menos de 12,22% Rojo: 12,22% o más	
Periodicidad	Del periodo y anual.	
Fuente de información	Sistema Integrado de Atenciones Hospitalarias (SIAH)	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud. • Dashboard: Indicadores claves del desempeño AES.	
Comentarios generales	Elaborado a partir de propuesta del Area de Estadísticas en Salud en “Fichas de Indicadores Claves de Desempeño de Servicios de Salud, año 2023”	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 04

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td colspan="2">12-03-1.0. Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td colspan="2">Aprovechamiento del tiempo de quirófano disponible. (V-1.0)</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Determina cual es la proporción del tiempo de quirófano disponible durante el cual se registra tiempo de anestesia.
Incluye:
• Cirugías donde se registre información en la hoja de anestesia
Excluye:
• Pacientes cuyo procedimiento no requiere apoyo de anestesiólogo, pacientes operados en tiempo extraordinario o en quirófanos cerrados (inhabilitados, ausencia de recurso humano o equipo, salas de emergencias).</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Tiempo anestesia: inicia desde el primer registro en la hoja de anestesia (o su equivalente) por parte del médico anestesiólogo hasta el registro de la entrega del paciente al salón de recuperación.
• Tiempo ordinario: total de horas asignadas al trabajo en el bloque quirúrgico en jornada diurna, de lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm.
• Quirófano (sala de operaciones): Local conveniente y acondicionado para hacer intervenciones quirúrgicas bajo anestesia. o Fuente: EDUS
• Tiempo de inicio de anestesia: Registro de la hora exacta en el que inicia la monitorización de signos del paciente por parte del anestesiólogo. o Fuente: EDUS
• Tiempo de finalización de anestesia: o Definición operativa variable: Registro de la hora exacta que es entregado el paciente en la sala de recuperación. o Fuente: EDUS
• Fecha: Día en que se realiza el procedimiento médico. o Fuente: EDUS</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$$\frac{\text{Sumatoria del tiempo de anestesia utilizado por quirófano en tiempo ordinario}}{\text{Total de días hábiles que se programó cirugías electivas mayores con soporte anestésico}}$$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Segundo y tercer nivel hospitalario</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Hospitalización – Sala de operaciones</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Tratamiento (curación/mantenimiento)
Rehabilitación
Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2"><table><tr><th>Centro</th><th>Tiempo de anestesia por día utilizado</th></tr><tr><td>2101</td><td>5,73</td></tr><tr><td>2102</td><td>5,71</td></tr><tr><td>2103</td><td>5,92</td></tr><tr><td>2104</td><td>6,29</td></tr><tr><td>2105</td><td>4,73</td></tr><tr><td>2202</td><td>3,58</td></tr><tr><td>2203</td><td>5,64</td></tr><tr><td>2205</td><td>6,09</td></tr><tr><td>2206</td><td>5,07</td></tr><tr><td>2207</td><td>4,20</td></tr><tr><td>2208</td><td>5,28</td></tr></table></td></tr>
</table>

	2306 4,99 2307 5,93 2308 4,79 2401 6,33 2402 3,10 2501 5,55 2502 5,75 2503 5,34 2504 5,23 2601 3,93 2602 5,59 2701 6,46 2702 5,59 2703 6,07 2704 5,26 2705 4,97 2802 1,45 Global 5,57 Según egreso registrado durante el año 2022
Periodicidad	Coincidente con el indicador de evaluación asociado
Fuente de información	Registro de cirugías realizadas. AES
Clasificación	Indicador de proceso
Presentación de resultados	• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud. • Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud.
Comentarios generales	No aplica

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 12-04-1.0

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Código</td><td colspan="2">12-04-1.0</td></tr>
<tr><td>Nombre</td><td colspan="2">Índice de estancia ajustado por el riesgo vs porcentaje de ocupación</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Refleja la eficiencia en la gestión de la cama hospitalaria contrastando dos indicadores del uso de la estancia, mediante la proximidad a parámetros aceptables de rendimiento.
Incluye: usuarios de los servicios de hospitalización de hospitales de segundo y tercer nivel de atención en los servicios de medicina, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría y psiquiatría.
Excluye: Egresos que cumplen los parámetros de cirugía ambulatoria y se registran en los correspondientes servicios</td></tr>
<tr><td>Indicadores precursores</td><td colspan="2">Indicador 1: Índice de estancia ajustada por el riesgo (IEAC)
Indicador 2: Porcentaje de ocupación (PO)</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Ver anexo de esta ficha (IEAC) y anexo 2 de la ficha 12-03-1.0 (PO)</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">Paso 1:
Para cada uno de los rangos en los tiempos definidos.
Proximidad:
$$\frac{\text{Logro promedio-Meta}}{\text{Meta}}$$
Paso 2:
<u>Índice conjunto de rendimiento:</u>
Proximidad global ajustada**:
$$\frac{\text{Proximidad del indicador 1 + Proximidad del indicador 2}}{2}$$
**Los valores de proximidad negativos se sustituyen por cero.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Segundo y tercer nivel con área de hospedería hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Hospitalización</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>• Prevención
• Tratamiento (curación/mantenimiento)
• Rehabilitación
• - Cuidados paliativos</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Gestión Hospitalaria</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">La metodología de cálculo del IEAC está ajustada para la segregación por centro y servicio por cuanto arroja tablas de estado excesivamente grandes para efectos de esta explicación.
Por ello solo se incorpora a manera de ejemplo los valores calculados para el servicio de cirugía en hospitales nacionales, regionales y periféricos 3 durante el año 2022.
<table><tr><th></th><th>Proximidad IEAC</th><th>Proximidad PO</th><th>Proximidad ajustada</th></tr><tr><td>2101</td><td>0,030</td><td>-0,019</td><td>0,015</td></tr><tr><td>2104</td><td>0,176</td><td>-0,146</td><td>0,088</td></tr><tr><td>2102</td><td>0,016</td><td>-0,053</td><td>0,008</td></tr></table></td></tr>
</table>

	2401	0,217	-0,089	0,109
	2306	0,246	0,162	0,204
	2501	0,088	0,073	0,081
	2701	0,081	-0,234	0,040
	2502	0,036	-0,063	0,018
	2205	0,184	-0,081	0,092
	2601	0,048	-0,137	0,024
	2503	0,049	-0,098	0,024
	2207	0,308	-0,093	0,154
	2208	0,087	-0,186	0,044
	2602	0,001	0,028	0,014
	2307	0,327	-0,020	0,164

Codificación de colores para el resultado de la proximidad:
Verde: Menor o igual a cero
Amarillo: 0>x<=0,25
Rosado: 0.25>x<0,50
Rojo: x>=0,50

Meta	La revisión permite la agrupación de las unidades funcionales en tres grupos: 1. Buena gestión: El IEAC = 1 y el PO se debe ubicar entre 85 % y 100 %. 2. Buena gestión de la ocupación con requerimiento de análisis del IEAC: PO se debe ubicar entre 85 % y 100 % y el IEAC superior o inferior a 1. 3. Buena gestión de las estancias con requerimiento de análisis de las camas entre servicios: el IEAC = 1 y el PO menor a 85 % o superior al 100 % Según esa propuesta, el requerimiento meta para cada unidad funcional es alcanzar el grupo 1, equivalente a una proximidad ajustada de cero o codificación de color verde.
Periodicidad	Monitoreo según requerimiento. Evaluación semestral
Fuente de información	Base de egresos hospitalarios AES
Clasificación	Indicador de Proceso
Presentación de resultados	Reporte a partir de visor gráfico y tabla de resultados
Comentarios generales	NA

ANEXO. ÍNDICE DE ESTANCIAS AJUSTADO POR RIESGO (IEAC) (V-1.0)

Elemento	Descripción	
Definición conceptual	Intervalo de confianza que aproxima el uso de la estancia de una unidad funcional (centro o servicio) respecto a la norma estandarizada mediante regresión binomial. Al estandarizar cada estancia dentro de las unidades funcionales evaluadas según las condiciones (variables independientes) seleccionadas, se puede comparar los rendimientos entre unidades a partir de una referencia común construida con aporte del comportamiento de todas las realidades.	
Variables involucradas en la medición	Edad, sexo, vía de ingreso al hospital, estado civil, condición de salida del paciente, grupo de diagnóstico CIE-10 consignado en el egreso hospitalario institucional, grupo de comorbilidad representado por el Índice de Charlson (Quan et al, 2011).	
Fórmula de cálculo	Paso 1: Determinación de estancias esperadas mediante regresión binomial negativa con variable dependiente en la estancia e independientes en el listado inmediato anterior. Paso 2: Determinación la razón entre la estancia observada y la estancia esperada. Con ello se determina si la gestión de la estancia se considera adecuada (IEAC=1) o si requiere análisis (IEAC<>1) Paso 3: Cálculo del intervalo de confianza. Intervalo de confianza del IEAC por el método de Byar (Public healt england, 2018, Newcombe, R. ,1998.) Límite superior: $= (observadas + 1) * (1 - \frac{1}{9*(observadas+1)} - \frac{Z\alpha/2}{\sqrt[3]{(observadas+1)}})^3$ Límite inferior $= observadas * (1 - \frac{1}{9*observadas} - \frac{Z\alpha/2}{\sqrt[3]{(observadas)}})^3$ Donde: Observadas: son las estancias observadas $Z\ \alpha/2$: es el valor de la Distribución Normal Estándar para un nivel de significancia dado. Para un intervalo de confianza del 95 %, α = 0.05 y $Z\ \alpha/2$ = 1.96	
Desagregación	Nivel de atención	II y III nivel hospitalario y clínicas especializadas
	Componente de la prestación	Hospitalización
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento (curación/mantenimiento) • Rehabilitación • - Cuidados paliativos
	Temática	No aplica
Línea base	La metodología de cálculo del IEAC está ajustada para la segregación por centro y servicio por cuanto arroja tablas de estado excesivamente grandes para efectos de esta explicación.	
Periodicidad	Monitoreo según requerimiento. Evaluación semestral	
Fuente de información	Cubos urgencias EDUS	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	Asociado al indicador principal	

Comentarios generales	El análisis del IEAC debe enfocarse en determinar si el uso de más o menos estancias en egresos con características similares se explica únicamente por variaciones controlables de la cultura en el centro o si existen variables no consideradas como la complejidad diferencial, epidemiología, demografía, acceso, disponibilidad de recursos locales, etc. que influyan significativamente en la desviación cuando se presente.
Referencias	Newcombe, R. . *Two-sided confidence intervals form the single proportion: comparison of seven methods.* 1998. Sat Med, 857-72. Public health Data Science, *Confidence intervals : Technical Guide.* Version : 25 mayo 2018. Pag.6 Quan, H., Li, B., Couris, C., & Fushimi, K. (2011). *Updating and validating the Charlson Comorbility index and score for risk adjustment in hospital discharge abstracts using from 6 countries.* American journal of epidemilogy, 173(6), 676-682.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE EVALUACIÓN 12-05-1.0

Elemento	Descripción
Código	12-05-1.0
Nombre	Índice de mortalidad ajustado por el riesgo (IMHAR)
Definición conceptual	Este indicador permite al gestor observar cuanto se ajusta o se desvía el perfil real de mortalidad del centro respecto a una proyección estandarizada de decesos que correspondería a su producto si se comportarse al 100% como una extensión normal del tipo de centro. Valores del IMHAR significativamente superiores o inferiores a la tasa institucional denotan una fuerte influencia de variables locales que por su particularidad es imposible se consideran en la regresión para la determinación de las muertes esperadas en el clúster hospitalario total. Las diferencias respecto al sistema constituyen una alerta para que desde la administración se identifique esas variables locales y se determine la posibilidad y conveniencia de influir sobre estas en beneficio del usuario. Incluye: No aplica Excluye: Pacientes en cuidados paliativos: código CIE-10 de Z51.5 en cualquiera de los diagnósticos, principal y secundario. • Egresos que registren valores perdidos de las variables: edad, sexo, categoría de ingreso, estancias, códigos diagnósticos primarios y secundarios • Egresos que se agrupan en edades con mortalidades con riesgos relativos de muerte significativamente elevado
Variables involucradas en la medición	Defunciones observadas: las muertes registradas en el hospital en un período determinado. Fuente: Área de Estadística en Salud (AES) y Expediente Digital Único en Salud (EDUS) Defunciones esperadas: se obtienen de la suma de las probabilidades de defunción de cada episodio individual (egreso). Donde la probabilidad individual de defunción (un valor entre 0 –sin riesgo de defunción– y 1 –máximo riesgo de defunción–) se calcula mediante un modelo de regresión logística binaria. Fuente: AES y EDUS. Tasa institucional: Tasa bruta de mortalidad intrahospitalaria del conjunto de hospitales. Se obtienen dividiendo el total de muertes intrahospitalarias entre el total de egresos en el año analizado, multiplicado por 100. Fuente: AES y EDUS. Índice de Charlson: es una puntuación de comorbilidad general que se ha demostrado está altamente relacionada con la mortalidad y ha sido ampliamente utilizada en la investigación clínica y de gestión. Para este indicador se utiliza el Índice de Charlson, según la metodología actualizada de Quan et al (2011). Se calcula para cada egreso de los hospitales generales de la CCSS según la presencia de condiciones y pesos establecidos para el índice. Fuente: AES y EDUS.
Fórmula de cálculo	La metodología empleada para estimar el índice de mortalidad intrahospitalaria tiene como base la utilizada por el Instituto Canadiense para la Información en Salud (CIHI por sus siglas en inglés) para la evaluación de la mortalidad intrahospitalaria de ese país (CIHI, 2012). En la estimación del IMHAR intervienen los siguientes procesos: Paso 1 Seleccionar los egresos que concentran el 80 % de las muertes hospitalarias en el período de estudio. Paso 2: Determinación de las muertes esperadas en el grupo seleccionado en el paso 1 mediante regresión logística con variable dependiente en las muertes e independientes como sigue: edad, sexo, vía de ingreso al hospital, estado civil, condición de salida del paciente, grupo de diagnóstico CIE-10 consignado en el egreso hospitalario institucional, grupo de comorbilidad representado por el Índice de Charlson (Quan et al, 2011). Paso 3: Determinación la razón entre la muerte observada y la muerte esperada. Paso 4:

Cálculo del intervalo de confianza.
Intervalo de confianza del IMHAR por el método de Byar (Public healt england, 2018, Newcombe, R. ,1998.)

Límite superior:

$$= (observadas + 1) * (1 - \frac{1}{9*(observadas+1)} - \frac{Z\alpha/2}{\sqrt[3]{(observadas+1)}})^3$$

Límite inferior

$$= observadas * (1 - \frac{1}{9*observadas} - \frac{Z\alpha/2}{\sqrt[3]{(observadas)}})^3$$

Donde:
Observadas: son las estancias observadas
$Z\ \alpha/2$: es el valor de la Distribución Normal Estándar para un nivel de significancia dado. Para un intervalo de confianza del 95 %, α = 0.05 y $Z\ \alpha/2$ = 1.96
Con ello se determina si los límites de confianza que acompañan al IMHAR reflejan una mortalidad congruente con la norma (IMHAR=1) o si requiere análisis por desviarse de ella (IMHAR<>1)
Paso 5
Determinar la proximidad del límite más cercano a la norma.

Proximidad:

$$\frac{\text{Límite más cercano-Norma}}{\text{Norma}}$$

Desagregación	Nivel de atención	Segundo y tercer nivel con área de hospedería hospitalaria
	Componente de la prestación	Hospitalización
	Componente de la atención integral	- Prevención - Tratamiento (curación/mantenimiento) - Rehabilitación - Cuidados paliativos
	Temática	Mortalidad

Línea base

Determinada para el año 2022.

centro	Observaciones válidas	Muertes reales	Muertes esperadas (IMHAR)	Límite superior	Real/ Esperado	Límite inferior	Proximidad a IMHAR	Resultado
2101	9547	929	1175,4	0,84	0,79	0,74	0,260	Inferior a modelo
2104	8027	737	639,3	1,24	1,15	1,07	0,239	Excede modelo
2102	8302	1200	1010,3	1,26	1,19	1,12	0,257	Excede modelo
2208	3922	393	398,6	1,09	0,99	0,89	0,000	Ajustado a modelo
2401	3249	215	266,7	0,92	0,81	0,70	0,298	Inferior a modelo
2306	4439	284	328,7	0,97	0,86	0,77	0,234	Inferior a modelo
2501	2444	237	218,1	1,23	1,09	0,95	0,000	Excede modelo
2701	3581	394	415,4	1,05	0,95	0,86	0,000	Ajustado a modelo

	2502	3026	323	273,1	1,32	1,18	1,06	0,319	Excede modelo
	2205	3303	246	258,1	1,08	0,95	0,84	0,000	Ajustado a modelo
	2601	2014	233	166,2	1,59	1,40	1,23	0,594	Excede modelo
	2503	1428	173	153,8	1,31	1,12	0,96	0,000	Ajustado a modelo
	2207	895	93	109,0	1,05	0,85	0,69	0,000	Ajustado a modelo
	2704	562	57	59,8	1,23	0,95	0,72	0,000	Ajustado a modelo
	2602	1110	158	116,1	1,59	1,36	1,16	0,591	Excede modelo
	2307	993	102	112,8	1,10	0,90	0,74	0,000	Ajustado a modelo
	2206	1045	96	127,5	0,92	0,75	0,61	0,390	Inferior a modelo
	2705	189	10	18,9	0,97	0,53	0,25	0,747	Inferior a modelo
	2504	105	17	13,8	1,97	1,23	0,72	0,000	Ajustado a modelo
	2702	271	29	24,0	1,74	1,21	0,81	0,000	Ajustado a modelo
	2402	79	7	5,2	2,79	1,36	0,54	0,000	Ajustado a modelo
	2206	382	45	39,5	1,52	1,14	0,83	0,000	Ajustado a modelo
	2703	325	24	27,6	1,29	0,87	0,56	0,000	Ajustado a modelo
	Codificación de colores para el resultado de la proximidad: Verde: Menor o igual a cero Amarillo: 0>x<=0,25 Rosado: 0.25>x<0,50 Rojo: x>=0,50								
Meta	Se establecen tres categorías para la interpretación del IMHAR: 1- Mortalidad sobre la predicción del modelo: si el límite inferior del intervalo de confianza del IMHAR es superior a la tasa institucional. 2- Mortalidad bajo la predicción del modelo: si el límite superior del intervalo de confianza del IMHAR es inferior a la tasa institucional. 3- Mortalidad coincide con la predicción del modelo: si la tasa institucional está contenida dentro del intervalo de confianza del IMHAR Según esa propuesta, el requerimiento meta para cada unidad funcional es alcanzar a agruparse dentro de la categoría 3, equivalente a una proximidad ajustada de cero o codificación de color verde.								
Periodicidad	Monitoreo según requerimiento. Evaluación semestral								
Fuente de información	Base de egresos hospitalarios AES								
Clasificación	Proceso								

Presentación de resultados	Reporte a partir de visor gráfico y tabla de resultados
Comentarios generales	Se debe recordar que el IMHAR es un intento de presentar comportamientos estandarizados a partir de un modelo generado con un número limitado de variables explicativas. Por tanto, el resultado no puede de ninguna forma utilizarse con un enfoque punitivo, por el contrario, la pretensión es que sirva para el desarrollo local de estrategias de mejora. En su análisis el IMHAR debe enfocarse en determinar si las desviaciones respecto al perfil de la norma estandarizada se explican únicamente por variaciones controlables de la cultura en el centro o si existen determinantes no consideradas como la complejidad diferencial, epidemiología, demografía, acceso, disponibilidad de recursos locales, etc. que influyan significativamente en el comportamiento
Referencias	Canadian Institute for Health Information . *Hospital Standardized Mortality Ratio. Technical notes 2012*. Disponible en: https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/hsmr-technotes_en_0.pdf (última revisión 12-06-2013). Newcombe, R. . *Two-sided confidence intervals form the single proportion: comparison of seven methods.* 1998. Sat Med, 857-72. Public health Data Science, *Confidence intervals : Technical Guide.* Version : 25 mayo 2018. Pag.6 Quan, H., Li, B., Couris, C., & Fushimi, K. (2011). *Updating and validating the Charlson Comorbility index and score for risk adjustment in hospital discharge abstracts using from 6 countries.* American journal of epidemilogy, 173(6), 676-682.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR COMPLEMENTARIO 01

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Indicador de Evaluación</td><td colspan="2">12-05-1.0. Índice de mortalidad ajustado por el riesgo</td></tr>
<tr><td>Indicador Complementario</td><td colspan="2">Tasa de Mortalidad. (V-1.0)</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td colspan="2">Cuantifica la cantidad de egresos fallecidos en los centros hospitalarios.
Según se requiera la cuantificación se puede realizar especificando grupos de edad, patologías trazadoras, servicios o especialidades
Incluye:
• Todos los egresos independientemente el área de ingreso.
Excluye:
• No aplica</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Muertes hospitalarias registradas en el período: Egresos cuya condición de salida se codifica como 5, 6 ó 7: Fallecido con autopsia, fallecido sin autopsia, fallecido transferido a forense respectivamente.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\text{Muertes hospitalarias registradas durante el periodo evaluado}}{\text{Egresos registrados durante el periodo evaluado}} * 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Segundo y tercer nivel hospitalario</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Hospitalización</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Mortalidad general</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2"><table><tr><th>Tipo de centro</th><th>Tasa Mortalidad Bruta X 1.000 egresos</th></tr><tr><td>Especializado</td><td>1,04</td></tr><tr><td>Nacional</td><td>6,82</td></tr><tr><td>Periférico 1</td><td>1,61</td></tr><tr><td>Periférico 3</td><td>1,20</td></tr><tr><td>Regional</td><td>2,06</td></tr><tr><td>Global</td><td>3,09</td></tr></table>Según egreso registrado durante el año 2022</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Coincidente con el indicador de evaluación asociado</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Base de egresos hospitalarios AES</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">• Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud.
• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios del establecimiento de salud.</td></tr>
<tr><td>Comentarios generales</td><td colspan="2">Los resultados sirven como alerta para que la administración activa identifique las determinantes del comportamiento y, en lo posible, elabore estrategias correctivas. Si se considera necesario, el estadístico se puede medir por servicio, especialidad o programa según lo considere la administración local.</td></tr>
</table>